Optimal Untuk Negeri

optimal

*Buku Ajar*

# PEMERIKSAAN ANTENATAL TERPADU

## *ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, DAN INTERPRETASI TEMUAN*

Baiq Iin Rumintang • Husnul Khatimah • Hasanalita • Nurulicha • Yanti

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



# BUKU AJAR
# PEMERIKSAAN ANTENATAL TERPADU: ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, DAN INTERPRETASI TEMUAN

**Penulis:**
Baiq Iin Rumintang, S.ST., M. Keb.
Husnul Khatimah, S.ST., M.K.M.
Bdn. Hasanalita, S.SiT, M.Keb.
Nurulicha, S.ST., M.Keb.
Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb.

**Editor:**
Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Optimal Untuk Negeri

**BUKU AJAR PEMERIKSAAN ANTENATAL TERPADU: ANAMNESIS, PEMERIKSAAN FISIK, DAN INTERPRETASI TEMUAN**

**Penulis:**
Baiq Iin Rumintang, S.ST., M. Keb.
Husnul Khatimah, S.ST., M.K.M.
Bdn. Hasanalita, S.SiT, M.Keb.
Nurulicha, S.ST., M.Keb.
Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb.

**Editor:** Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

**Desain Sampul:** Ivan Zumarano
**Penata Letak:** Muhamad Rizki Alamsyah

**ISBN:** 978-634-7756-92-3

**Cetakan Pertama :** September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang
**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**
**Copyright © 2026**
**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

# PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga Buku Ajar Pemeriksaan Antenatal Terpadu: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Temuan ini dapat disusun sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pemeriksaan antenatal terpadu merupakan bagian penting dalam pelayanan kebidanan karena bertujuan untuk memantau kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan, mendeteksi secara dini adanya faktor risiko atau komplikasi, serta memberikan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan ibu hamil. Melalui pemeriksaan antenatal yang sistematis, bidan dapat mengenali kondisi normal maupun tidak normal sejak awal, sehingga upaya pencegahan, penatalaksanaan, edukasi, konseling, dan rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami tahapan pemeriksaan antenatal secara menyeluruh, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan obstetri, pemeriksaan penunjang sederhana, hingga interpretasi temuan yang diperoleh. Anamnesis menjadi dasar penting dalam menggali riwayat kesehatan ibu, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat penyakit, pola makan, aktivitas, keluhan yang dirasakan, serta faktor sosial dan psikologis yang dapat memengaruhi kehamilan. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai kondisi umum ibu, status gizi, tanda vital, serta kondisi obstetri yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan janin.

Selain keterampilan melakukan pemeriksaan, kemampuan menginterpretasikan hasil temuan juga menjadi kompetensi penting bagi calon bidan. Setiap data yang diperoleh dari anamnesis dan pemeriksaan fisik perlu dianalisis secara tepat agar dapat menjadi dasar dalam menentukan masalah, merumuskan kebutuhan ibu hamil, memberikan asuhan kebidanan, serta mengambil keputusan klinis. Dengan demikian, pemeriksaan antenatal tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi merupakan proses pengkajian klinis yang membutuhkan ketelitian, kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab profesional.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelayanan antenatal yang berkualitas, terpadu, dan berpusat pada ibu hamil. Dalam praktik kebidanan, bidan dituntut mampu memberikan pelayanan yang aman, menyeluruh, humanis, dan sesuai standar. Oleh karena itu, mahasiswa kebidanan perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai cara melakukan pemeriksaan, mengenali tanda bahaya kehamilan,

menilai faktor risiko, memberikan edukasi kesehatan, serta melakukan kolaborasi atau rujukan apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Materi dalam buku ajar ini disajikan secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, laboratorium keterampilan, maupun praktik klinik. Buku ini diharapkan mampu membantu mahasiswa menghubungkan konsep teori dengan penerapan nyata dalam pelayanan antenatal. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi dosen dan praktisi dalam mengembangkan pembelajaran serta meningkatkan mutu pelayanan kebidanan.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, kedalaman pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, bidan, dan seluruh pembaca dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pemeriksaan antenatal terpadu demi terwujudnya kesehatan ibu dan bayi yang optimal.

**Penulis**

Juli, 2026

# DAFTAR ISI

**PRAKATA** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **v**

**BAB 1 PEMERIKSAAN PENUNJANG KEHAMILAN: LABORATORIUM DASAR, USG, DAN INTERPRETASI HASIL** ..... **1**
A. Pemeriksaan Laboratorium Dasar Kehamilan ..... 4
B. Ultrasonografi (USG) Dasar Terbatas dalam Kebidanan ..... 10
C. Interpretasi Hasil dan Integrasi Temuan Klinis ..... 12
D. Aktivitas 1 — Ujian interpretasi penunjang (case-based) ..... 13
E. Rubrik Penilaian ..... 15
F. Ringkasan 1 Halaman ..... 16
G. Daftar Pustaka ..... 17

**BAB 2 IDENTIFIKASI TANDA BAHAYA KEHAMILAN : PERDARAHAN, NYERI HEBAT, DEMAM, DAN PENURUNAN GERAK JANIN** ..... **21**
A. Perdarahan ..... 31
B. Nyeri Hebat ..... 46
C. Deman ..... 49
D. Penurunan Gerak Janin ..... 51
E. Aktivitas 1 — Knows How ..... 52
F. Latihan Soal ..... 53
G. Tabel Red Flags & Eskalasi ..... 69
H. Rangkuman Materi ..... 71
I. Glosarium ..... 72
J. Daftar Pustaka ..... 73

**BAB 3 DETEKSI DINI ANEMIA DAN MASALAH GIZI: HB, STATUS GIZI, DAN INTERVENSI AWAL** ..... **76**
A. Deteksi Dini Anemia dan Masalah Gizi ..... 78
B. Deteksi Dini Anemia ..... 79
C. Deteksi Dini Masalah Gizi ..... 82
D. Aktivitas 1 — *Knows How* ..... 86
E. Latihan Soal ..... 87

F. Rangkuman Materi ..... 96
G. Daftar Pustaka ..... 97

**BAB 4 KELUHAN UMUM KEHAMILAN: PENILAIAN PENYEBAB DAN TATA LAKSANA NON FARMAKOLOGIS" ..... 100**
A. Konsep Dasar Kehamilan ..... 106
B. Keluhan Umum pada Kehamilan ..... 106
C. Jenis-Jenis Keluhan Umum pada Kehamilan ..... 107
D. Penilaian Penyebab Keluhan Kehamilan(World Health Organization, 2020) ..... 115
E. Tata Laksana Nonfarmakologis ..... 117
F. Bentuk Tata Laksana Nonfarmakologis (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020) ..... 118
G. Peran Tenaga Kesehatan(World Health Organization, 2020) ..... 120
H. Metode Dokumentasi (SOAP) pada Keluhan Umum Kehamilan ..... 121
I. Aktivitas 1 — Knows How ..... 122
J. Aktivitas 2 — Shows How ..... 123
K. Ringkasan ..... 151
L. Daftar Pustaka ..... 157

**BAB 5 KONSELING ANC TERPADU: GIZI, AKTIVITAS, PERSIAPAN PERSALINAN, DAN RENCANA RUJUKAN ..... 158**
A. Konseling ANC Terpadu: Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan ..... 160
B. Konseling gizi, aktivitas ibu hamil, persiapan persalinan dan rencana rujukan ..... 163
C. Konseling Aktivitas Ibu Hamil ..... 165
D. Konseling Persiapan Persalinan ..... 166
E. Konseling Rencana Rujukan Ibu Hamil ..... 167
F. Ringkasan ..... 185
G. Daftar Pustaka ..... 189

**PROFIL PENULIS ..... 192**

# BAB 1

## PEMERIKSAAN PENUNJANG KEHAMILAN: LABORATORIUM DASAR, USG, DAN INTERPRETASI HASIL

**CPL**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menguasai konsep ilmiah dan evidence-based terkait pemeriksaan antenatal terpadu. | CPMK-1, CPMK-5 |
| CPL-3 | Mampu menginterpretasi temuan klinis dan penunjang untuk mengenali masalah serta risiko kehamilan. | CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6 |

**CPK**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK Utama | |
| CPMK-5 | Menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang kehamilan (laboratorium dasar dan USG) dan mengintegrasikannya dengan temuan klinis. |
| CPMK Penguat | |
| CPMK-1 | Menganalisis konsep dasar pemeriksaan antenatal terpadu, standar pelayanan ANC, serta prinsip privasi, keselamatan pasien, dan pencegahan infeksi. |
| CPMK-6 | Mengidentifikasi tanda bahaya dan masalah prioritas pada kehamilan (termasuk hipertensi/preeklamsia, anemia/gizi, keluhan umum) serta menetapkan tindak lanjut awal dan kebutuhan rujukan. |

**Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK**

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 8. Pemeriksaan Penunjang Kehamilan: Laboratorium | 8.1 Menentukan pemeriksaan penunjang dasar kehamilan sesuai | 8.2 Menginterpretasi hasil laboratorium/USG dan mengintegrasikan dengan temuan klinis. | CPMK-5 | CPMK-6; CPMK-1 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Dasar, USG, dan Interpretasi Hasil | indikasi dan waktu pemeriksaan. | | | |

## Uraian Materi

Pemeriksaan penunjang dalam kehamilan, termasuk laboratorium dasar dan ultrasonografi (USG), merupakan bagian integral dari asuhan antenatal karena berfungsi untuk memperkuat dugaan klinis, mendeteksi risiko sejak dini, dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Meskipun demikian, pemeriksaan penunjang tidak dapat menggantikan peran anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis tetap menjadi langkah utama untuk menggali keluhan ibu, riwayat kesehatan, riwayat obstetri, dan faktor risiko kehamilan. Dengan demikian, pemeriksaan penunjang sebaiknya dipandang sebagai penguat diagnosis, bukan satu-satunya dasar penetapan masalah kebidanan (Wardani & Rosyidah, 2025).

Dalam praktik kebidanan, pemeriksaan laboratorium dasar, seperti hemoglobin, protein urin, golongan darah, dan gula darah sewaktu, sangat membantu dalam skrining anemia, preeklampsia, infeksi, dan gangguan metabolik pada ibu hamil. Sementara itu, USG memberikan informasi penting terkait usia kehamilan, jumlah janin, letak plasenta, pertumbuhan janin, serta kemungkinan adanya kelainan kehamilan. Hasil pemeriksaan ini memperkaya proses pengkajian, namun interpretasinya tetap harus dikaitkan dengan kondisi klinis ibu secara menyeluruh (Wardani & Rosyidah, 2025; Goldenberg et al., 2018).

Meskipun pemeriksaan penunjang memiliki manfaat yang signifikan, bidan tetap harus memahami batas kewenangannya. Tidak semua hasil pemeriksaan dapat ditangani di tingkat layanan primer, terutama jika ditemukan tanda bahaya atau hasil yang mengarah pada kehamilan risiko tinggi. Dalam situasi tersebut, rujukan dini menjadi langkah penting untuk mencegah keterlambatan penanganan dan menurunkan risiko komplikasi bagi ibu maupun janin. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengenali hasil abnormal dan keputusan merujuk merupakan kompetensi krusial dalam asuhan kebidanan (Wardani & Rosyidah, 2025; Goldenberg et al., 2018).

Secara keseluruhan, pemeriksaan penunjang harus dipahami sebagai bagian dari pendekatan komprehensif. Anamnesis memberikan arah, pemeriksaan fisik memberikan konteks klinis, dan pemeriksaan penunjang memperkuat keputusan diagnosis serta tindak lanjut. Pemahaman yang benar mengenai fungsi, batasan, dan makna hasil pemeriksaan sangat penting agar mahasiswa kebidanan mampu berpikir sistematis, bekerja sesuai kewenangan, dan melakukan rujukan tepat waktu demi keselamatan ibu dan janin (Wardani & Rosyidah, 2025).

## A. Pemeriksaan Laboratorium Dasar Kehamilan

### 1. Pemeriksaan Darah Rutin dan Golongan Darah

a. Kadar Hemoglobin (Hb)

Pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) merupakan bagian penting dari pemeriksaan darah rutin pada ibu hamil. Pemeriksaan ini digunakan untuk skrining anemia sejak dini dan membantu menilai kemampuan darah dalam mengangkut oksigen untuk kebutuhan ibu dan janin. Dalam pelayanan kebidanan, hasil Hb perlu ditafsirkan bersama anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kondisi klinis ibu, karena penurunan Hb dapat berkaitan dengan asupan zat besi yang kurang, perdarahan, infeksi, atau kondisi lain yang memengaruhi kehamilan. (Stephansson et al., 2000; McDade et al., 2023).

Selama kehamilan terjadi perubahan fisiologis berupa hemodilusi, yaitu peningkatan volume plasma yang lebih besar dibandingkan peningkatan massa eritrosit. Perubahan ini menyebabkan kadar Hb tampak menurun, terutama pada trimester kedua, dan pada batas tertentu merupakan adaptasi normal tubuh ibu hamil. Namun, penurunan Hb yang melampaui batas fisiologis perlu diwaspadai karena dapat menunjukkan anemia yang memerlukan penanganan lebih lanjut. (Stephansson et al., 2000; McDade et al., 2023).

Secara umum, pemeriksaan Hb pada kehamilan bertujuan mempertahankan kadar yang memadai agar kebutuhan oksigen ibu dan janin tetap terpenuhi. Pada praktik klinis, anemia kehamilan umumnya ditandai dengan Hb kurang dari 11 g/dL pada trimester pertama dan ketiga, serta kurang dari 10,5 g/dL pada trimester kedua. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan kadar Hb di bawah nilai tersebut, bidan perlu melakukan evaluasi lanjutan, memberikan edukasi gizi dan kepatuhan konsumsi zat besi, serta merujuk bila ditemukan anemia sedang sampai berat atau kondisi klinis yang menyertai. (FIGO, 2025; McDade et al., 2023).

1) Batas Hb Normal pada Ibu Hamil

WHO dan Kemenkes menetapkan bahwa anemia pada kehamilan ditegakkan bila kadar Hb <11 g/dL. Variasi batas trimester: Hb <11 g/dL pada trimester I dan III serta <10,5 g/dL pada trimester II, namun secara praktis di Indonesia umumnya digunakan cut-off 11 g/dL untuk kehamilan.

**Tabel 1.1 Derajat anemia pada Ibu Hamil Menurut WHO**

| Kategori | Kadar Hb (g/dL) |
|---|---|
| Tidak anemia | ≥ 11,0 |
| Anemia ringan | 10,0 – 10,9 |

| | |
|---|---|
| Anemia sedang | 7,0 – 9,9 |
| Anemia berat | < 7,0 |

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata kadar Hb cenderung menurun seiring bertambahnya trimester akibat hemodilusi, misalnya rerata Hb 11,53 g/dL pada trimester I, 11,05 g/dL trimester II, dan 10,45 g/dL trimester III (Nurhajimah, 2024)

2) Waktu dan Frekuensi Pemeriksaan Hb

Pemeriksaan Hb dilakukan minimal dua kali selama kehamilan. Umumnya pemeriksaan dilakukan pada trimester I (sebelum usia kehamilan 12 minggu) dan trimester III (sekitar 28–36 minggu) untuk menilai kondisi awal dan memantau perubahan menjelang persalinan. Di beberapa puskesmas, pemeriksaan Hb juga dikaitkan dengan program 1000 HPK untuk pemantauan status gizi dan pencegahan anemia pada ibu hamil.

3) Metode Pemeriksaan Kadar Hb di Layanan Kebidanan

Di fasilitas pelayanan dasar, pemeriksaan Hb dapat dilakukan dengan beberapa metode sederhana maupun laboratorium.

Metode yang sering digunakan antara lain:

a) Metode Sahli (acid hematin): metode kolorimetri sederhana menggunakan alat Sahli, banyak digunakan di fasilitas dengan keterbatasan sarana.
b) Metode sianmethemoglobin atau automatic analyzer di laboratorium: lebih akurat, namun membutuhkan peralatan dan reagen khusus.
c) Alat digital portabel (hemoglobinometer): semakin banyak digunakan dalam program lapangan karena hasilnya cepat dan relatif mudah dioperasikan.

Metode Sahli dan pemeriksaan sederhana lainnya digunakan luas sebagai surveilans anemia di masyarakat dan layanan primer karena murah dan mudah dilakukan.

b. Golongan Darah dan Rhesus

Pemeriksaan golongan darah ABO dan faktor Rhesus merupakan bagian penting dari pemeriksaan darah rutin pada ibu hamil. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi kemungkinan inkompatibilitas antara darah ibu dan janin, terutama pada ibu dengan Rh negatif yang berisiko mengalami alloimunisasi bila janin Rh positif. Kondisi tersebut dapat memicu pembentukan antibodi maternal terhadap eritrosit janin dan berpotensi menyebabkan hemolytic disease of the fetus and newborn. Karena itu, penentuan golongan darah sejak awal kehamilan penting dilakukan sebagai

langkah pencegahan dan dasar pemantauan lanjutan. (Sari & Wibowo, 2025; Rhesus incompatibility in pregnancy: a case report, 2020).

Dalam praktik kebidanan, hasil pemeriksaan golongan darah dan Rhesus membantu mengidentifikasi ibu hamil yang memerlukan pemantauan lebih ketat serta kolaborasi atau rujukan ke fasilitas yang lebih mampu. Pemeriksaan ini juga penting dalam situasi perdarahan atau kebutuhan transfusi, karena kesesuaian darah harus dipastikan untuk mencegah komplikasi transfusi. Dengan demikian, pemeriksaan golongan darah dan Rhesus bukan hanya data biologis dasar, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keselamatan ibu dan janin sepanjang kehamilan. (Sari & Wibowo, 2025; Rhesus incompatibility in pregnancy: a case report, 2020).

1) Waktu Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus dalam ANC
   a) Pemeriksaan golongan darah dan rhesus sebaiknya dilakukan pada kunjungan antenatal pertama (K1) atau sedini mungkin setelah kehamilan terdeteksi.
   b) Hasil dicatat dalam buku KIA/kartu ANC dan rekam medis ibu sebagai data dasar yang berlaku sepanjang hayat.
2) Metode Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus
   a) Pemeriksaan Golongan Darah ABO

      Metode yang lazim digunakan di layanan dasar:
      - Metode slide/card (aglutinasi langsung)
      - Menggunakan antisera anti-A dan anti-B.
      - Cepat, sederhana, banyak digunakan di puskesmas/RS kecil.

      Prinsip: Bila darah dicampur dengan antisera sesuai, akan terjadi aglutinasi (penggumpalan) bila antigen yang bersesuaian ada di eritrosit.

      Contoh:
      - Darah + anti-A → aglutinasi, darah + anti-B → tidak → golongan A.
      - Darah + anti-A → aglutinasi, darah + anti-B → aglutinasi → golongan AB.
      - Tidak aglutinasi dengan keduanya → golongan O
   b) Pemeriksaan Rhesus (RhD)
      - Menggunakan antisera anti-D (RhD).
      - Darah dicampur dengan anti-D, kemudian diamati aglutinasi: Aglutinasi → Rh positif & Tidak Aglutinasi → Rh negative.

## 2. Pemeriksaan Urin (Urinanalisis)

Pemeriksaan urin merupakan bagian rutin dari pelayanan antenatal karena dapat membantu deteksi dini komplikasi kehamilan, termasuk preeklampsia dan diabetes melitus gestasional.

a. Pemeriksaan protein urine

Pemeriksaan protein urine pada ibu hamil adalah pemeriksaan sederhana tetapi sangat penting untuk deteksi dini risiko preeklampsia dan gangguan ginjal ibu hamil. Proteinuria adalah keadaan di mana terdapat protein dalam urine melebihi kadar normal, biasanya lebih dari 150 mg/24 jam. Protein urin dikatakan patologis pada ibu hamil bila kadar protein dalam urin ≥300 mg/24 jam atau setara sekitar ≥+2 pada dipstick. Beberapa penelitian di Indonesia menggunakan ambang +2 pada dipstick sebagai indikator proteinuria yang bermakna klinis pada ibu hamil trimester II–IIIPada kehamilan, sedikit protein masih bisa muncul dalam urin karena perubahan fisiologis ginjal, tetapi bila berlebihan harus dicurigai sebagai tanda penyakit, terutama preeklampsia. Proteinuria sering dikaitkan dengan preeklampsia, yaitu penyakit kehamilan dengan tanda hipertensi, edema, dan proteinuria yang timbul setelah usia kehamilan 20 minggu.

Penelitian menunjukkan bahwa protein urin positif pada trimester II dan III berhubungan dengan meningkatnya kejadian hipertensi dan edema sebagai gejala preeklampsia. Selain preeklampsia, proteinuria pada ibu hamil juga dapat disebabkan oleh kerusakan ginjal, infeksi saluran kemih, sindrom HELLP, diabetes gestasional, dan dehidrasi berat

Metode pemeriksaan protein urine pada ibu hamil

1) Pemeriksaan carik celup (dipstick) – metode utama di layanan kebidanan

   Metode carik celup visual menggunakan strip urin (dipstick) adalah cara paling umum di puskesmas dan klinik untuk skrining proteinuria. Strip berisi area reagen yang akan berubah warna bila bereaksi dengan protein dalam urin; hasil dibaca secara semi-kuantitatif: negatif, trace, +, ++, +++.

2) Pemeriksaan kuantitatif

   Secara definisi, proteinuria ⩾300 mg/24 jam atau rasio protein/kreatinin tertentu menjadi standar emas, tetapi ini biasanya dilakukan di laboratorium rumah sakit, bukan di layanan dasar. Untuk kebidanan primer, cukup dikenalkan sebagai "pemeriksaan lanjutan" bila hasil dipstick mencurigakan dan didukung klinis.

**Interpretasi hasil protein urine pada ibu hamil**

**Tabel 1.2. Interpretasi hasil protein urine pada ibu hamil**

| Hasil dipstick | Makna klinis umum pada kehamilan |
|---|---|
| Negatif | Tidak ada proteinuria signifikan; lanjut ANC rutin |
| Trace | Bisa fisiologis atau awal; perlu pemantauan ulang dan evaluasi faktor lain |
| + (1+) | Proteinuria ringan; evaluasi tekanan darah, gejala, dan ulang pemeriksaan |
| ++ (2+) | Proteinuria bermakna; curiga preeklampsia/kelainan ginjal → pertimbangkan rujukan |
| +++ (3+) | Proteinuria berat; sangat curiga preeklampsia berat/penyakit ginjal |

b. Pemeriksaan Glukosuria

Pemeriksaan glukosu ria pada ibu hamil merupakan bagian dari skrining laboratorium dasar untuk mendeteksi kemungkinan gangguan metabolisme glukosa sejak dini. Meskipun glukosa dalam urine bukan pemeriksaan utama untuk menegakkan diagnosis diabetes melitus gestasional, temuan glukosuria dapat menjadi tanda awal yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Diabetes melitus gestasional sendiri merupakan gangguan toleransi glukosa yang pertama kali diketahui selama kehamilan dan dapat menimbulkan risiko komplikasi pada ibu maupun janin bila tidak dikenali sejak awal. (Yuliana et al., 2026; Plows et al., 2023).

Secara fisiologis, kehamilan menyebabkan perubahan metabolik yang dapat meningkatkan resistensi insulin, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Kondisi ini membuat kadar glukosa darah ibu perlu dipantau, terutama pada ibu dengan faktor risiko seperti obesitas, riwayat keluarga diabetes, riwayat melahirkan bayi besar, atau riwayat diabetes melitus gestasional sebelumnya. Bila glukosuria ditemukan, ibu perlu dievaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik, karena glukosuria dapat terjadi akibat perubahan ambang ginjal selama kehamilan dan tidak selalu mencerminkan hiperglikemia. (Yuliana et al., 2026; Plows et al., 2023).

**Tujuan Pemeriksaan glukosuria**

1) Mendeteksi dini adanya gangguan metabolisme glukosa
2) Mengidentifikasi risiko diabetes gestasional
3) Mendukung diagnosis komplikasi kehamilan
4) Menjadi bagian dari pemantauan kesehatan ibu dan janin

Pemeriksaan ini penting karena komplikasi diabetes dalam kehamilan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti bayi besar (makrosomia), persalinan prematur, hingga kematian janin

**Metode Pemeriksaan**

Pemeriksaan glukosuria umumnya dilakukan dengan metode:

1) Dipstick urin (carik celup)
   Metode dipstick menjadi pilihan utama di pelayanan primer karena cepat, mudah, dan ekonomis.
2) Metode enzimatik (GOD-POD) di laboratorium

**Interpretasi Hasil**

1) Negatif (-): Tidak terdapat glukosa (normal)
2) Positif (+ hingga ++++): Menunjukkan adanya glukosa dalam urin

Namun, hasil positif tidak selalu menunjukkan diabetes karena dapat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis kehamilan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti glukosa darah

**3. Skrining Penyakit Menular (Triple Elimination): Tes HIV, Sifilis, dan Hepatitis B (HBsAg).**

Penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B masih menjadi masalah kesehatan global yang berdampak besar terhadap ibu dan bayi. Penularan dari ibu ke anak dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, maupun menyusui sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka morbiditas dan mortalitas neonatal (WHO, 2017). Skrining HIV, sifilis, dan hepatitis B pada ibu hamil merupakan bagian penting dari strategi triple elimination untuk mencegah penularan infeksi dari ibu ke anak. Pemeriksaan ini dilakukan sedini mungkin dalam pelayanan antenatal agar kasus dapat dikenali lebih awal, ditangani sesuai kewenangan, dan dirujuk bila diperlukan. Ketiga infeksi tersebut sering tidak menimbulkan gejala pada ibu, tetapi dapat menyebabkan dampak berat, seperti abortus, prematuritas, berat badan lahir rendah, infeksi kongenital, hingga kematian bayi. Karena itu, pemeriksaan skrining ini menjadi komponen penting dalam menjaga keselamatan ibu dan janin. (Utami et al., 2020; van den Akker et al., 2011).

Dalam praktik kebidanan, skrining dilakukan untuk mengetahui status infeksi ibu sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang tepat. Pada ibu dengan hasil reaktif, diperlukan konseling, konfirmasi diagnosis, dan rujukan atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang berwenang agar terapi dapat segera diberikan. Pemeriksaan HIV memungkinkan pencegahan penularan melalui terapi antiretroviral, sedangkan deteksi sifilis memungkinkan pengobatan dini untuk mencegah sifilis kongenital. Pemeriksaan HBsAg penting untuk mengidentifikasi

ibu dengan hepatitis B sehingga bayi dapat memperoleh tindakan pencegahan segera setelah lahir. Dengan demikian, triple elimination bukan hanya prosedur skrining rutin, tetapi juga upaya preventif yang berdampak langsung pada luaran kehamilan dan kesehatan bayi. (Utami et al., 2020; van den Akker et al., 2011).

Pelaksanaan skrining triple elimination juga menuntut komunikasi yang baik, kerahasiaan hasil pemeriksaan, serta edukasi yang memadai kepada ibu hamil. Bidan perlu menjelaskan tujuan pemeriksaan, kemungkinan hasil, dan pentingnya tindak lanjut bila hasil reaktif. Pendekatan ini membantu meningkatkan penerimaan ibu terhadap pemeriksaan, mempercepat deteksi kasus, dan mendukung tercapainya eliminasi penularan dari ibu ke anak. (Utami et al., 2020).

**Waktu Pelaksanaan**

Skrining dilakukan:

a. Pada kunjungan antenatal pertama (trimester I)
b. Diulang pada trimester III (pada kelompok berisiko tinggi)

Skrining ini merupakan bagian dari pelayanan antenatal terpadu sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**Interpretasi Hasil**

**Tabel 1.3 Interpretasi hasil pemeriksaan Skrining Penyakit Menular**

| Pemeriksaan | Hasil Negatif | Hasil Positif |
|---|---|---|
| HIV | Tidak terdeteksi antibodi | Perlu konfirmasi dan terapi ARV |
| Sifilis | Non-reaktif | Perlu terapi antibiotik |
| HBsAg | Tidak terinfeksi | Perlu monitoring dan pencegahan transmisi |

Skrining Triple Elimination merupakan intervensi penting dalam pelayanan antenatal untuk mencegah penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi. Melalui deteksi dini dan penanganan yang tepat, risiko penularan dapat ditekan secara signifikan, mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan bebas penyakit menular.

## B. Ultrasonografi (USG) Dasar Terbatas dalam Kebidanan

### 1. Prinsip Dasar dan Keamanan USG (ALARA Principle)

Ultrasonografi (USG) adalah pemeriksaan pencitraan yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, bukan radiasi pengion. Dalam kebidanan, USG digunakan untuk membantu menilai kondisi kehamilan secara lebih aman

karena tidak menimbulkan paparan sinar-X pada janin. Karena itu, USG diagnostik dianggap aman bila dilakukan sesuai indikasi medis dan oleh tenaga yang kompeten. (Puspa et al., 2019; WHO, 2020).

Prinsip keamanan USG dikenal sebagai ALARA, yaitu *As Low As Reasonably Achievable*. Prinsip ini menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan dengan intensitas serendah mungkin, durasi sesingkat mungkin, dan hanya bila manfaat klinisnya jelas. Walaupun USG dinilai aman, operator tetap perlu menjaga penggunaan alat secara bijak agar paparan energi pada jaringan janin tetap minimal. (Puspa et al., 2019; WHO, 2020).

Dalam praktik kebidanan, pemahaman tentang ALARA penting agar bidan dapat memberikan edukasi yang tepat kepada ibu hamil. USG bukan pemeriksaan yang dilakukan berulang tanpa tujuan, melainkan alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, seperti memastikan viabilitas janin, usia kehamilan, dan adanya kelainan yang memerlukan tindak lanjut. Dengan penerapan prinsip ALARA, manfaat USG dapat diperoleh secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan ibu dan janin. (Puspa et al., 2019).

**2. Indikasi dan Waktu Pemeriksaan (Timing):**

Pemeriksaan ultrasonografi pada trimester I dilakukan terutama untuk mengonfirmasi kehamilan intrauterin, mendeteksi denyut jantung janin (DJJ), dan menentukan usia kehamilan secara lebih akurat melalui biometri crown-rump length (CRL). Pada fase ini, USG membantu memastikan lokasi kehamilan, membedakan kehamilan intrauterin dari kehamilan ektopik, serta memberikan dasar penetapan usia kehamilan yang paling reliabel pada awal gestasi. CRL merupakan ukuran yang paling akurat untuk penentuan usia kehamilan pada trimester pertama, khususnya saat embrio mulai terlihat jelas dan pertumbuhan berlangsung paling konsisten. (Abdominal Radiology Editorial, 2019; ISUOG, 2020).

Pada trimester II dan III, pemeriksaan USG digunakan untuk menilai pertumbuhan janin, kesejahteraan janin, lokasi plasenta, dan volume air ketuban. Serial biometri janin penting untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan seperti fetal growth restriction atau janin besar untuk masa kehamilan. Selain itu, evaluasi lokasi plasenta membantu mengidentifikasi plasenta letak rendah atau plasenta previa, sedangkan penilaian volume air ketuban memberi informasi mengenai fungsi plasenta dan kondisi intrauterin. Dengan demikian, timing USG pada trimester lanjut berperan penting dalam pemantauan kehamilan dan perencanaan tindak lanjut klinis. (ISUOG, 2020; Reddy et al., 2014).

### 3. Parameter Dasar USG bagi Bidan

Parameter dasar pada USG obstetri membantu bidan membaca pertumbuhan janin secara lebih terstruktur. BPD mengukur lebar kepala janin, AC menggambarkan lingkar perut sebagai indikator pertumbuhan dan status nutrisi janin, sedangkan FL menilai panjang tulang paha yang juga berkaitan dengan pertumbuhan linear janin. Ketiga parameter ini biasanya digunakan bersama untuk menilai apakah ukuran janin sesuai usia kehamilan dan untuk membantu memperkirakan berat janin secara lebih akurat. (Hadlock et al., 1984; ISUOG, 2020).

Dalam praktik kebidanan, BPD, AC, dan FL tidak dibaca secara terpisah, tetapi dibandingkan dengan usia kehamilan dan pola pertumbuhan janin. Bila salah satu ukuran tampak lebih kecil atau lebih besar dari yang diharapkan, bidan perlu mempertimbangkan kemungkinan variasi normal, kesalahan penentuan usia kehamilan, atau gangguan pertumbuhan janin. Karena itu, pemahaman dasar terhadap parameter ini penting agar bidan dapat mengenali hasil yang normal, mencurigai kelainan, dan merujuk bila ditemukan tanda pertumbuhan janin yang tidak sesuai. (ISUOG, 2020; Hadlock et al., 1984).

## C. Interpretasi Hasil dan Integrasi Temuan Klinis

### 1. Analisis Kritis Hasil Laboratorium

Analisis hasil laboratorium pada ibu hamil harus dilakukan bersama keluhan subjektif dan temuan klinis, karena nilai laboratorium pada kehamilan dapat berubah secara fisiologis dan menutupi atau menyerupai kondisi patologis. Keluhan seperti pusing, cepat lelah, dan lemas perlu dikaitkan dengan kadar hemoglobin, tanda vital, serta kondisi umum ibu. Jika Hb rendah disertai keluhan tersebut, maka anemia menjadi diagnosis kerja yang kuat dan perlu ditindaklanjuti. Sebaliknya, bila hasil laboratorium normal, bidan perlu mempertimbangkan penyebab lain dari keluhan ibu. (Mullins et al., 2018; Miller et al., 2020).

Pendekatan integratif ini penting agar bidan tidak hanya membaca angka laboratorium, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan gejala yang dirasakan ibu. Misalnya, keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, atau nyeri ulu hati yang disertai protein urine positif dapat mengarah pada preeklampsia. Demikian pula, keluhan sering haus dan sering berkemih yang disertai glukosa darah meningkat perlu dicurigai sebagai gangguan toleransi glukosa. Dengan cara ini, interpretasi laboratorium menjadi lebih akurat, kritis, dan bermakna untuk pengambilan keputusan klinis. (Mullins et al., 2018; Miller et al., 2020).

**2. Integrasi Temuan USG dengan Pemeriksaan Fisik**

Temuan USG harus dibaca bersama hasil pemeriksaan fisik, bukan berdiri sendiri. Dalam asuhan kebidanan, pemeriksaan fisik seperti tinggi fundus uteri, palpasi Leopold, denyut jantung janin, tekanan darah, dan keluhan ibu membantu memberi konteks terhadap hasil USG. Misalnya, bila fundus uteri terasa lebih kecil dari usia kehamilan dan USG menunjukkan biometri janin di bawah normal, maka bidan perlu mempertimbangkan kemungkinan gangguan pertumbuhan janin. Sebaliknya, bila hasil pemeriksaan fisik sesuai tetapi USG menunjukkan perbedaan bermakna, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan akurasi usia kehamilan atau kemungkinan kelainan lain. (ISUOG, 2020; Munoz et al., 2023).

Integrasi ini penting karena USG dan pemeriksaan fisik saling melengkapi. Pemeriksaan fisik memberi gambaran klinis awal, sedangkan USG memberikan konfirmasi objektif terhadap posisi janin, pertumbuhan, lokasi plasenta, dan volume air ketuban. Contohnya, pada ibu dengan keluhan gerak janin berkurang, pemeriksaan fisik dapat menunjukkan kondisi umum ibu dan denyut jantung janin, sedangkan USG membantu menilai aktivitas janin, pertumbuhan, serta kondisi cairan amnion. Dengan menggabungkan kedua sumber data tersebut, bidan dapat menentukan apakah kondisi masih fisiologis atau sudah memerlukan kolaborasi dan rujukan. (Abuhamad et al., 2014; ISUOG, 2020).

Pendekatan integratif juga membantu mencegah kesalahan interpretasi. Pemeriksaan fisik yang abnormal tidak selalu berarti kelainan janin, dan temuan USG yang tampak normal tidak selalu menyingkirkan masalah klinis. Karena itu, bidan perlu menilai hasil USG dalam kerangka pemeriksaan kehamilan yang utuh. Ketelitian membaca tanda fisik, mengenali temuan sonografi, dan menghubungkannya dengan kondisi ibu merupakan keterampilan penting agar keputusan asuhan lebih tepat dan aman. (ISUOG, 2020).

## D. Aktivitas 1 — Ujian interpretasi penunjang (case-based)

**Pemeriksaan Laboratorium & USG Kehamilan**

1. Skenario Kasus:

   Seorang ibu hamil G2P1A0 usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan pusing, lemah, dan bengkak pada kaki sejak 1 minggu terakhir. Usia kehamilan 31 minggu. Hasil pemeriksaan TD: 150/100 mmHg, Nadi: 92 x/menit, Pernafasan: 20 x/menit, Edema ekstremitas bawah (+), TFU sesuai usia kehamilan. Pemeriksaan Laboratorium: Hb: 9,8 g/dL Protein urine: (+2), Gula darah sewaktu: 95 mg/dL. Hasil USG: Janin tunggal hidup, Presentasi kepal, Berat janin sesuai usia kehamilan, Air ketuban cukup.

2. Lembar Jawaban Mahasiswa

   Nama :

   Nim :

   Kelas :

   a. Klasifikasi Hasil Pemeriksaan

| No | Parameter | Hasil | Normal/Abnormal | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hb | | | |
| 2 | Protein urine | | | |
| 3 | Gula darah | | | |
| 4 | USG | | | |

   b. Analisis Integrasi Data

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

   c. Simpulan Masalah Klinis

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Lembar Analisis Kasus Penunjang

   a. dentifikasi Data

      Data Subjektif:

      .....
      .....

      Data Objektif:

      .....
      .....

      Data Penunjang:

.....
.....

b. Interpretasi Laboratorium

| Pemeriksaan | Nilai | Interpretasi | Dasar |
|---|---|---|---|
| Hb | | | |
| Protein urine | | | |
| Gula darah | | | |

c. Interpretasi USG

.....
.....

d. Analisis Klinis (Jika… maka… karena…)

.....

e. Penentuan Masalah

.....

f. Sintesis (Kesimpulan)

.....

## E. Rubrik Penilaian

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| Akurasi interpretasi laboratorium dasar | Salah mengklasifikasi hasil; implikasi klinis tidak tepat | Klasifikasi dasar benar sebagian; implikasi masih umum | Klasifikasi tepat; implikasi klinis sesuai konteks kasus | Klasifikasi sangat tepat; implikasi jelas, spesifik, dan terintegrasi dengan konteks |
| Integrasi hasil USG/penunjang dengan temuan klinis | Tidak mengaitkan data penunjang dengan kondisi; | Mengaitkan sebagian; simpulan masih lemah | Mengaitkan data penunjang klinis secara | Integrasi sangat kuat; simpulan tajam dan mendukung |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | simpulan tidak logis | | logis; simpulan tepat | keputusan tindak lanjut secara jelas |

## F. Ringkasan

Pemeriksaan penunjang pada kehamilan, meliputi laboratorium dasar dan ultrasonografi (USG), merupakan komponen penting dalam asuhan antenatal. Fungsi utamanya adalah memperkuat dugaan klinis, mendeteksi risiko dini, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Pemeriksaan ini bersifat komplementer dan harus dikaitkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik ibu hamil untuk memperoleh gambaran klinis yang utuh. Anamnesis tetap menjadi langkah utama untuk mengevaluasi keluhan, riwayat kesehatan, obstetri, dan faktor risiko kehamilan.

Laboratorium Dasar mencakup pemeriksaan hemoglobin (Hb) untuk skrining anemia, protein urin untuk deteksi preeklampsia atau gangguan ginjal, gula darah sewaktu untuk skrining diabetes gestasional, serta golongan darah dan faktor Rhesus untuk mencegah inkompatibilitas ibu–janin. Nilai Hb normal pada kehamilan adalah ≥11 g/dL; anemia dikategorikan ringan (10–10,9 g/dL), sedang (7–9,9 g/dL), dan berat (<7 g/dL). Pemeriksaan urine dipantau dengan dipstick, sementara skrining HIV, sifilis, dan HBsAg penting dalam strategi triple elimination untuk mencegah penularan ibu–anak.

Ultrasonografi (USG) digunakan untuk menilai usia kehamilan, jumlah janin, pertumbuhan, lokasi plasenta, dan volume cairan ketuban. Prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable) menekankan penggunaan gelombang suara serendah mungkin dan durasi sesingkat mungkin untuk keselamatan janin. USG trimester I fokus pada konfirmasi kehamilan, denyut jantung janin, dan biometri crown-rump length (CRL). Trimester II–III digunakan untuk memantau pertumbuhan janin (BPD, AC, FL), lokasi plasenta, dan kondisi cairan amnion.

Interpretasi Hasil dan Integrasi Klinis penting untuk pengambilan keputusan. Hasil laboratorium harus dianalisis bersama keluhan dan pemeriksaan fisik. Misalnya, Hb rendah dengan gejala pusing dan lemas mengarah pada anemia, sedangkan proteinuria dengan hipertensi mencurigai preeklampsia. USG harus dikombinasikan dengan pemeriksaan fisik untuk menilai pertumbuhan janin, aktivitas janin, dan kondisi intrauterin. Pendekatan integratif ini meminimalkan risiko kesalahan interpretasi dan menentukan kebutuhan rujukan atau tindak lanjut yang tepat.

Secara keseluruhan, pemeriksaan penunjang kehamilan memberikan dasar objektif bagi bidan untuk pengkajian klinis, penentuan risiko, edukasi gizi,

pengawasan komplikasi, dan rujukan tepat waktu. Kompetensi membaca, menafsirkan, dan mengintegrasikan data laboratorium serta USG dengan temuan klinis menjadi kunci dalam praktik kebidanan yang aman dan evidence-base

**Alur Asuhan Singkat**

Ibu hamil menjalani anamnesis & pemeriksaan fisik Pemeriksaan laboratorium: Hb, protein urin, gula darah, golongan darah/Rhesus USG dasar untuk usia kehamilan, pertumbuhan janin, plasenta, dan cairan ketuban Identifikasi masalah & risiko Edukasi ibu terkait tanda bahaya dan nutrisi Rencana tindak lanjut termasuk monitoring, rujukan, dan jadwal kunjungan berikutnya Verifikasi pemahaman & dokumentasi pada Buku KIA dan stiker P4K.

## G. Daftar Pustaka


Abdominal Radiology Editorial. (2019). Role of ultrasound in the evaluation of first-trimester pregnancies in the acute setting. Abdominal Radiology, 44(10), 3576–3590. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7065984/

Abuhamad, A., et al. (2014). Routine obstetrical ultrasound examination in the second and third trimester. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, 36(9), 828–839. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9710905/

Benson, C. S., Shah, A., Frise, M. C., Lal, S., Manjunath, S. N., & Bhatia, R. (2019). The change in haemoglobin concentration between the first and third trimester of pregnancy is highly variable among individual women. BMC Pregnancy and Childbirth, 19, 388. https://doi.org/10.1186/s12884-019-2556-8

Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. (2022, August 4). Anemia dalam kehamilan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/1132/anemia-dalam-kehamilan

Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. (2023, November 5). Anemia pada kehamilan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2918/anemia-pada-kehamilan

FIGO. (2025). FIGO good practice recommendations on anemia in pregnancy, to improve maternal and fetal outcomes. International Journal of Gynecology & Obstetrics. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41031541/

Hadlock, F. P., Harrist, R. B., Sharman, R. S., Deter, R. L., & Park, S. K. (1984). Estimation of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements. A

prospective study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 151(3), 333–337. https://doi.org/10.1016/S0002-9378(84)80084-0

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). (2020). Practice guidelines: Ultrasound assessment of fetal biometry and growth. https://www.wrh.ox.ac.uk/publications/101070

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Pedoman pelayanan antenatal terpadu (Dokumen kebijakan nasional). World Health Organization – MNCAH Policy Indicator.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024, August 26). Buku saku pencegahan anemia pada ibu hamil dan remaja putri. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://ayosehat.kemkes.go.id/buku-saku-pencegahan-anemia-pada-ibu-hamil-dan-remaja-putri

McDade, A., et al. (2023). Maternal hemoglobin concentrations across pregnancy and child health and development. Maternal and Child Health Journal. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9978095/

Miller, J. P., et al. (2020). Common symptoms and signs during pregnancy. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 68, 1–14. https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/common-symptoms-and-signs-during-pregnancy/

Mullins, E., et al. (2018). Changes in biochemical tests in pregnancy and their clinical significance. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 38(3), 345–352. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6295771/

Nurhajimah. (2024). Perbandingan Kadar Haemoglobin pada Ibu Hamil Trimester I, II, III dalam Rangka Mengidentifikasi Kejadian Anemia Puskesmas Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Ventilator: Jurnal Kesehatan, 6(2), 45–52.

Plows, J. F., Stanley, J. L., Baker, P. N., Reynolds, C. M., & Vickers, M. H. (2023). A comprehensive review of gestational diabetes mellitus. Nutrients, 15(20), 4257. https://doi.org/10.3390/nu15204257

Puspa, S., dkk. (2019). Pengaruh pelatihan ultrasonografi terhadap pengetahuan residen obstetri dan ginekologi mengenai keamanan penggunaan ultrasonografi pada kehamilan. Jurnal Kedokteran Universitas Gadjah Mada. https://journal.ugm.ac.id/jkr/article/download/41409/24652

Rhesus incompatibility in pregnancy: a case report. (2020). Indonesian Journal of Perinatology, 1(1), 1–4. https://perinasiajournal.id/index.php/InaJPerinatol/article/view/1

Sari, N., & Wibowo, A. (2025). Korelasi golongan darah dan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Lontara: Journal of Health Science & Technology, 6(2), 174–181. https://www.jurnal.poltekmu.ac.id/index.php/lontarariset/article/download/597/378

Utami, D. P., Sari, N. K., & Lestari, A. A. (2020). Gambaran hasil pemeriksaan skrining RPR-TP rapid, anti-HIV dan HBsAg pada ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Anakes: Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2(1), 1–8. https://journal.thamrin.ac.id/index.php/anakes/article/view/359

van den Akker, T., van de Pas, R., Smits, L. J., et al. (2011). Antenatal screening for HIV, hepatitis B and syphilis in the Netherlands is effective. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 37(10), 1372–1379. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21718466/

World Health Organization. (2020). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience: Ultrasound examination. https://www.who.int/initiatives/triple-elimination-initiative-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-syphilis-and-hepatitis-b

Yuliana, A., Anong, D., & Sari, R. (2026). Gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di Puskesmas Tambelan Sampit Kota Pontianak. Jurnal Ners, 10(1), 1–8. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/download/22203/17795/82272

# BAB 2

## IDENTIFIKASI TANDA BAHAYA KEHAMILAN : PERDARAHAN, NYERI HEBAT, DEMAM, DAN PENURUNAN GERAK JANIN

**Tabel CPL**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menguasai konsep ilmiah dan evidence-based terkait pemeriksaan antenatal terpadu. | CPMK-1, CPMK-5 |
| CPL-2 | Mampu melaksanakan pemeriksaan antenatal terpadu secara sistematis, aman, dan efektif. | CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4 |
| CPL-3 | Mampu menginterpretasi temuan klinis dan penunjang untuk mengenali masalah serta risiko kehamilan. | CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6 |
| CPL-4 | Mampu menetapkan tindak lanjut, intervensi awal, dan rencana rujukan berdasarkan hasil pemeriksaan. | CPMK-6, CPMK-7 |
| CPL-5 | Mampu berkomunikasi terapeutik dan melakukan konseling kesehatan ibu secara kolaboratif. | CPMK-2, CPMK-7 |
| CPL-6 | Menunjukkan profesionalisme (etika, privasi, keselamatan pasien, pencegahan infeksi, dokumentasi) dalam pelayanan ANC. | CPMK-1, CPMK-3, CPMK-7 |

**Tabel CPMK**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Menganalisis konsep dasar pemeriksaan antenatal terpadu, standar pelayanan ANC, serta prinsip privasi, keselamatan pasien, dan pencegahan infeksi. |
| CPMK-2 | Melaksanakan anamnesis terstruktur pada ibu hamil untuk menghimpun data penting dan mengenali faktor risiko. |

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-3 | Melaksanakan pemeriksaan tanda vital, antropometri, dan pemeriksaan fisik umum ibu hamil sesuai prosedur serta menafsirkan temuan dasar. |
| CPMK-4 | Melaksanakan pemeriksaan abdomen obstetri dan penilaian kesejahteraan janin secara sistematis serta menginterpretasi hasil pemantauan klinis. |
| CPMK-5 | Menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang kehamilan (laboratorium dasar dan USG) dan mengintegrasikannya dengan temuan klinis. |
| CPMK-6 | Mengidentifikasi tanda bahaya dan masalah prioritas pada kehamilan (termasuk hipertensi/preeklamsia, anemia/gizi, keluhan umum) serta menetapkan tindak lanjut awal dan kebutuhan rujukan. |
| CPMK-7 | Melaksanakan konseling ANC terpadu dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam format standar untuk mendukung keputusan klinis dan komunikasi layanan. |

**Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK**

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 1. Konsep Dasar Pemeriksaan Antenatal Terpadu dan Standar Pelayanan ANC | 1.1 Menjelaskan tujuan, komponen, dan alur pemeriksaan antenatal terpadu. | 1.2 Menguraikan standar pelayanan ANC (jadwal, komponen minimal, indikator mutu) sebagai dasar praktik. | CPMK-1 | CPMK-7 |
| Bab 2. Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi, dan Pencegahan Infeksi | 2.1 Menyiapkan alat, lingkungan, dan alur pemeriksaan yang ergonomis dan aman. | 2.2 Menerapkan privasi, informed consent, dan pencegahan infeksi selama ANC. | CPMK-1 | CPMK-3; CPMK-7 |
| Bab 3. Anamnesis Terstruktur pada Ibu Hamil: Riwayat Obstetri, Penyakit, dan Faktor Risiko | 3.1 Melakukan anamnesis terstruktur mencakup riwayat obstetri, penyakit, obat, dan faktor sosial. | 3.2 Menyusun faktor risiko dan prioritas tindak lanjut dari hasil anamnesis. | CPMK-2 | CPMK-6; CPMK-7 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 4. Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri Ibu Hamil: Teknik dan Interpretasi | 4.1 Melakukan pengukuran tanda vital sesuai prosedur. | 4.2 Mengukur antropometri dan menafsirkan implikasinya pada kehamilan. | CPMK-3 | CPMK-6 |
| Bab 5. Pemeriksaan Fisik Umum: Kepala–Leher, Jantung–Paru, Abdomen Non-Obstetri, dan Ekstremitas | 5.1 Melakukan pemeriksaan fisik umum sistematis dengan teknik pemeriksaan yang tepat. | 5.2 Mengidentifikasi temuan abnormal yang relevan terhadap kehamilan. | CPMK-3 | CPMK-6; CPMK-1 |
| Bab 6. Pemeriksaan Abdomen Obstetri: Leopold, Tinggi Fundus, Presentasi, dan Penurunan Bagian Terendah | 6.1 Melakukan manuver Leopold, mengukur tinggi fundus, dan menilai presentasi/posisi janin. | 6.2 Menilai penurunan bagian terendah dan kesesuaian usia kehamilan berbasis TFU. | CPMK-4 | CPMK-3; CPMK-6 |
| Bab 7. Penilaian Kesejahteraan Janin: DJJ, Gerak Janin, dan Pemantauan Pertumbuhan | 7.1 Menilai kesejahteraan janin melalui DJJ dan pola gerak janin. | 7.2 Mengevaluasi pertumbuhan janin berbasis pemantauan klinis serial dan menentukan kebutuhan pemantauan lanjut. | CPMK-4 | CPMK-6; CPMK-5 |
| Bab 8. Pemeriksaan Penunjang Kehamilan: Laboratorium Dasar, USG, dan Interpretasi Hasil | 8.1 Menentukan pemeriksaan penunjang dasar kehamilan sesuai indikasi dan waktu pemeriksaan. | 8.2 Menginterpretasi hasil laboratorium/USG dan mengintegrasikan dengan temuan klinis. | CPMK-5 | CPMK-6; CPMK-1 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 9. Identifikasi Tanda Bahaya Kehamilan: Perdarahan, Nyeri Hebat, Demam, dan Penurunan Gerak Janin | 9.1 Mengenali tanda bahaya utama melalui anamnesis terarah dan pemeriksaan cepat. | 9.2 Menentukan tindakan awal dan keputusan rujukan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan. | CPMK-6 | CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7 |
| Bab 10. Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan dan Preeklamsia: Skrining, Kriteria, dan Tindak Lanjut | 10.1 Melaksanakan skrining hipertensi/preeklamsia melalui teknik pengukuran dan penilaian gejala. | 10.2 Menerapkan kriteria tindak lanjut/rujukan pada hipertensi/preeklamsia berdasarkan derajat. | CPMK-6 | CPMK-3; CPMK-5 |
| Bab 11. Deteksi Dini Anemia dan Masalah Gizi: Hb, Status Gizi, dan Intervensi Awal | 11.1 Melakukan skrining anemia dan status gizi serta klasifikasi derajat masalah. | 11.2 Menetapkan intervensi awal dan indikator pemantauan perbaikan. | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-7 |
| Bab 12. Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Nonfarmakologis | 12.1 Mengkaji keluhan umum untuk membedakan fisiologis vs patologis. | 12.2 Memberikan tata laksana nonfarmakologis dan menentukan indikasi evaluasi lanjut/rujukan. | CPMK-6 | CPMK-2; CPMK-7 |
| Bab 13. Konseling ANC Terpadu: Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan | 13.1 Melaksanakan konseling ANC terpadu mencakup gizi, aktivitas, tanda bahaya, dan kepatuhan kunjungan. | 13.2 Menyusun rencana persalinan dan rencana rujukan bersama ibu/keluarga. | CPMK-7 | CPMK-6; CPMK-1 |
| Bab 14. Dokumentasi Hasil Pemeriksaan ANC: | 14.1 Mendokumentasikan hasil ANC pada format | 14.2 Mensintesis data untuk keputusan klinis dan komunikasi antar-layanan. | CPMK-7 | CPMK-5; CPMK- |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| SOAP/Format ANC, Buku KIA, dan Keputusan Klinis | standar secara lengkap dan legal. | | | 6; CPMK-1 |

**Tabel Asesmen (berbasis CPMK)**

| Kode CPMK | Teknik/Instrumen | Indikator Penilaian (inti, terukur) | Bobot (%) | Bukti/Produk |
|---|---|---|---|---|
| CPMK-1 | Ujian tulis (MCQ/SAQ) berbasis standar & kasus | Ketepatan mengaitkan komponen ANC standar dengan skenario layanan; konsistensi langkah privasi–keselamatan pasien–pencegahan infeksi dalam alur pemeriksaan | 8 | Lembar jawaban ujian; analisis singkat alur standar |
| CPMK-2 | OSCE anamnesis (checklist) | Item data kunci anamnesis terisi lengkap dan runtut; faktor risiko teridentifikasi dan diprioritaskan dari skenario | 15 | Checklist OSCE; lembar ringkasan risiko |
| CPMK-3 | OSCE keterampilan (tanda vital, antropometri, fisik umum) | Prosedur pengukuran tanpa kesalahan kritis; hasil ukur dan pencatatan temuan konsisten dengan kondisi skenario/temuan simulasi | 15 | Checklist OSCE; lembar hasil ukur & catatan temuan |
| CPMK-4 | OSCE obstetri (Leopold–TFU–DJJ) | Urutan dan teknik pemeriksaan tepat; interpretasi presentasi/posisi, TFU, dan parameter kesejahteraan janin sesuai data yang diperoleh | 20 | Checklist OSCE; lembar interpretasi hasil pemeriksaan obstetri |

| Kode CPMK | Teknik/Instrumen | Indikator Penilaian (inti, terukur) | Bobot (%) | Bukti/Produk |
|---|---|---|---|---|
| CPMK-5 | Ujian interpretasi penunjang (case-based) | Klasifikasi hasil lab/USG (normal–abnormal) tepat; integrasi temuan penunjang dengan data klinis menghasilkan simpulan masalah yang logis | 12 | Lembar jawaban; lembar analisis kasus penunjang |
| CPMK-6 | Ujian berbasis skenario (OSCE/CBT) manajemen awal & rujukan | Tanda bahaya/komplikasi terdeteksi dan tingkat urgensi tepat; rencana tindakan awal, tindak lanjut, dan rujukan sesuai prioritas masalah | 20 | Checklist/lembar jawaban skenario; rencana tindak lanjut–rujukan |
| CPMK-7 | Role-play konseling (rubrik) + tugas dokumentasi (portofolio) | Pesan konseling terstruktur dan dipahami (terverifikasi); dokumentasi standar lengkap, konsisten, dan mendukung keputusan klinis | 10 | Video/lembar observasi konseling; SOAP/format ANC; cuplikan Buku KIA (simulasi) |

**Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**

**Rubrik CPMK-1**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Ketepatan mengaitkan komponen ANC standar dengan skenario | Banyak komponen kunci tidak tercantum/keliru; hubungan dengan skenario tidak jelas | Komponen utama tercantum namun ada beberapa kekeliruan; keterkaitan sebagian | Hampir seluruh komponen tepat; ada kekurangan minor pada detail/urutan | Seluruh komponen tepat dan lengkap; keterkaitan dengan skenario jelas dan konsisten |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Konsistensi langkah privasi–keselamatan pasien–pencegahan infeksi | Langkah inti terlewat; menimbulkan risiko keselamatan/privasi | Langkah dasar ada namun tidak runtut; masih ada celah risiko | Langkah sesuai prosedur; celah minor tidak berdampak kritis | Langkah sangat lengkap, runtut, dan proaktif mengantisipasi risiko serta menjaga privasi |

**Rubrik CPMK-2**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Kelengkapan dan sistematika anamnesis | Banyak data penting tidak digali; alur pertanyaan tidak terstruktur | Data penting sebagian tergali; alur masih meloncat | Data kunci tergali lengkap; alur terstruktur dengan kekurangan minor | Data kunci sangat lengkap; alur sangat sistematis, fokus, dan efisien |
| 2.2 Ketepatan identifikasi faktor risiko dan prioritas | Faktor risiko utama tidak dikenali/keliru; prioritas tidak tepat | Mengenali sebagian faktor risiko; prioritas belum konsisten | Mengenali faktor risiko utama; prioritas logis dengan kekurangan minor | Mengenali faktor risiko secara komprehensif; prioritas sangat tepat dan berorientasi keselamatan |

**Rubrik CPMK-3**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 Ketepatan prosedur tanda vital & antropometri | Langkah prosedur banyak salah/terlewat; hasil ukur tidak dapat dipercaya | Prosedur dasar dilakukan namun ada kesalahan yang memengaruhi akurasi | Prosedur benar dan aman; kesalahan minor tidak memengaruhi hasil utama | Prosedur sangat benar, konsisten, dan memastikan akurasi (verifikasi/ulang bila perlu) |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 Ketelitian pemeriksaan fisik umum & pencatatan | Pemeriksaan tidak sistematis; temuan tidak dicatat/keliru | Pemeriksaan cukup sistematis; pencatatan kurang lengkap | Pemeriksaan sistematis; pencatatan lengkap dengan kekurangan minor | Pemeriksaan sangat sistematis; pencatatan lengkap, jelas, dan relevan terhadap kondisi kehamilan |

**Rubrik CPMK-4**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Teknik pemeriksaan abdomen obstetri (Leopold/TFU) | Urutan/teknik salah; tidak menjaga kenyamanan/keamanan | Urutan benar sebagian; teknik kurang mantap sehingga hasil kurang konsisten | Urutan dan teknik benar; hasil dapat diandalkan dengan kekurangan minor | Urutan sangat benar, teknik mantap, komunikasi baik, dan hasil sangat konsisten |
| 4.2 Akurasi penilaian kesejahteraan janin (DJJ/gerak/pertumbuhan) | Tidak mampu memperoleh/menafsirkan data; simpulan tidak sesuai | Data diperoleh tetapi interpretasi sebagian keliru; simpulan kurang tepat | Data diperoleh dan ditafsirkan tepat; simpulan logis | Data sangat lengkap; interpretasi sangat tepat dan mampu mengaitkan dengan kebutuhan pemantauan lanjut |

**Rubrik CPMK-5**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Akurasi interpretasi laboratorium dasar | Salah mengklasifikasi hasil; implikasi klinis tidak tepat | Klasifikasi dasar benar sebagian; implikasi masih umum | Klasifikasi tepat; implikasi klinis sesuai konteks kasus | Klasifikasi sangat tepat; implikasi jelas, spesifik, dan terintegrasi dengan konteks |
| 5.2 Integrasi hasil USG/penunjang dengan temuan klinis | Tidak mengaitkan data penunjang dengan kondisi; simpulan tidak logis | Mengaitkan sebagian; simpulan masih lemah | Mengaitkan data penunjang–klinis secara logis; simpulan tepat | Integrasi sangat kuat; simpulan tajam dan mendukung keputusan tindak lanjut secara jelas |

**Rubrik CPMK-6**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Ketepatan deteksi masalah prioritas & urgensi | Tanda bahaya/komplikasi tidak dikenali; urgensi salah | Mengenali sebagian; klasifikasi urgensi belum konsisten | Mengenali masalah prioritas; urgensi tepat dengan kekurangan minor | Mengenali masalah secara komprehensif; urgensi sangat tepat dan berorientasi keselamatan |
| 6.2 Ketepatan tindakan awal, tindak lanjut, dan rujukan | Tindakan awal tidak sesuai; rujukan tidak tepat/terlambat | Tindakan awal cukup; rencana tindak lanjut/rujukan masih umum | Tindakan awal sesuai; rencana tindak lanjut/rujukan tepat | Tindakan awal sangat tepat dan terukur; rencana tindak lanjut/rujukan jelas, realistis, dan berbasis prioritas |

**Rubrik CPMK-7**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 Kualitas konseling (struktur pesan, empati, verifikasi pemahaman) | Pesan tidak terstruktur; empati minim; tidak ada verifikasi pemahaman | Pesan cukup terstruktur; verifikasi pemahaman terbatas | Pesan terstruktur, empatik; verifikasi pemahaman dilakukan | Pesan sangat terstruktur dan individual; empati kuat; verifikasi pemahaman efektif dan mendorong komitmen |
| 7.2 Kelengkapan & konsistensi dokumentasi standar | Banyak elemen inti hilang; inkonsisten dengan data; sulit ditelusuri | Elemen utama ada; masih ada kekurangan/inkonsistensi minor | Lengkap dan konsisten; mendukung keputusan klinis | Sangat lengkap, rapi, legal, dan sangat konsisten; keputusan klinis terdokumentasi dengan rasional jelas |

## Uraian Materi

### A. Perdarahan

Perdarahan pada kehamilan sendiri berarti perdarahan melalui vagina yang terjadi pada masa kehamilan, bukan perdarahan dari organ atau sistem lainnya. Pengelompokan perdarahan pada kehamilan tersebut secara praktis dibagi menjadi: perdarahan pada kehamilan muda, perdarahan sebelum melahirkan (antepartum hemoragik), dan perdarahan setelah melahirkan (postpartum hemoragik).

**1. Perdarahan Pervaginam Pada Kehamilan Muda**

Perdarahan pervaginam pada kehamilan muda adalah perdarahan yang terjadi sebelum kehamilan 22 minggu. World Health Organization (WHO) IMPAC menetapkan batas usia kehamilan kurang dari 22 minggu, namun beberapa acuan terbaru menetapkan batas usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Penyebab utama perdarahan pada kehamilan muda antara lain abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa.

a. Abortus

1) Pengertian

Abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di dunia luar, tanpa mempersoalkan sebabnya. Menurut WHO, abortus berarti keluarnya janin dengan berat janin < 500 gram atau usia kehamilan < 22 minggu. Abortus diartikan sebagai keluarnya hasil konsepsi ketika usia kehamilan < 20 minggu atau berat janin < 400 gram.

2) Etiologi

a) Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi.

Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi biasanya menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum usia 8 minggu. Faktor penyebab kelainan ini adalah:

- Kelainan kromosom
  Kelainan yang sering ditemukan pada abortus spontan ialah trisomi, poliploidi, kelainan kromosom sex serta kelainan kromosom lainnya.
- Lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna
  Bila lingkungan di endometrium di sekitar tempat implantasi kurang sempurna sehingga menyebabkan pemberian zat-zat makanan pada hasil konsepsi terganggu.
- Pengaruh dari luar
  Adanya pengaruh dari radiasi, virus, obat-obat, dan sebagainya dapat mempengaruhi baik hasil konsepsi maupun lingkungan hidupnya dalam uterus. Pengaruh ini umumnya dinamakan pengaruh teratogen.

b) Kelainan pada plasenta

End-arteritis dapat terjadi dalam vili korialis dan menyebabkan oksigenasi plasenta terganggu, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematian janin. Keadaan ini bisa terjadi sejak kehamilan muda misalnya karena hipertensi menahun.

c) Faktor maternal

- Infeksi

  Beresiko bagi janin yang sedang berkembang, terutama pada akhir trimester pertama atau awal trimester kedua. Penyebab kematian janin tidak diketahui secara pasti akibat infeksi janin atau oleh toksin yang dihasilkan mikroorganisme penyebab infeksi. Penyakit yang dapat menyebabkan abortus antara lain:

  - Virus – Rubella, sitomegalovirus, herpes simpleks, varicella zoster, vaccinia, campak, hepatitis, polio, ensefalomielitis.
  - Bakteri – Salmonella typhi
  - Parasit – Toxoplasma gondii, plasmodium

- Penyakit vaskular – Hipertensi, penyakit jantung.
- Kelainan endokrin – Abortus spontan dapat terjadi bila produksi progesteron tidak mencukupi, terjadi disfungsi tiroid, atau defisiensi insulin.
- Imunologi – Ketidakcocokan (inkompatibilitas) sistem HLA (Human Leukocyte Antigen), SLE (Systemic Lupus Erythematosus).
- Trauma – Jarang terjadi, umumnya segera setelah trauma, misalnya trauma akibat pembedahan:
  - Pengangkatan ovarium yang mengandung korpus luteum graviditatum sebelum minggu ke – 8.
  - Pembedahan intraabdominal dan pembedahan uterus pada saat hamil.
- Kelainan uterus – Hipoplasia uterus, mioma (terutama mioma submukosa), serviks inkoompeten atau retroflexio uteri gravidii incarcerata.
- Psikosomatik – Pengaruh faktor ini masih dipertanyakan.

d) Kelainan traktus genitalia

Retroversi uteri, mioma uteri, atau kelainan bawaan uterus dapat menyebabkan abortus.

3) Patologi

Pada awal abortus terjadilah perdarahan dalam desidua basalis kemudian diikuti oleh nekrosis jaringan di sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan hasil konsepsi terlepas sebagian atau seluruhnya, sehingga menjadi benda asing dalam uterus. Keadaan ini menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya.

Pada kehamilan kurang dari 8 minggu, hasil konsepsi biasanya dikeluarkan seluruhnya karena villi korialis belum menembus desidua secara mendalam. ebelum minggu ke-10 seluruh hasil konsepsi biasanya dapat keluar dengan lengkap karena villi korialis belum menanamkan diri dengan erat ke dalam desidua. Pada kehamilan 10 – 12 minggu, korion tumbuh cepat dan hubungan antara vili korialis dengan desidua makin erat, sehingga abortus yang mulai di saat ini sering menyisakan korion (plasenta). Pengeluaran hasil konsepsi didasarkan atas 4 cara:

- Kantung korion keluar pada kehamilan yang sangat dini, meninggalkan sisa desidua.
- Kantung amnion dan isinya (janin) didorong keluar, meninggalkan korion dan desidua.
- Pecah amnion disertai putusnya tali pusat dan pendorongan janin keluar , tetapi sisa amnion dan korion tetap tertinggal (hanya janin yang dikeluarkan).
- Seluruh janin dan desidua yang melekat didorong keluar secara utuh

Pada kehamilan antara 8 sampai 14 minggu villi korialis menembus desidua lebih dalam, sehingga umumnya plasenta tidak terlepas sempurna yang dapat menyebabkan banyak perdarahan. Pada kehamilan 14 minggu keatas umumnya dikeluarkan setelah ketuban pecah ialah janin, disusul beberapa waktu kemudian plasenta. Hasil konsepsi keluar dalam berbagai bentuk, seperti kantong kosong amnion atau benda kecil yang tidak jelas bentuknya (blighted ovum), janin lahir mati, janin masih hidup, mola kruenta, fetus kompresus, maserasi, atau fetus papiraseus.

4) Klasifikasi

Abortus dapat digolongkan atas dasar:

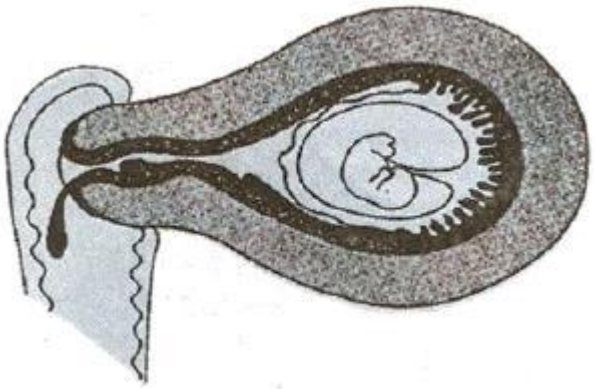
a) Abortus Spontan

- Abortus imminens;

  Merupakan peristiwa terjadinya perdarahan pervaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks. Adanya abortus imminens terlihat pada gambar .

Diagnosis abortus imminens ditentukan dari:

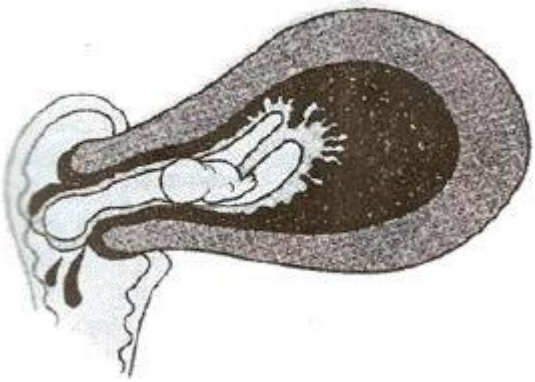
- Terjadinya perdarahan melalui ostium uteri eksternum dalam jumlah sedikit;
- Disertai sedikit nyeri perut bawah atau tidak sama sekali;
- Uterus membesar, sesuai masa kehamilannya;
- Serviks belum membuka, ostium uteri masih tertutup;
- Tes kehamilan (+)



**Gambar 2.1. abortus imminens**

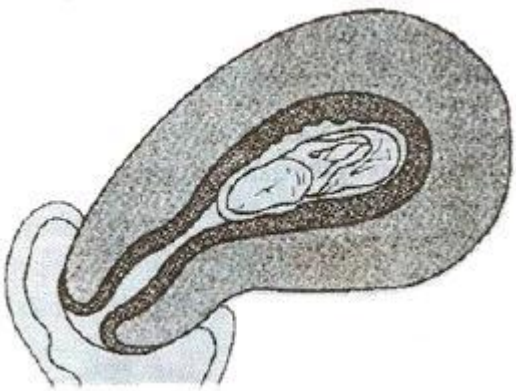
- Abortus insipiens;

  Merupakan peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan kurang dari 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks yang meningkat dan ostium uteri telah membuka, tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus. Dalam hal ini rasa mules menjadi lebih sering dan kuat, perdarahan bertambah. Ciri dari jenis abortus ini yaitu perdarahan pervaginam dengan kontraksi makin lama makin kuat dan sering, serviks terbuka, besar uterus masih sesuai dengan umur kehamilan dan tes urin kehamilan masih positif.



**Gambar 2.2 Abortus Insipien**

- Missed abortion;
  Tertahannya hasil konsepsi yang telah mati didalam rahim selama ≥8 minggu. Ditandai dengan tinggi fundus uteri yang menetap bahkan mengecil, biasanya tidak diikuti tanda–tanda abortus seperti perdarahan, pembukaan
  serviks, dan kontraksi.



**Gambar 2.3 Missed Abortion**

- Abortus habitualis;
  Merupakan abortus spontan yang terjadi 3x atau lebih secara berturut-turut. Pada umumnya penderita tidak sulit untuk menjadi hamil, tetapi kehamilan berakhir sebelum mencapai usia 28 minggu.
  Etiologi abortus habitualis yaitu :
  - Kelainan dari ovum atau spermatozoa, dimana kalau terjadi pembuahan hasilnya adalah pembuahan patologis.
  - Kesalahan-kesalahan pada ibu yaitu disfungsi tiroid, kesalahan korpus luteum, kesalahan plasenta, yaitu tidak sanggupnya plasenta menghasilkan progesteron sesudah korpus luteum atrofi. Ini dapat dibuktikan dengan mengukur kadar pregnadiol dalam urin. Selain itu juga bergantung pada gizi ibu (malnutrisi), kelainan anatomis dalam rahim, hipertensi oleh karena kelainan pembuluh darah sirkulasi pada plasenta/vili terganggu dan fetus menjadi mati. Dapat juga gangguan psikis, serviks inkompeten, atau rhesus antagonisme.
  - Kelainan kromosom. Diketahui bahwa adanya trisomi pada kromosom ke 9, 12, 15, 16, 21, 22 dan X akan menyebabkan anomali genetik pada kejadian abortus habitualis.
- Abortus infeksiosa & Septik;

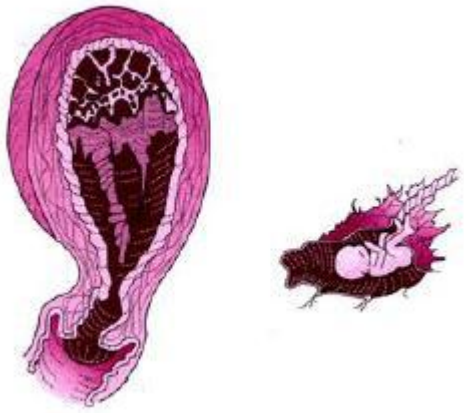
Abortus infeksius adalah abortus yang disertai infeksi pada genitalia bagian atas termasuk endometritis atau parametritis. Abortus septik juga merupakan komplikasi yang jarang terjadi akibat prosedur abortus yang aman.

Abortus septik adalah abortus infeksius berat disertai penyebaran kuman atau toksin ke dalam peredaran darah atau peritonium. Infeksi dalam uterus/sekitarnya dapat terjadi pada tiap abortus, tetapi biasanya ditemukan pada abortus inkomplet dan lebih sering pada abortus buatan yang dikerjakan tanpa memperhatikan asepsis dan antisepsis.

Diagnosis abortus infeksius ditentukan dengan adanya abortus yang disertai gejala dan tanda infeksi alat genital seperti panas, takikardi, perdarahan pervaginam yang lama atau bercak perdarahan, discharge vagina atau serviks yang berbau busuk, uterus lembek, serta nyeri perut dan pelvis serta leukositosis. Apabila terdapat sepsis, penderita tampak sakit berat atau kadang menggigil, demam tinggi, dan penurunan tekanan darah

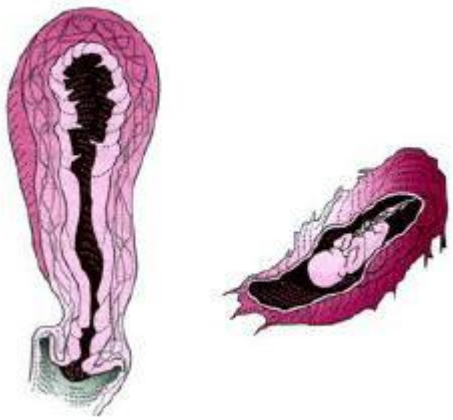
- Abortus inkompletus;

  Merupakan pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Perdarahan abortus ini dapat banyak sekali dan tidak berhenti sebelum hasil konsepsi dikeluarkan. Ciri dari jenis abortus ini yaitu perdarahan yang banyak disertai kontraksi, kanalis servikalis masih terbuka, dan sebagian jaringan keluar.



**Gambar 2.4 Abortus Inkompletus**

- Abortus Kompletus.
  Abortus kompletus terjadi dimana semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan. Pada penderita ditemukan perdarahan sedikit, ostium uteri sebagian besar telah menutup, dan uterus sudah banyak mengecil. Ciri dari abortus ini yaitu perdarahan pervaginam, kontraksi uterus, ostium serviks menutup, dan tidak ada sisa konsepsi dalam uterus.



**Gambar 2.5 Abortus Kompletus**

b) Abortus Provakatus (induced abortion)

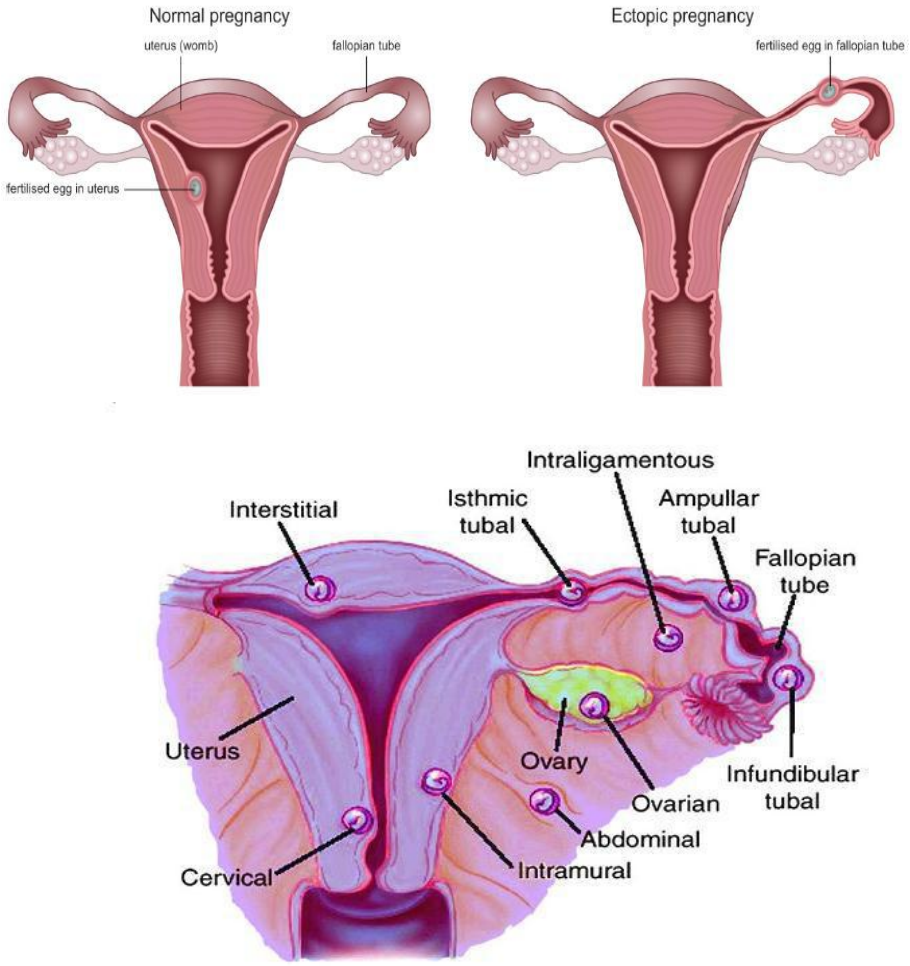
- Abortus Medisinalis (abortus therapeutica)
  Abortus medisinalis adalah abortus karena tindakan kita sendiri, dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan, dapat membahayakan jiwa ibu (berdasarkan indikasi medis)
- Abortus Kriminalis
  Abortus kriminalis adalah abortus yang terjadi oleh karena tindakantindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis.

b. Kehamilan Ektopik

**Definisi**

Kehamilan ektopik didefinisikan sebagai suatu kehamilan yang pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada dinding endometrium kavum uteri, tetapi biasanya menempel pada daerah didekatnya.

Kehamilan ekstrauterin tidak sinonim dengan kehamilan ektopik karena kehamilan pada pars interstitialis tuba dan kanalis servikalis masih termasuk dalam uterus tetapi jelas bersifat ektopik.




**Gambar 2.6 Kehamilan ektopik**

**Patologi**

Proses implantasi ovum yang dibuahi yang terjadi di tuba pada dasarnya sama dengan halnya di kavum uteri. Telur di tuba bernidasi secara kolumner atau interkolumner. Implantasi secara kolumner yaitu telur berimplantasi pada ujung atau sisi jonjot endosalping. Perkembangan telur selanjutnya dibatasi oleh kurangnya vaskularisasi dan biasanya telur mati secara dini dan kemudian diresorpsi. Pada nidasi secara interkolumner telur bernidasi antara dua jonjot endosalping. Setelah tempat nidasi tertutup, maka telur dipisahkan dari lumen tuba oleh lapisan jaringan yang menyerupai desidua dan dinamakan pseudokapsularis. Karena pembentukan desidua di tuba tidak sempurna, dengan mudah vili korialis menembus endosalping dan masuk ke dalam lapisan otot-otot tuba dengan merusak jaringan dan pembuluh darah. Perkembangan janin selanjutnya bergantung pada beberapa faktor, seperti tempat implantasi, tebalnya dinding tuba dan banyaknya perdarahan yang terjadi oleh invasi trofoblas. Di bawah pengaruh hormon estrogen dan progesteron dari korpus luteum graviditas dan trofoblas, uterus menjadi besar

dan lembek. Endometrium dapat pula berubah menjadi desidua. Setelah janin mati, desidua dalam uterus mengalami degenerasi dan kemudian dikeluarkan berkeping-keping atau dilepaskan secara utuh. Perdarahan pervaginam yang dijumpai pada kehamilan ektopik terganggu berasal dari uterus dan disebabkan oleh pelepasan desidua yang degeneratif.

c. Mola Hidatidosa

**Definisi**

Mola berasal dari bahasa latin yang artinya massa dan hidatidosa
berasal dari kata hydats yang berarti tetesan air. Mola hidatidosa merupakan kehamilan yang berkembang tidak wajar (konsepsi yang patologis) dimana tidak ditemukan janin dan hampir seluruh vili korialis mengalami perubahan/degenerasi hidropik menyerupai buah anggur atau mata ikan. Dalam hal demikian disebut Mola Hidatidosa atau Complete mole, sedangkan bila disertai janin atau bagian janin disebut sebagai Mola Parsialis atau Partial mole.

Etiologi dan Faktor Risiko

Penyebab dari mola tidak diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya mola:

1) Faktor ovum yang memang sudah patologik, tetapi terlambat untuk dikeluarkan;
2) Imunoselektif dari trofoblas;
3) Keadaan sosio-ekonomi yang rendah;
4) Malnutrisi, defisiensi protein, asam folat, karoten, vitamin, dan lemak hewani;
5) Paritas tinggi;
6) Umur, risiko tinggi kehamilan dibawah 20 atau diatas 40 tahun;
7) Infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas;
8) Suku bangsa (ras) dan faktor geografi yang belum jelas.

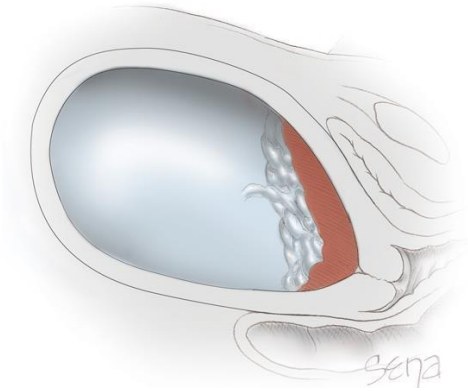
**2. Perdarahan Antepartum**

Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi setelah minggu ke 28 masa kehamilan. Atau Perdarahan antepartum merupakan perdarahan yang berasal dari traktus genitalia setelah usia kehamilan 24 minggu dan sebelum onset pelahiran janin.

a. Plasenta Previa

**Definisi**

Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sedemikia rupa sehingga berdekatan atau menutupi ostium uteri internum secara partial maupun total.



**Gambar 2.7 plasenta previa total yang memperlihatkan kemungkinan terjadinya perdarahan dalam jumlah besar meski pada pembukaan serviks yang kecil**

**Etiologi**

Etiologi plasenta previa belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor risiko telah ditetapkan sebagai kondisi yang berhubungan dengan terjadinya plasenta previa. Faktor risiko tersebut meliputi hamil usia tua, multiparitas, kehamilan ganda, merokok selama masa kehamilan, janin laki-laki, riwayat aborsi, riwayat operasi pada uterus, riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya dan IVF. Penyebab blastokista berimplantasi pada segmen bawah rahim belum diketahui dengan pasti. Mungkin secara kebetulan saja blastokista menimpa desidua didaerah segmen bawah rahim tanpa latar belakang lain yang mungkin. Teori lain mengemukakan sebagai salah satu penyebabnya adalah vaskularisasi desidua yang tidak
memadai mungkin akibat dari proses radang atau atrofi.

Beberapa kondisi terkait plasenta previa yaitu :

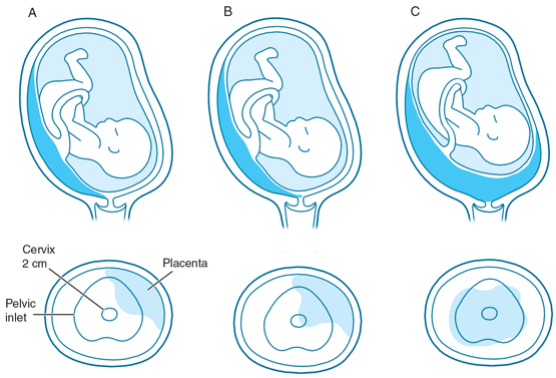
1) Usia ibu yang semakin lanjut meningkatkan risiko plasenta previa. Insiden plasenta previa meningkat secara bermakna pada setiap peningkatan kelompok usia ibu. Insiden ini sebesar 1 dalam 1500 pada perempuan berusia ≤ 19 tahun dan sebesar 1 diantara 100 pada perempuan berusia lebih dari 35 tahun.
2) Multiparitas juga berkaitan dengan peningkatan risiko plasenta previa. Angka kejadian plasenta previa 40% lebih tinggi pada kehamilan dengan janin multipel dibandingkan janin tunggal.
3) Untuk alasan yang tidak diketahui, riwayat pelahiran caesar meningkatkan risiko plasenta previa. Peningkatan risiko plasenta previa sebanyak 3 kali lipat pada perempuan yang pernah menjalani pelahiran caesar.
4) Risiko relatif plasenta previa dilaporkan meningkat sebanyak dua kali lipat pada perempuan yang merokok. Dibuat teori bahwa hipoksia karbon

monoksida menyebabkan hipertrofi plasenta kompensatoris. Yang mungkin terkait terganggunya vaskularisasi desidua, mungkin akibat perubahan atrofik atau peradangan, terlibat dalam terjadinya plasenta previa.

**Klasifikasi**

Terdapat beberapa kemungkinan implantasi plasenta pada plasenta previa:

1) Plasenta previa totalis/komplit: Plasenta yang menutupi seluruh ostium uteri internum
2) Plasenta previa parsialis: Plasenta yang menutupi sebagian ostium uteri internum
3) Plasenta previa marginalis: Plasenta yang tepinya pada pinggir ostium uteri internum
4) Plasenta letak rendah: Plasenta berimplantasi pada segmen bawah rahim dimana tepi plasenta berjarak < 2 cm dari ostium uteri internum.

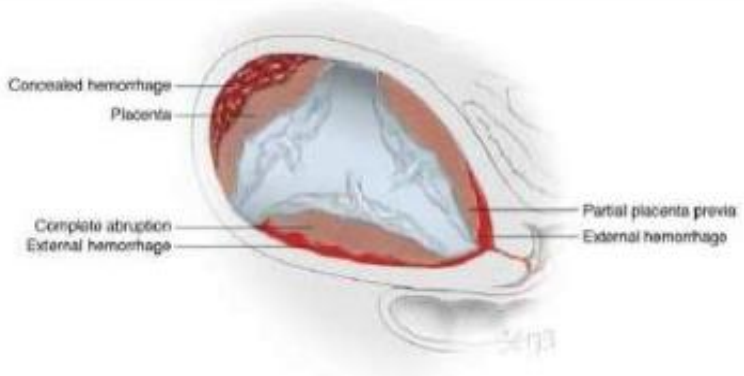



**Gambar 2.8. Klasifikasi plasenta previa**

b. Solutio Plasenta

**Definisi**

Solusio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya yang normal pada lapisan desidua endometrium sebelum waktunya. Istilah lain dari solusio plasenta adalah *ablatio plasentae*, *abruptio plasentae*, *accidental haemorrhage* dan *prematur separation of the normally implanted placenta*.




**Gambar 2.9. Tipe Solusio Plasenta**

**Klasifikasi**

Dalam klinis solusio plasenta dibagi ke dalam berat ringannya gambaran klinik sesuai dengan luasnya permukaan plasenta yang terlepas, yaitu solutio plasenta ringan, solusio plasenta sedang, dan solusio plasenta berat.

1) Solusio plasenta ringan

   Kurang lebih 30-40% penderita solusio plasenta ringan tidak atau sedikit terlihat gejala. Luas plasenta yang terlepas tidak sampai 25%, atau ada yang menyebutkan kurang dari 1/6 bagian. Pada keadaan yang sangat ringan tidak ada gejala kecuali hematom yang berukuran beberapa sentimeter terdapat pada permukaan maternal plasenta. Perdarahan vagina bisa tidak ada hingga sedikit (< 100 mL). Rasa nyeri pada perut masih ringan dan darah yang keluar masih sedikit, sehingga belum keluar melalui vagina. Nyeri yang belum terasa menyulitkan membedakannya dengan plasenta previa kecuali darah yang keluar bewarna merah segar pada plasenta previa. Tanda-tanda vital dan keadaan umum ibu maupun janin masih baik. Pada inspeksi dan auskultasi tidak dijumpai kelainan kecuali pada palpasi sedikit terasa nyeri lokal pada tempat terbentuk hematom dan perut sedikit tegang tapi bagian-bagian janin masih dapat dikenal. Kadar fibrinogen darah dalam batas-batas normal yaitu 350 mg%. Walaupun belum memerlukan intervensi segera, keadaan yang ringan ini perlu dimonitor terus sebagai upaya mendeteksi keadaan bertambah berat.

2) Solusio plasenta sedang

   Luas plasenta yang terlepas telah melebihi 25%, tetapi belum mencapai separuhnya (50%). Gejala-gejala dan tanda-tanda sudah jelas seperti rasa nyeri pada perut yang terus menerus, dan denyut jantung janin biasanya telah menunjukkan gawat janin, perdarahan yang tampak keluar lebih banyak (100-500 mL), takikardia, hipotensi, kulit dingin, dan keringatan, oliguria mulai ada, kadar fibrinogen berkurang antara 150 - 250 mg/100 ml, dan mungkin kelainan pembekuan darah dan gangguan fungsi ginjal sudah mulai ada. Rasa nyeri datangnya akut kemudian menetap tidak bersifat hilang timbul seperti pada his yang normal. Perdarahan pervaginam jelas dan bewarna kehitaman, penderita pucat karena mulai ada syok sehingga keringat dingin. Keadaan janin biasanya sudah gawat. Pada stadium ini bisa jadi telah timbul his dan persalinan telah mulai. Pada pemantauan keadaan janin dengan kardiotokografi bisa jadi telah ada deselarasi lambat. Bila terminasi persalinan terlambat atau fasilitas perawatan intensif neonatus tidak memadai, kematian perinatal dapat dipastikan terjadi.

3) Solusio plasenta berat

Luas plasenta yang terlepas sudah melebihi 50%. Perut sangat nyeri dan tegang serta keras seperti papan (defans musculaire) disertai perdarahan yang berwarna hitam (>500 mL). Oleh karena itu palpasi bagian-bagian janin tidak mungkin lagi dilakukan. Fundus uteri lebih tinggi daripada yang seharusnya oleh karena telah terjadi penumpukan darah di dalam rahim pada kategori concealed hemorrhage. Jika dalam masa observasi tinggi fundus bertambah lagi berarti perdarahan baru masih berlangsung. Pada auskultasi denyut jantung janin tidak terdengar lagi akibat gangguan anatomik dan fungsi dari plasenta. Keadaan umum menjadi buruk disertai syok. Adakalanya keadaan umum ibu jauh lebih buruk dibandingkan perdarahan yang tidak seberapa keluar dari vagina. Hipofibrinogenemia dan oliguria boleh jadi telah ada sebagai akibat komplikasi pembekuan darah intravaskular yang luas (disseminated intravascular coagulation), dan gangguan fungsi ginjal. Kadar fibrinogen darah rendah yaitu kurang dari 150 mg% dan telah ada trombositopenia.

**Patofisiologi**

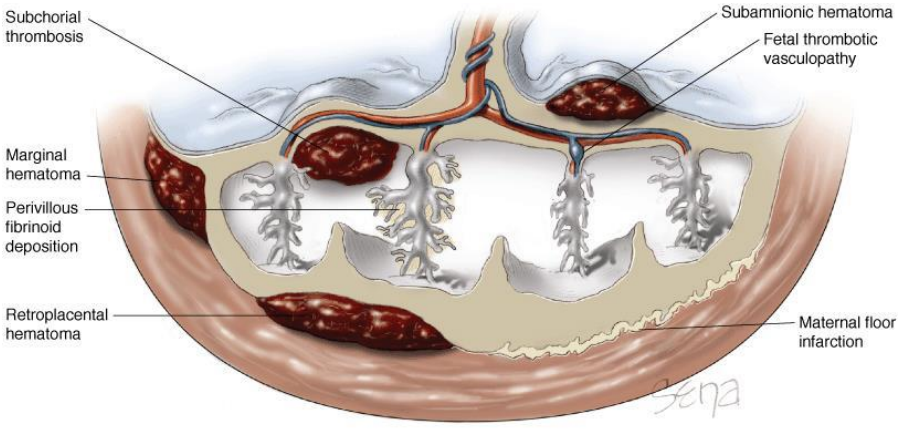
Solusio plasenta dimulai oleh pedarahan kedalam desidua basalis akibat cedera vaskular lokal. Desidua kemudian memisah, meninggalkan lapisan tipis yang melekat ke miometrium. Karena itu, proses dalam tahap paling awal terdiri atas pembentukan hematoma desidua yang menyebabkan pemisahan, kompresi, dan akhirnya menghancurkan plasenta didekatnya.

Ditemukan adanya bukti histologis peradangan yang lebih banyak terlihat pada kasus solusio plasenta dibandingkan pada kontrol normal. Sebagai kemungkinan lain, areteri spiralis dapat ruptur, menciptakan hematoma retroplasenta. Pada kasus ini, terjadi perdarahan, terbentuk bekuan, dan permukaan plasenta tidak dapat lagi menyediakan pertukaran metabolik antara ibu dan janin.

Dalam tahap dini, mungkin tidak ditemukan gejala-gejala klinis, dan pemisahan hanya ditemukan pada saat pemeriksaan plasenta yang baru dilahirkan. Pada kasus-kasus seperti ini, terdapat cekungan berbatas tegas pada permukaan maternal plasenta. Cekungan ini biasanya berdiameter beberapa sentimeter dan ditutupi darah yang telah membeku dan berwarna gelap.

Pada kondisi tertentu arteri spiralis desidua pecah dan menimbulkan hematoma retroplasenta yang pada saat bertambah besar merusak lebih banyak lagi pembuluh darah sehingga lebih banyak plasenta yang terpisah. Daerah terpisanya plasenta dengan cepat meluas dan mencapai tepi plasenta.

Karena uterus masih membesar, akibat produk konsepsi uterus tidak mampu berkontraksi secara adekuat untuk menekan pembuluh darah yang robek yang memperdarahi lokasi plasenta. Darah yang keluar dapat menyebabkan diseksi membran dari dinding uterus dan akhirnya tampak dari luar atau tertahan sepenuhnya dalam uterus.




Source: Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY: *Williams Obstetrics, 23rd Edition*: http://www.accessmedicine.com
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Potential sites of placental circulatory disturbances. (Adapted from Faye-Peterson and colleagues, 2006.)

**Gambar 2.10. Sisi plasenta yang potensial untuk terjadinya gangguan sirkulasi**

Faktor mekanikal jarang meyebabkan pemisahan plasenta prematur (1-5%). Temasuk didalamnya trauma abdomen, dekompresi tiba-tiba dari uterus misalnya seperti pelahiran bayi kembar pertama, atau ruptur membran pada hidramnion, atau traksi pada tali pusar yang pendek.

Mekanisme lain yang mungkin adalah dimulainya kaskade kooagulasi. Hal ini dapat terjadi contohnya pada trauma yang menyebabkan pelepasan tromboplastin jaringan. Aktivasi faktor koagulasi ini pada saatnya dapat berperan untuk memulai pembentukan bekuan pada hemodinamik yang stasis terjadi pada placenta pool.

Perdarahan terselubung atau tertahan (tersamar) mungkin terjadi bila :

1) Terdapat efusi darah dibelakang plasenta, tetapi tepinya masih tetap melekat
2) Plasenta sepenuhnya terpisah tapi membran masih melekat ke dinding uterus
3) Darah memperoleh akses ke rongga amnion setelah menembus membran
4) Kepala janin memenuhi segmen bawah uterus sehingga darah tidak bisa lewat Namun yang paling sering terjadi adalah membran secara bertahap terdiseksi lepas dari dinding uterus dan darah cepat atau lambat akan mengalir ke luar. Perdarahan janin yang bermakna jauh lebih mungkin

terjadi pada solusio traumatik. Pada kondisi ini, perdarahan janin terjadi akibat robekan atau fraktur dalam plasenta, bukan akibat pemisahan plasenta itu sendiri perdarahan janin rata-rata bervolume 12 mL.

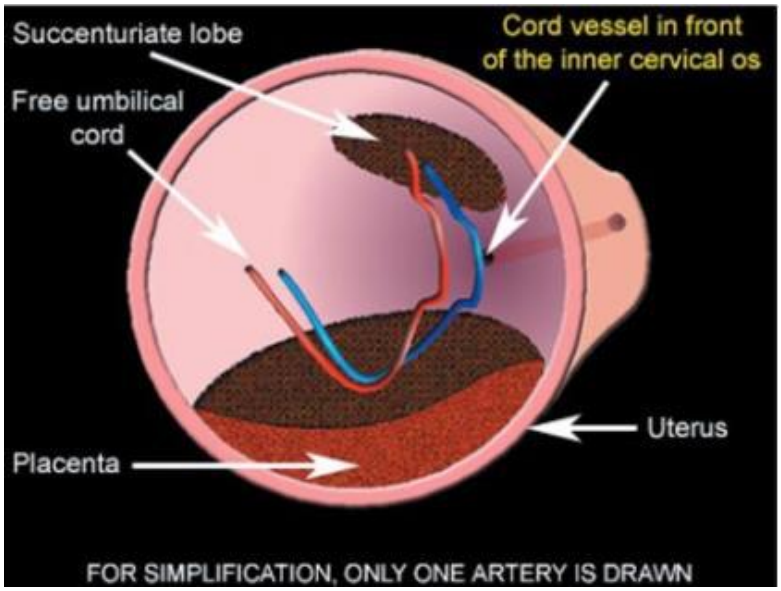
c. Vasa Previa

**Definisi**

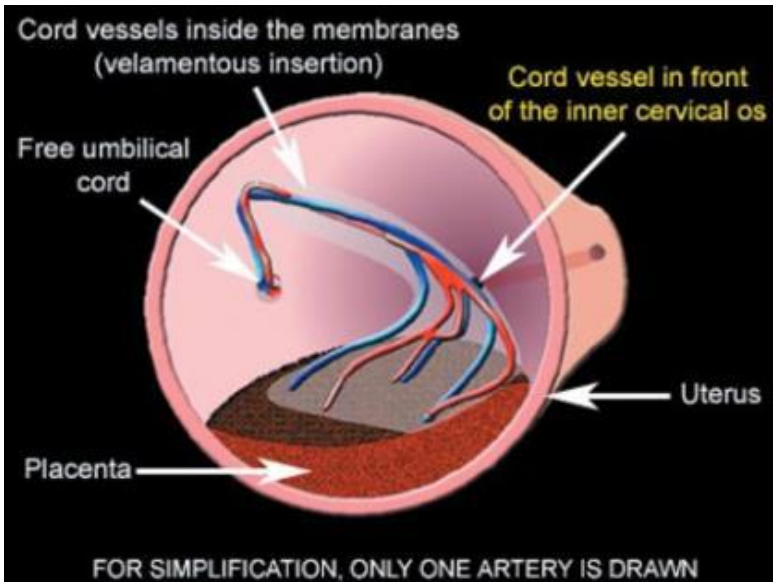
Vasa previa adalah keadaan dimana pembuluh darah janin berada didalam selaput ketuban dan melewati ostium uteri internum untuk kemudian sampai ke dalam insersinya di tali pusat.Perdarahan terjadi bila selaput ketuban yang melewati pembukaan serviks robek atau pecah dan vaskular janinpun ikut terputus. Vasa Previa adalah suatu kondisi pembuluh darah janin yang menyilang atau berjalan pada ostium internum cervix. Pembuluh pembuluh darah ini berada dalam membran (tidak didukung oleh tali pusat atau jaringan plasenta) dan beresiko pecah ketika suplai membran pecah.

Etiologi dan Patofisiologi

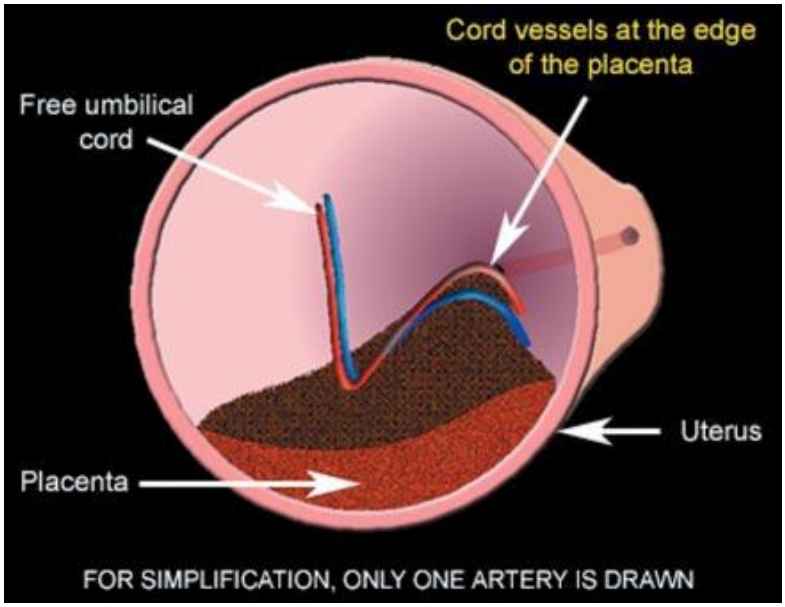
Penyebab utama vasa previa adalah insersi velamentous (di mana tali menyisip langsung ke dalam membran, meninggalkan pembuluh darah yang tidak terlindungi berjalan ke plasenta) dan pembuluh darah yang melintasi lobus plasenta seperti pada plasenta succenturiate atau bilobate. Penyebab yang jarang terjadi, pembuluh darah yang mengarah ke tepi plasenta marjinal atau plasenta previa dapat menjadi vasa previa setelah perpanjangan plasenta di atas daerah vaskularisasi yang lebih baik (trophotropism) dan involusi dari kotiledon.




**Gambar 2.11. Plasenta Succenturiata menunjukkan pembuluh darah diantara lobus utama dan succenturiata melintasi ostium internum cervix**




**Gambar 2.12. Insersi vilamentous dari tali pusat**




**Gambar 2.13. Plasenta marginal dengan pembuluh darah yang berjalan di tepi plasenta dan melintasi ostium internum cervix.**

## B. Nyeri Hebat

Berbagai macam penyakit, termasuk gangguan pada sistem obstetri, ginekologi, gastrointestinal, hepatobilier, genitourinari, dan vaskular, dapat muncul sebagai nyeri perut selama kehamilan. Diagnosis klinis penyakit intraabdominal pada wanita hamil seringkali terhalang oleh perubahan fisiologis dan anatomi ibu yang terjadi bersamaan. Rasa nyeri pada peritonitis mungkin tidak terjadi karena hilangnya elastisitas otot dinding perut [2]. Leukositosis pada kehamilan kurang bermanfaat dalam evaluasi klinis karena jumlah sel darah putih biasanya meningkat selama kehamilan, berkisar antara 6.000–16.000 sel/µL selama trimester pertama dan kedua hingga 20–30.000 sel/µL pada akhir trimester ketiga [3]. Kompresi ureter

dan perpindahan organ intraabdominal, termasuk usus buntu, oleh rahim yang membesar juga dapat membingungkan presentasi klinis.

**Penyebab :**

Selama trimester pertama kehamilan, penyebab umum nyeri perut dan panggul meliputi abortus dan kehamilan ektopik. Selama trimester kedua dan ketiga, penyebab nyeri meliputi persalinan prematur dan komplikasi yang kurang umum, tetapi lebih parah, yaitu abrupsi plasenta dan ruptur uterus.

**1. Abortus**

Keguguran spontan terjadi pada sekitar 10–12% kehamilan trimester pertama yang diketahui. Meskipun pasien mungkin tidak menunjukkan gejala, keguguran spontan umumnya mengakibatkan nyeri dan perdarahan vagina.

Ultrasonografi dapat mengkonfirmasi keguguran dini dengan spesifisitas tinggi jika tidak ada aktivitas jantung janin yang terdeteksi pada saat embrio berukuran 5 mm atau jika kehamilan diketahui berusia 6,5 minggu tanpa embrio dengan detak jantung.

**2. Kehamilan ektopik**

Kehamilan ektopik seringkali ditandai dengan nyeri perut atau panggul pada trimester pertama. Ultrasonografi berperan mengkonfirmasi kehamilan intrauterin. Kehamilan heterotopik, yaitu kehamilan ektopik dan intrauterin yang terjadi bersamaan, jarang terjadi (1 dari 7.000) pada populasi umum. Namun, insiden kehamilan heterotopik lebih tinggi setelah fertilisasi in vitro, mendekati 1% dalam beberapa penelitian.

**3. Abrupsio Plasenta**

Gejala abrupsio plasenta bervariasi meliputi perdarahan vagina dan nyeri perut atau panggul. Abrupsio plasenta didefinisikan sebagai pemisahan plasenta dari miometrium di dalam rahim dan menyumbang 10–25% kematian prenatal. Dalam kebanyakan kasus, USG tidak menunjukkan tanda-tanda abrupsio karena perdarahan akibat pemisahan plasenta dapat melewati ostium serviks. Temuan sonografi yang menunjukkan abrupsio plasenta, jika terlihat, biasanya disebabkan oleh hematoma. Visualisasi hematoma secara klinis penting karena kehamilan memiliki prognosis jelek. Lokasi hematoma yang paling umum dalam kondisi ini adalah subkorionik (yaitu, di antara dinding rahim dan membran korionik). Hematoma retroplasenta (di belakang plasenta) dan preplasenta (di depan plasenta) kurang umum.

**4. Persalinan Prematur**

Persalinan prematur didefinisikan sebagai kontraksi uterus yang cukup kuat untuk menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks antara usia kehamilan 20 dan 37 minggu. Nyeri perut yang menyertai kontraksi ini seringkali dapat dibedakan

secara klinis, sehingga pencitraan biasanya tidak diindikasikan untuk diagnosis. Semakin pendek ukuran panjang serviks, semakin tinggi risiko kelahiran prematur. Selain itu, semakin dini ditemukannya pemendekan panjang serviks, semakin tinggi risiko kelahiran prematur. Panjang serviks normal lebih dari 30 mm antara usia kehamilan 14 dan 30 minggu. Pelebaran serviks juga dikaitkan dengan peningkatan risiko persalinan prematur. Pelebaran serviks terjadi ketika ostium internal terbuka di bagian proksimal dan secara bertahap menyempit, menyerupai bentuk kerucut. Jika pelebaran serviks ada, panjang serviks hampir selalu memendek. Namun, keberadaan pelebaran serviks pada pasien dengan panjang serviks normal tidak meningkatkan risiko kelahiran prematur.

**5. Ruptur Uteri**

Ruptur uteri adalah kejadian langka dan katastropik yang seringkali ditandai dengan nyeri perut hebat. Faktor predisposisi meliputi riwayat operasi uterus sebelumnya, termasuk persalinan sesar dan miomektomi, serta malformasi uterus kongenital. Ruptur uteri dapat terjadi selama persalinan atau sebelum persalinan, seperti pada kasus kehamilan ektopik interstisial yang mengalami ruptur.

**6. Penyebab Ginekologi**

Penyebab ginekologis umum nyeri selama kehamilan meliputi komplikasi yang berhubungan dengan massa adneksa, torsi ovarium, dan leiomioma. Massa adneksa sering kali pertama kali terdeteksi pada saat pemeriksaan ultrasonografi rutin trimester pertama atau di trimester kedua.

**7. Massa Adneksa**

Massa adneksa terjadi pada sekitar 2% dari semua kehamilan. Massa adneksa bukanlah penyebab nyeri yang umum, dengan 65% dari massa ini bersifat asimtomatik dan ditemukan secara tidak sengaja pada pemeriksaan fisik atau sonografi. Ukuran massa juga tidak selalu menentukan apakah akan menyebabkan nyeri. Namun, jika massa adneksa tertekan, jika menekan organ atau organ yang berdekatan, seperti yang lebih mungkin terjadi selama kehamilan yang berhubungan dengan pembesaran rahim, atau jika menjadi rumit karena torsi, perdarahan, atau ruptur, massa adneksa dapat menimbulkan nyeri.

**8. Torsi Ovarium**

Insiden torsi ovarium meningkat selama kehamilan, memperumit 1 dari 800 kehamilan. Peningkatan insiden ini kemungkinan besar terkait dengan peningkatan insiden massa adneksa. Hingga 7% massa adneksa dilaporkan menyebabkan torsi ovarium selama kehamilan. Namun, torsi juga dapat terjadi pada ovarium yang normal, biasanya ovarium kanan. Selama kehamilan, torsi ovarium paling sering terjadi antara usia kehamilan 6 dan 14 minggu ketika

pembesaran rahim paling cepat. Menurut penelitian, hingga 45% kasus torsi ovarium terjadi selama trimester kedua dan ketiga.

**9. Leiomioma**

Leiomioma uterus sering ditemui selama kehamilan, dengan 1 dari 500 wanita hamil dirawat di rumah sakit karena komplikasi terkait leiomioma. Sekitar setengah dari semua leiomioma tumbuh selama kehamilan, terutama pada trimester pertama karena peningkatan kadar estrogen. Nyeri perut dan kontraksi uterus dapat terjadi akibat nekrosis dan degenerasi leiomioma sekunder akibat pertumbuhan yang cepat. "Degenerasi merah" adalah jenis degenerasi yang paling umum selama kehamilan dan terjadi ketika leiomioma melebihi pasokan darahnya sehingga menyebabkan perdarahan.

**10. Nyeri Gastrointestinal**

Penyebab nyeri gastrointestinal selama kehamilan meliputi apendisitis dan proses inflamasi, infeksi, dan obstruktif lainnya pada usus. Penyakit-penyakit ini tidak hanya terjadi pada kehamilan atau lebih umum terjadi pada kehamilan, tetapi diagnosisnya bisa lebih sulit selama kehamilan.

**11. Appendisitis**

Apendisitis adalah penyebab non-obstetri paling umum untuk operasi darurat selama kehamilan, terjadi pada sekitar 1 dari 1.500 persalinan. Mendiagnosis apendisitis secara klinis selama kehamilan sulit karena beberapa faktor, termasuk, pertama, posisi apendiks yang bervariasi (apendiks secara bertahap bergeser ke atas selama kehamilan); kedua, keterbatasan pemeriksaan fisik perut ibu hamil; dan, ketiga, gejala yang tidak spesifik seperti mual, muntah, nyeri tekan, dan leukositosis selama kehamilan.

**12. Infeksi dan Peradangan Usus**

Infeksi dan peradangan usus merupakan penyebab potensial tambahan nyeri perut akut selama kehamilan. Penyakit radang usus memiliki insidensi puncak pada wanita usia reproduksi. Aktivitas penyakit sebagian besar tidak bergantung pada kehamilan; namun, aktivitas selama kehamilan dikaitkan dengan peningkatan angka keguguran janin dan keterlambatan pertumbuhan janin. Ultrasonografi mengungkapkan segmen usus berdinding tebal dalam kondisi infeksi atau peradangan aktif.

## C. Deman

**Definisi:**

Demam adalah kenaikan suhu tubuh yang ditandai oleh kenaikan titik ambang regulasi panas hipotalamus. Pusat regulasi/pengatur panas hipotalamus mengendalikan suhu tubuhdengan menyeimbangkan sinyal dari reseptor neuronal

perifer dingin dan panas. Ibu menderita demam dengan suhu tubuh >38ºC dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan.

**Etiologi :**

1. **Demam Infeksi**

   Demam infeksi adalah demam yang disebabkan oleh masuknya patogen, misalnya kuman, bakteri, viral atau virus, atau binatang kecil lainnya ke dalam tubuh. Demam infeksi paling sering terjadi dan diderita oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bakteri, kuman atau virus dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui berbagai cara, misalnya melalui makanan, udara, atau persentuhan tubuh.

2. **Demam Non-Infeksi**

   Demam non-infeksi adalah demam yang bukan disebabkan oleh masuknya bibit penyakit kedalam tubuh. Demam non-infeksi jarang terjadi dan diderita oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Demam ini timbul karena adanya kelainan pada tubuh yang dibawa sejak lahir, dan tidak ditangani dengan. Penyebab non infeksi antara lain dehidrasi pada anak dan lansia, alergi, stres, trauma, dan lain-lain

**Patofisiologi:**

Hipotalamus posterior bertugas meningkatkan produk panas dan mengurangi pengeluaran panas. Bila hipotalamus posterior menerima informasi suhu luar lebih rendah dari suhu tubuh maka pembentukan panas ditambah dengan meningkatkan metabolisme dan aktivitas otot rangka dalam bentuk menggigil dan pengeluaran panas dikurangi dengan vasokontriksi kulit dan pengurangan produksi keringat sehingga suhu tubuh tetap dipertahankan tetap.

Hipotalamus anterior mengatur suhu tubuh dengan cara mengeluarkan panas. Bila hipotalamus anterior menerima informasi suhu luar lebih tinggi dari suhu tubuh maka pengeluaran panas ditingkatkan dengan vasodilatasi kulit dan menambah produksi keringat. Umumnya peninggian suhu tubuh terjadi akibat peningkatan set point. Infeksi bakteri

menimbulkan demam karena endotoksin bakteri merangsang sel PMN untuk membuat pirogen endogen yaitu interleukin-1, interleukin 6 atau tumor nekrosis faktor. Pirogen endogen bekerja di hipotalamus dengan bantuan enzim siklooksigenase membentuk protaglandin selanjutnya prostaglandin meningkatkan set point hipotalamus. Selain itu pelepasan pirogen endogen diikuti oleh pelepasan cryogens (antipiretik endogen) yang ikut memodulasi peningkatan suhu tubuh dan mencegah peningkatan suhu tubuh pada tingkat yang mengancam jiwa.

**Diagnosis:**

Demam selama kehamilan mudah didiagnosis karena didefinisikan sebagai suhu di atas 38 °C. Kesulitannya terletak pada pengenalan dini penyakit infeksi dan tanda-tanda awal sepsis yang harus mendorong rujukan untuk penilaian rumah sakit segera mengenai konsekuensinya bagi ibu dan janin.

Infeksi ibu dapat dengan cepat memengaruhi janin, pola detak jantung janin yang abnormal parah atau kematian janin dalam kandungan menjadi pertimbangan.

## D. Penurunan Gerak Janin

**Gerakan Janin**

Gerakan janin umumnya pertama kali dirasakan pada usia kehamilan 18 hingga 20 minggu; namun, gerakan dapat dirasakan lebih awal oleh wanita multipara dan lebih lambat oleh wanita primipara (Agass & Patel, 2016). Selama trimester ketiga awal dan akhir, Bradford dan Maude (2018) melaporkan peningkatan yang nyata dalam kekuatan gerakan dan bahwa gerakan beralih dari kacau menjadi terorganisir. Setelah usia kehamilan 28 minggu, wanita hamil dapat lebih mudah menentukan kekuatan dan frekuensi gerakan janin dan mengidentifikasi kapan perubahan terjadi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gerakan Janin

Gerakan janin bersifat subjektif dan terutama dinilai oleh ibu hamil. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi gerakan janin adalah usia ibu yang lanjut, indeks massa tubuh yang tinggi, kehamilan pertama, plasenta anterior, keterlambatan pertumbuhan janin, dan bayi kecil untuk usia kehamilan (Agass & Patel, 2016; Akselsson et al., 2020; Mangesi et al., 2015; Tsakiridis et al., 2022). Frekuensi persepsi gerakan janin dapat dipengaruhi oleh posisi tubuh wanita, aktivitas, kecemasan, dan asupan makanan, seperti kafein dan glukosa.

**Intervensi**

Ketika seorang ibu hamil melaporkan perubahan pola gerakan janin atau penurunan gerakan janin, bidan harus memulai hal-hal berikut:

1. Percayai persepsi ibu hamil.
2. Sarankan ibu hamil untuk datang untuk pemeriksaan kesehatan janin dalam waktu 2 jam setelah pemberitahuan penurunan gerakan janin.
3. Hindari rekomendasi intervensi yang dapat menunda evaluasi langsung, seperti mengonsumsi minuman manis.

**Penatalaksanaan:**

1. Kaji detak jantung janin dengan alat Doppler
2. Lakukan penilaian klinis, termasuk riwayat medis, kesehatan, dan kehamilan lengkap

3. Jika detak jantung janin terdeteksi, evaluasi kesejahteraan janin dengan satu atau lebih dari berikut ini: tes non-stres, profil biofisik yang dimodifikasi, dan/atau evaluasi ultrasonografi. Di daerah pedesaan, pertimbangkan rujukan ke unit perawatan obstetri terdekat, pusat ultrasonografi, atau departemen gawat darurat untuk pengujian lebih lanjut (Jakes dkk., 2018; Lai dkk., 2016; RCOG, 2011).
4. Jika detak jantung janin tidak terdeteksi, pertimbangkan untuk melakukan ultrasonografi darurat
5. Jelaskan temuan penilaian janin kepada ibu hamil dan keluarga jika ada. Jadwalkan penilaian ulang dan dorong tindak lanjut segera jika terjadi perubahan gerakan janin lebih lanjut.

**Edukasi Selama Kehamilan**

Edukasi ibu hamil dan keluarganya tentang hal-hal berikut:

1. Perkembangan janin yang diharapkan dan perubahan sensasi gerakan janin sepanjang kehamilan.
2. Pemantauan gerakan janin termasuk kuantitas (jumlah) dan kualitas (intensitas), yang dapat bervariasi berdasarkan usia kehamilan.
3. Jenis dan sifat perubahan intensitas dan sensasi gerakan janin sepanjang kehamilan (Woods &Heazell, 2018). Penting untuk ditekankan bahwa frekuensi gerakan tidak berkurang menjelang akhir kehamilan
4. Gerakan janin umumnya dirasakan sebagai kuat atau sedang intensitasnya.

## E. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang ibu G3P2A0 usia kehamilan 35 minggu datang dengan keluhan perdarahan pervaginam tiba-tiba tanpa nyeri. Darah berwarna merah segar. Ibu tampak cemas namun stabil. Uterus lunak, tidak nyeri tekan, DJJ 145x/menit.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan pada kasus ini adalah …

A. Memantau tanda vital
B. Memasang infus
C. Melakukan pemeriksaan USG
**D. Melakukan pemeriksaan dalam**
E. Persiapan rujukan

Pertanyaan Diskusi Kelompok

1. Apa kemungkinan diagnosis pada kasus di atas? Jelaskan alasan Anda.
2. Apa saja tanda dan gejala khas yang mendukung diagnosis tersebut?
3. Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis?

4. Bagaimana penatalaksanaan awal pada kasus ini di fasilitas kesehatan?
5. Tindakan apa yang *tidak boleh dilakukan* pada kasus ini? Jelaskan alasannya.

## F. Latihan Soal

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| 1 | No. Stasiun | 1 |
| 2 | Judul | Kehamilan: Gawat Darurat Obstetri |
| 3 | Kasus | Perdarahan antepartum trimester III (suspek plasenta previa) dengan tindakan awal dan rujukan |
| 4 | Tujuan | Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam: |
| 5 | Kompetensi | 1. Anamnesis<br>2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana<br>3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah<br>4. Prosedur tindakan klinis<br>5. KIE/konseling<br>6. Kolaborasi/rujukan<br>7. Perilaku profesional |
| 6 | Soal: Skenario dan tugas peserta ujian | SKENARIO KLINIK<br>Seorang perempuan usia 30 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 35 minggu, datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir secara tiba-tiba sejak 1 jam yang lalu.<br>Hasil anamnesis awal:<br>• Perdarahan tanpa nyeri perut<br>• Darah berwarna merah segar<br>• Ibu merasa cemas namun masih dapat berkomunikasi dengan baik<br>• Gerakan janin masih dirasakan<br>Hasil pemeriksaan:<br>• TD : 110/70 mmHg<br>• N : 90 x/menit<br>• P : 20 x/menit<br>• S : 36,8°C<br>Pemeriksaan obstetri:<br>• Uterus lunak<br>• Tidak ada nyeri tekan |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | • DJJ 145 x/menit<br>• Tampak perdarahan merah segar dari vagina<br>Peserta diminta melakukan penatalaksanaan awal sesuai kewenangan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.<br>TUGAS<br>1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus.<br>2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus.<br>3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh.<br>4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut.<br>5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan. |
| 7 | Instruksi penguji | INSTRUKSI UMUM<br>1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.<br>2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:<br>a. Ujian institusi<br>• 2 digit jika peserta berjumlah 01–99<br>• 3 digit jika peserta berjumlah 100–999<br>• 4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta<br>b. Ujian nasional<br>• 4 digit jika peserta berjumlah ribuan<br>• atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka<br>3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian:<br>• Actual mark (0/1/2/3)<br>• Global rating (1/2/3/4)<br>4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan.<br>5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE.<br><br>INSTRUKSI KHUSUS |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS.<br>2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen, penguji memberikan data:<br>• TFU 33 cm<br>• Punggung kiri<br>• Presentasi kepala<br>• Kepala 3/5 di atas PAP<br>3. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan dalam, penguji menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan pada kasus ini karena terdapat perdarahan trimester III yang dicurigai Plasenta Previa.<br>4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:<br>• Menilai kondisi ibu dan janin secara cepat<br>• Memposisikan ibu miring kiri<br>• Mengobservasi jumlah perdarahan<br>• Memantau tanda vital dan DJJ<br>• Menyiapkan atau memasang infus cairan sesuai kewenangan<br>• Memberikan dukungan emosional kepada ibu<br>• Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas<br>• Menyiapkan rujukan segera ke rumah sakit<br>• Mengisi formulir rujukan<br>5. Peserta tidak melakukan pemeriksaan dalam/vaginal toucher.<br>6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai.<br><br>INSTRUKSI TAMBAHAN<br>1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya.<br>2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta. |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| 8 | Kebutuhan dan instruksi PS | Instruksi PS:<br>1. PS berperan sebagai ibu hamil dengan perdarahan trimester III.<br>2. PS tampak cemas, memegang perut, dan sesekali melihat darah yang keluar.<br>3. PS dapat menjawab pertanyaan peserta dengan jelas.<br>4. Bila peserta memberikan penjelasan dan dukungan, PS tampak lebih tenang.<br>5. Bila peserta menjelaskan bahwa ibu perlu dirujuk ke rumah sakit, PS tampak khawatir namun bersedia mengikuti arahan. |
| 9 | Dialog PS | **Peserta:**<br>Selamat pagi/siang, Bu.<br>**PS:**<br>Pagi/siang, Bu.<br>**Peserta:**<br>Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia?<br>**PS:**<br>Iya, Bu.<br>**Peserta:**<br>Apa keluhan utama ibu?<br>**PS:**<br>Saya tiba-tiba keluar darah dari jalan lahir, Bu.<br>**Peserta:**<br>Sejak kapan darah keluar?<br>**PS:**<br>Sekitar satu jam yang lalu.<br>**Peserta:**<br>Apakah ibu merasakan nyeri perut?<br>**PS:**<br>Tidak, Bu, tidak terasa sakit.<br>**Peserta:**<br>Bagaimana warna darahnya?<br>**PS:**<br>Merah segar, Bu. |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | **Peserta:**<br>Bagaimana gerakan bayi?<br>**PS:**<br>Masih terasa bergerak, Bu.<br>**Peserta:**<br>Apakah sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini?<br>**PS:**<br>Belum pernah, Bu.<br>**Peserta:**<br>Ini kehamilan yang ke berapa?<br>**PS:**<br>Kehamilan ketiga, Bu. Anak saya dua.<br>**Peserta:**<br>Ibu, kemungkinan ada masalah pada letak plasenta sehingga terjadi perdarahan. Ibu perlu dirujuk ke rumah sakit agar mendapat penanganan lebih lanjut.<br>**PS:**<br>Baik, Bu, saya ikut saran bidan. |
| 10 | Kebutuhan manikin | 1. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold<br>2. Phantom panggul untuk simulasi pemeriksaan (tanpa pemeriksaan dalam)<br>3. Lembar kasus pemeriksaan obstetri |
| 11 | Kebutuhan laboran | Peran laboran:<br>• Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin<br>• Mengganti lembar instruksi bila diperlukan<br>• Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya |
| 12 | Kebutuhan alat | 1. Tempat tidur/periksa — 1<br>2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1<br>3. Tensimeter — 1<br>4. Stetoskop — 1<br>5. Doppler/Pinard — 1<br>6. Jam tangan/stopwatch — 1<br>7. Termometer — 1<br>8. Sarung tangan bersih — 1 pasang<br>9. Handrub — 1 botol |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | 10. Kain penutup/selimut — 1<br>11. Tisu — 1 pack<br>12. Infus set dummy — 1 set<br>13. Cairan RL/NaCl dummy — 1<br>14. Abocath dummy — 1<br>15. Formulir rujukan — 1 lembar<br>16. Lembar jawaban peserta — 1 lembar<br>17. Pena — 1 |
| 13 | Penulis | ..... |
| 14 | Referensi | 1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020.<br>2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022.<br>3. World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*.<br>4. World Health Organization. (2015). *WHO recommendations for the prevention and treatment of maternal peripartum infections*. |

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

**Stase 1: Kehamilan Gawatdarurat**

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

| No | Aspek yang Dinilai | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memberi salam, memperkenalkan diri, dan meminta persetujuan pasien | | | | |
| 2 | Menanyakan keluhan utama pasien | | | | |
| 3 | Menggali waktu mulai perdarahan | | | | |
| 4 | Menanyakan jumlah perdarahan | | | | |
| 5 | Menanyakan warna darah yang keluar | | | | |
| 6 | Menanyakan apakah perdarahan disertai nyeri perut | | | | |

| No | Aspek yang Dinilai | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Menanyakan riwayat trauma, hubungan seksual, atau aktivitas sebelum perdarahan | | | | |
| 8 | Menanyakan gerakan janin | | | | |
| 9 | Menanyakan riwayat perdarahan sebelumnya pada kehamilan ini | | | | |
| 10 | Menanyakan usia kehamilan saat ini | | | | |
| 11 | Menanyakan riwayat obstetri (G, P, A) | | | | |
| 12 | Menanyakan riwayat persalinan sebelumnya | | | | |
| 13 | Menanyakan riwayat penyakit ibu (hipertensi, anemia, dll.) | | | | |
| 14 | Menanyakan riwayat pemeriksaan antenatal (ANC) | | | | |
| 15 | Menunjukkan sikap empati dan komunikasi yang baik selama anamnesis | | | | |

KOMPETENSI 2. Pemeriksaan Fisik dan Obstetri

| No | Aspek yang Dinilai | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melakukan kebersihan tangan sebelum pemeriksaan | | | | |
| 2 | Menjaga privasi dan kenyamanan pasien | | | | |
| 3 | Memeriksa tanda vital (TD, nadi, respirasi, suhu) | | | | |
| 4 | Mengobservasi kondisi umum ibu (kesadaran, kecemasan, pucat) | | | | |
| 5 | Mengobservasi jumlah perdarahan yang keluar | | | | |
| 6 | Melakukan palpasi abdomen secara sistematis | | | | |
| 7 | Menentukan tinggi fundus uteri (TFU) | | | | |
| 8 | Menentukan posisi dan presentasi janin | | | | |
| 9 | Menilai kontraksi uterus | | | | |
| 10 | Memeriksa denyut jantung janin | | | | |
| 11 | Menyebutkan bahwa pemeriksaan dalam tidak boleh dilakukan pada perdarahan trimester III | | | | |
| 12 | Melakukan pemeriksaan secara hati-hati dan komunikatif | | | | |

Kompetensi 3 : Perumusan Diagnosis / Masalah Kebidanan

| No | Aspek yang Dinilai | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi adanya perdarahan antepartum | | | | |
| 2 | Mengaitkan gejala perdarahan tanpa nyeri dengan kemungkinan plasenta previa | | | | |
| 3 | Menyimpulkan diagnosis kebidanan dengan tepat | | | | |
| 4 | Mengidentifikasi risiko terhadap ibu dan janin | | | | |

Kompetensi 4: Prosedur Tindakan Klinis Awal

| No | Aspek yang Dinilai | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menilai kondisi ibu dan janin secara cepat | | | | |
| 2 | Memposisikan ibu miring kiri | | | | |
| 3 | Memantau tanda vital ibu | | | | |
| 4 | Memantau denyut jantung janin | | | | |
| 5 | Menilai jumlah perdarahan | | | | |
| 6 | Menyiapkan atau memasang infus cairan sesuai kewenangan | | | | |
| 7 | Menjaga kondisi ibu tetap stabil | | | | |
| 8 | Menyiapkan rujukan segera | | | | |

Kompetensi 5: KIE / Konseling

| No | Aspek yang Dinilai | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menjelaskan kondisi ibu secara sederhana | | | | |
| 2 | Menjelaskan kemungkinan penyebab perdarahan | | | | |
| 3 | Menjelaskan perlunya penanganan di rumah sakit | | | | |
| 4 | Memberikan dukungan emosional kepada ibu | | | | |
| 5 | Memberikan kesempatan ibu/keluarga bertanya | | | | |

Penilaian:

| **Skor** | **Kriteria** |
|---|---|
| **0** | Tidak dilakukan |
| **1** | Dilakukan tetapi tidak lengkap / tidak sistematis |
| **2** | Dilakukan cukup lengkap tetapi masih ada bagian yang kurang |
| **3** | Dilakukan lengkap, sistematis, dan komunikasi baik |

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

**TOTAL SKOR =**

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{156} \times 100 =$$

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

| TIDAK LULUS | BORDERLINE | LULUS | SUPERIOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

(Kota), .....

.....

Penguji :.....

**Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Kehamilan**

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| Metode Penilaian | Metode penilaian klinik berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa saat melakukan tindakan pada pasien atau simulasi klinik. Penilaian dilakukan oleh pembimbing klinik menggunakan checklist dan rubrik penilaian yang terstandar. | Mahasiswa kebidanan melakukan penatalaksanaan awal pada ibu hamil dengan perdarahan trimester III di ruang gawat darurat kebidanan dan diamati langsung oleh pembimbing klinik. |
| Tujuan Penilaian | Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan keterampilan klinik secara aman, efektif, dan profesional | Mahasiswa mampu melakukan penilaian awal, mengidentifikasi kegawatdaruratan obstetri, serta melakukan tindakan stabilisasi |

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| | sesuai standar praktik kebidanan. | dan rujukan secara tepat pada kasus perdarahan trimester III. |
| Kasus Klinik | Kasus klinik nyata atau simulasi yang digunakan untuk mengamati keterampilan prosedural mahasiswa. Kasus dipilih sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran klinik. | Seorang ibu G3P2A0 usia kehamilan 35 minggu datang dengan keluhan perdarahan pervaginam tiba-tiba tanpa nyeri, darah merah segar, ibu tampak cemas namun stabil, uterus lunak, tidak nyeri tekan, DJJ 145 x/menit. Mahasiswa diminta melakukan penatalaksanaan awal dan menyiapkan rujukan. |
| Aktivitas Mahasiswa yang Diamati | Aktivitas mahasiswa saat melakukan prosedur klinik mulai dari persiapan, komunikasi dengan pasien, pemeriksaan klinis, tindakan awal, hingga dokumentasi dan rujukan. | Mahasiswa melakukan anamnesis singkat, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan obstetri, memantau DJJ, memposisikan ibu miring kiri, menyiapkan infus, menjelaskan kondisi kepada ibu, dan menyiapkan rujukan ke rumah sakit. |
| Aspek yang Dinilai | Aspek yang dinilai meliputi keterampilan teknis, komunikasi, pengambilan keputusan klinis, serta perilaku profesional mahasiswa selama melakukan prosedur. | 1. Komunikasi dengan pasien 2. Ketepatan anamnesis 3. Ketepatan pemeriksaan fisik/obstetri 4. Identifikasi diagnosis/masalah kebidanan 5. Tindakan stabilisasi awal 6. Keputusan rujukan 7. Sikap profesional dan keselamatan pasien |
| Fokus Observasi Pembimbing | Pembimbing klinik mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan prosedur, termasuk ketepatan langkah, keselamatan pasien, | Pembimbing menilai apakah mahasiswa: • Mengidentifikasi perdarahan antepartum dengan benar • Tidak melakukan pemeriksaan dalam pada perdarahan trimester III • |

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| | serta kemampuan klinis dalam pengambilan keputusan. | Melakukan stabilisasi ibu • Menyiapkan rujukan secara cepat dan tepat |
| Umpan Balik | Pembimbing memberikan umpan balik langsung setelah prosedur selesai untuk memperkuat praktik yang benar dan memperbaiki kekurangan mahasiswa. | Pembimbing menjelaskan bahwa mahasiswa sudah tepat dalam memposisikan ibu dan memantau DJJ, namun perlu meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan rujukan. |
| Keputusan Penilaian | Keputusan penilaian ditentukan berdasarkan rubrik penilaian atau skala kompetensi yang telah ditetapkan, seperti kompeten atau belum kompeten. | Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan obstetri secara sistematis dan aman serta melakukan rujukan dengan tepat. |
| Makna dalam OBE | DOPS mendukung pendekatan OBE karena penilaian berfokus pada pencapaian kompetensi nyata mahasiswa dalam praktik klinik, bukan hanya pada aspek pengetahuan teoritis. | Penilaian DOPS memastikan bahwa mahasiswa kebidanan mampu menunjukkan capaian pembelajaran berupa kemampuan melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan obstetri dan pengambilan keputusan klinis yang tepat. |

**Portofolio**

**Bukti yang dikumpulkan**

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

**Catatan untuk penulis:**

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

**Tabel. Portofolio pada Kegawatdaruratan kehamilan**

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| Hakikat Portofolio | Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar mahasiswa yang mendokumentasikan proses, pengalaman klinik, refleksi, dan pencapaian kompetensi selama praktik kebidanan. Portofolio menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa secara berkelanjutan. | Mahasiswa mendokumentasikan pengalaman klinik saat menangani ibu hamil dengan perdarahan trimester III di fasilitas pelayanan kesehatan. |
| Tujuan Portofolio | Portofolio bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif melalui dokumentasi pengalaman klinik, refleksi pembelajaran, serta umpan balik dari pembimbing. | Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengidentifikasi perdarahan antepartum, melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan obstetri, serta melakukan rujukan secara tepat. |
| OSCE dan DOPS | Portofolio dapat memuat hasil penilaian keterampilan klinik mahasiswa melalui metode OSCE dan DOPS sebagai bukti pencapaian kompetensi praktik. | Mahasiswa menyertakan hasil penilaian OSCE tentang penatalaksanaan perdarahan antepartum serta hasil observasi keterampilan klinik melalui DOPS saat melakukan penilaian awal ibu hamil dengan perdarahan. |
| Catatan Kasus Singkat | Catatan singkat mengenai kasus yang ditangani mahasiswa meliputi identitas pasien, keluhan utama, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan, dan rencana penatalaksanaan. | Seorang ibu G3P2A0 usia kehamilan 35 minggu datang dengan keluhan perdarahan pervaginam tiba-tiba tanpa nyeri, darah merah segar, ibu tampak cemas namun stabil. Hasil pemeriksaan menunjukkan uterus lunak, tidak nyeri tekan, DJJ 145 x/menit. Mahasiswa melakukan penilaian awal, memantau kondisi ibu dan janin, memposisikan ibu miring kiri, serta menyiapkan rujukan ke rumah sakit karena dicurigai plasenta previa. |

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| Refleksi Patient Safety | Refleksi mahasiswa mengenai aspek keselamatan pasien yang dipelajari dari kasus tersebut, termasuk tindakan yang harus dihindari dan pentingnya pengambilan keputusan klinis yang tepat. | Mahasiswa merefleksikan bahwa pada kasus perdarahan trimester III sangat penting tidak melakukan pemeriksaan dalam sebelum mengetahui posisi plasenta karena dapat memperberat perdarahan dan membahayakan ibu serta janin. |
| Feedback CI/Dosen | Catatan umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen mengenai kinerja mahasiswa dalam menangani kasus klinik. | CI memberikan umpan balik bahwa mahasiswa sudah mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan dasar dengan baik, namun perlu meningkatkan ketepatan dalam komunikasi klinik saat menjelaskan kondisi kepada pasien dan keluarga. |
| Karakteristik Penilaian | Penilaian portofolio bersifat formatif dan berkelanjutan, menilai proses belajar mahasiswa melalui refleksi, dokumentasi kasus, dan umpan balik pembimbing. | Portofolio dinilai berdasarkan kelengkapan dokumentasi kasus, ketepatan analisis klinik, kualitas refleksi, serta bukti pencapaian kompetensi mahasiswa. |
| Bukti Konsistensi Kompetensi | Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menerapkan kompetensi secara konsisten pada berbagai kasus klinik selama praktik. | Mahasiswa menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam mengidentifikasi tanda kegawatdaruratan obstetri, melakukan stabilisasi awal, dan mengambil keputusan rujukan pada beberapa kasus kegawatdaruratan kehamilan. |
| Makna dalam OBE | Dalam pendekatan OBE, portofolio menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran melalui pengalaman nyata di lapangan. | Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa telah mencapai kompetensi kebidanan dalam mengidentifikasi dan melakukan penatalaksanaan awal |

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| | | kegawatdaruratan obstetri secara aman dan profesional. |

**Tabel. Case Report pada Kegawatdaruratan Kehamilan**

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| Hakikat Case Report | Case report merupakan laporan tertulis yang mendokumentasikan satu kasus klinik secara sistematis dan ilmiah. Laporan ini menggambarkan proses identifikasi masalah, analisis klinis, penatalaksanaan, serta pembelajaran yang diperoleh dari kasus tersebut. | Mahasiswa menyusun laporan kasus mengenai ibu hamil dengan perdarahan trimester III yang datang ke fasilitas kesehatan dan memerlukan penatalaksanaan awal serta rujukan. |
| Tujuan | Case report bertujuan untuk melatih mahasiswa menganalisis kasus klinik secara komprehensif, mengintegrasikan teori dengan praktik klinik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis. | Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda kegawatdaruratan obstetri, menentukan diagnosis kemungkinan, serta merencanakan penatalaksanaan awal dan rujukan yang tepat pada kasus perdarahan trimester III. |
| Isi Laporan | Laporan kasus biasanya memuat latar belakang kasus, identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis atau masalah kebidanan, penatalaksanaan, serta pembahasan berdasarkan literatur. | Seorang ibu G3P2A0 usia kehamilan 35 minggu datang dengan keluhan perdarahan pervaginam tiba-tiba tanpa nyeri, darah merah segar, ibu tampak cemas namun stabil. Hasil pemeriksaan menunjukkan uterus lunak, tidak nyeri tekan, dan DJJ 145 x/menit. Mahasiswa menganalisis bahwa kasus mengarah pada kemungkinan plasenta previa, kemudian melakukan penatalaksanaan awal berupa pemantauan kondisi ibu dan janin serta menyiapkan rujukan ke rumah sakit. |

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| Fokus Penilaian | Penilaian case report berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam mengumpulkan data klinik, melakukan analisis kasus, menghubungkan temuan klinik dengan teori, serta menyusun laporan secara sistematis dan ilmiah. | Penilaian mencakup ketepatan identifikasi masalah, kejelasan analisis diagnosis kebidanan, kesesuaian rencana penatalaksanaan, serta penggunaan referensi ilmiah yang relevan. |
| Nilai Edukatif | Case report memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi mahasiswa karena mereka terlibat langsung dalam proses analisis kasus nyata dan refleksi terhadap praktik klinik. | Mahasiswa memahami bahwa pada kasus perdarahan trimester III perlu dilakukan penilaian cepat dan tindakan yang aman, serta menghindari prosedur tertentu seperti pemeriksaan dalam sebelum memastikan posisi plasenta. |
| Makna dalam OBE | Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), case report menjadi bukti autentik pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan klinik, dan kemampuan analisis. | Case report menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan kebidanan dalam menganalisis kasus kegawatdaruratan obstetri serta mengambil keputusan klinis yang tepat sesuai standar praktik. |

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Kehamilan

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| Hakikat Refleksi Patient Safety | Refleksi patient safety merupakan proses evaluasi dan pemikiran kritis mahasiswa terhadap tindakan klinik yang dilakukan, dengan menekankan aspek keselamatan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan. | Mahasiswa merefleksikan penanganan ibu hamil dengan perdarahan trimester III untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak meningkatkan risiko terhadap ibu maupun janin. |
| Tujuan | Refleksi ini bertujuan meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya keselamatan pasien, | Mahasiswa memahami bahwa penanganan perdarahan pada kehamilan memerlukan penilaian cepat dan tindakan yang aman |

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| | mengidentifikasi potensi risiko klinis, serta mendorong pengambilan keputusan yang aman dalam praktik kebidanan. | untuk mencegah komplikasi serius bagi ibu dan janin. |
| Fokus Refleksi | Fokus refleksi meliputi proses pengambilan keputusan klinis, ketepatan tindakan yang dilakukan, serta identifikasi prosedur yang dapat membahayakan pasien jika dilakukan secara tidak tepat. | Mahasiswa menilai kembali langkah-langkah yang dilakukan saat menangani pasien, termasuk proses anamnesis, pemeriksaan obstetri, serta keputusan untuk melakukan rujukan. |
| Risiko yang Diidentifikasi | Mahasiswa mengidentifikasi potensi risiko atau kesalahan yang dapat terjadi selama penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri. | Pada kasus ini terdapat risiko perdarahan hebat jika dilakukan pemeriksaan dalam sebelum mengetahui posisi plasenta, serta risiko keterlambatan rujukan yang dapat membahayakan ibu dan janin. |
| Tindakan Pencegahan | Tindakan pencegahan merupakan langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keselamatan pasien selama pelayanan kesehatan. | Mahasiswa memastikan tidak melakukan pemeriksaan dalam, memantau kondisi ibu dan janin, memposisikan ibu miring kiri, serta menyiapkan rujukan segera ke rumah sakit yang memiliki fasilitas obstetri lebih lengkap. |
| Pembelajaran Mahasiswa | Bagian ini berisi refleksi mahasiswa mengenai pengalaman belajar yang diperoleh dari kasus tersebut serta bagaimana pengalaman tersebut meningkatkan kompetensi klinik mereka. | Mahasiswa belajar bahwa pengenalan tanda kegawatdaruratan obstetri dan pengambilan keputusan rujukan yang cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi pada ibu dan janin. |
| Makna dalam OBE | Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), refleksi patient safety menjadi bukti bahwa | Refleksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, |

| Komponen | Deskripsi | Contoh Kasus |
|---|---|---|
| | mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan klinik tetapi juga mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam praktik nyata. | keterampilan klinik, dan sikap profesional untuk memberikan pelayanan kebidanan yang aman dan berkualitas. |

## G. Tabel Red Flags & Eskalasi

**Kegawatdaruratan Kehamilan**

| Red Flags | Makna Klinis | Tindakan Eskalasi |
|---|---|---|
| Perdarahan pervaginam merah segar pada trimester III | Mengindikasikan kemungkinan perdarahan antepartum yang sering berkaitan dengan plasenta previa atau kelainan plasenta lainnya | Lakukan penilaian cepat kondisi ibu dan janin, observasi jumlah perdarahan, serta siapkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memiliki layanan obstetri emergensi |
| Perdarahan terjadi tanpa nyeri perut | Merupakan tanda khas plasenta previa karena plasenta menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum | Hindari pemeriksaan dalam, lakukan pemantauan tanda vital ibu dan denyut jantung janin, serta stabilisasi kondisi ibu |
| Ibu tampak cemas dan mengalami perdarahan aktif | Dapat menunjukkan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang memerlukan penanganan segera | Berikan dukungan emosional, monitor kondisi ibu secara berkala, dan siapkan tindakan stabilisasi |
| Denyut jantung janin tidak normal (<120 atau >160 x/menit) | Menunjukkan kemungkinan distress janin akibat gangguan aliran darah atau hipoksia | Lakukan pemantauan DJJ secara berkala, posisikan ibu miring kiri, dan percepat rujukan ke rumah sakit |
| Perdarahan semakin banyak atau tanda syok (pucat, takikardia, hipotensi) | Menunjukkan kemungkinan syok hipovolemik akibat kehilangan darah | Segera lakukan stabilisasi, pasang infus cairan sesuai kewenangan, pantau tanda vital, dan lakukan rujukan darurat |

| Red Flags | Makna Klinis | Tindakan Eskalasi |
|---|---|---|
| Pemeriksaan dalam dilakukan tanpa indikasi pada perdarahan trimester III | Dapat memicu perdarahan yang lebih hebat jika plasenta menutupi jalan lahir | Hindari pemeriksaan dalam, lakukan pemeriksaan obstetri eksternal dan rujuk pasien untuk pemeriksaan lanjutan di rumah sakit |

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

**Bab: Kegawatdaruratan Kehamilan**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

| No | Pernyataan | Sudah | Belum | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi adanya perdarahan pervaginam pada trimester III | | | |
| 2 | Menilai warna dan jumlah perdarahan yang keluar | | | |
| 3 | Menanyakan apakah perdarahan disertai nyeri perut | | | |
| 4 | Menilai kondisi umum ibu (kesadaran, kecemasan, tanda pucat) | | | |
| 5 | Memeriksa tanda vital ibu (TD, nadi, respirasi, suhu) | | | |
| 6 | Memeriksa denyut jantung janin (DJJ) | | | |
| 7 | Melakukan palpasi abdomen untuk menilai kondisi uterus | | | |
| 8 | Mengidentifikasi kemungkinan perdarahan antepartum | | | |
| 9 | Menghindari pemeriksaan dalam pada perdarahan trimester III | | | |
| 10 | Memposisikan ibu miring kiri untuk meningkatkan perfusi uteroplasenta | | | |
| 11 | Melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkala | | | |
| 12 | Menyiapkan pemasangan infus sesuai kewenangan | | | |

| No | Pernyataan | Sudah | Belum | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Memberikan penjelasan kondisi kepada ibu dan keluarga | | | |
| 14 | Menyiapkan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas obstetri lebih lengkap | | | |
| 15 | Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan | | | |

## H. Ringkasan

Tanda bahaya kehamilan merupakan indikator penting adanya komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Deteksi dini dan penatalaksanaan cepat menjadi kunci dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal.

**Perdarahan pada kehamilan** dibedakan menjadi perdarahan kehamilan muda (<20–22 minggu) dan perdarahan antepartum (>24–28 minggu). Perdarahan kehamilan muda umumnya disebabkan oleh abortus, kehamilan ektopik, dan mola hidatidosa. Abortus diklasifikasikan menjadi imminens, insipiens, inkompletus, kompletus, missed abortion, habitualis, infeksiosa, serta provokatus. Kehamilan ektopik terjadi akibat implantasi di luar kavum uteri dan berisiko ruptur serta syok. Mola hidatidosa merupakan kehamilan patologis akibat degenerasi vili korialis.

Perdarahan antepartum meliputi plasenta previa, solusio plasenta, dan vasa previa. Plasenta previa ditandai perdarahan merah segar tanpa nyeri, sedangkan solusio plasenta ditandai nyeri hebat dengan uterus tegang dan perdarahan berwarna gelap serta risiko gawat janin. Vasa previa terjadi akibat robekan pembuluh darah janin saat ketuban pecah dan dapat menyebabkan kematian janin cepat bila tidak segera ditangani.

**Nyeri hebat dalam kehamilan** dapat berasal dari penyebab obstetri seperti abortus, kehamilan ektopik, abrupsio plasenta, ruptur uteri, dan persalinan prematur, maupun non-obstetri seperti torsi ovarium, leiomioma, dan apendisitis. Perubahan fisiologis kehamilan sering menyulitkan diagnosis sehingga diperlukan analisis klinis yang cermat.

**Demam pada kehamilan** didefinisikan sebagai suhu ≥38°C dan umumnya disebabkan infeksi. Mekanisme demam terjadi melalui pelepasan pirogen endogen yang meningkatkan set point hipotalamus. Infeksi maternal dapat berdampak cepat pada janin, termasuk takikardi janin dan risiko sepsis, sehingga memerlukan evaluasi dan rujukan segera.

**Penurunan gerak janin** merupakan tanda gangguan kesejahteraan janin. Gerakan janin normalnya mulai dirasakan usia 18–20 minggu dan lebih jelas setelah 28 minggu. Bila ibu melaporkan penurunan gerak, tenaga kesehatan harus segera melakukan evaluasi detak jantung janin dan penilaian kesejahteraan janin (NST/USG). Edukasi ibu mengenai pemantauan gerak janin sangat penting.

## I. Glosarium

| | |
|---|---|
| Abortus | : Ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup luar kandungan dimana usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram |
| Amenorea | : Tidak haid minimal selama 3 bulan berturut-turut |
| Antepartum hemoragik | : Perdarahan yang terjadi sebelum proses persalinan |
| Atonia uteri | : Keadaan lemahnya tonus otot uterus |
| CRL | : Crown rump lenght adalah sebuah pengukuran yang dilakukan dari puncak kepala sampai bokong saat masa embrio, fetus. |
| Divertikel | : Suatu protusi mukosa keluar dari lumen/kantong mukosa |
| Endometriosis | : Sebuah kondisi biasanya ditandai dengan nyeri saat mentruasi/dismenorea dimana karakteristiknya adalah terjadinya abnormal fungsional jaringan endometrium di luar uterus |
| Endometrium | : Lapisan mukosa dari dinding dalam uterus |
| Fertilisasi | : Bertemunya sel ovum dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot. |
| hCG | : Human chorionic gonadotrophin adalah hormon yang disekresikan oleh plasenta sepanjang kehamilan untuk mempertahankan corpus luteum. |
| Hematokel | : Penimbunan darah pada saluran atau rongga tubuh |
| Hipofibrinogenemia | : Kadar fibrinogen yang rendah di dalam darah |
| Hipoplasia | : Perkembangan yang tidak lengkap dari suatu organ atau jaringan |
| Histerektomi | : Prosedur pembedahan untuk pengangkatan uterus |
| Induksi | : Inisiasi atau augmentasi persalinan dengan metode mekanik atau dengan farmakologi |
| Kehamilan ektopik terganggu | : Kehamilan yang terjadi di luar rahim (uterus) |
| Konsepsi | : Suatu produk penyatuan oosit dan spermatoa pada setiap tahap perkembangan dari fertilisasi sampai lahir, termasuk membran ektraembrionik sebagaimana embrio atau fetus |

| | |
|---|---|
| Kromosom | : Unit genetik yang terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup, kromosom berbentuk deret panjang molekul yang disusun oleh DNA dan protein-protein |
| Kuldoskopi | : Pemeriksaan visual visera pelvis wanita melalui endoskopi yang dimasukkan ke dalam rongga panggul melalui forniks posterior vagina |
| Laparoskopi | : Sejenis prosedur bedah dimana sayatan kecil dibuat, biasanya di umbilikal, dimana alat laparoskop (tabung optik) dimasukan |
| Laparotomi | : Insisi pembedahan pada dinding abdomen, terutama di regio panggul |
| Mola hidatidosa | : Kehamilan yang berkembang tidak wajar (konsepsi yang patologis) dimana tidak ditemukan janin dan hampir seluruh vili korialis mengalami perubahan/degenerasi hidropik menyerupai buah anggur atau mata ikan |
| Nekrosis | : Perubahan morfologi yang mengindikasikan kematian sel karena degradasi progresif enzimatik |
| Nidasi | : Atau implantasi merupakan tahap menempelnya blastokis ke dalam endometrium |
| Ostium | : Lubang |
| Perforasi | : Lubang patologis yang terbentuk pada organ yang berongga |
| Peritonitis | : Inflamasi pada lapisan peritoneum |
| Pervaginam | : Melalui vagina |
| Pielonefritis | : Inflamasi pada ginjal dan pelvis renalis akibat infeksi bakteri |
| Plasenta previa | : Plasenta yang berimplantasi di segmen bawah rahim, baik dapat menutup ostium uteri interna secara total, parsial, atau tepat di tepat ostium |
| Retensio plasenta | : Tidak lahirnya plasenta lebih dari 30 menit pada kala uri |
| Retroversi uterus | : Suatu kondisi dimana posisi uterus terbalik ke dalam pelvis |
| Ruptur uteri | : Robeknya dinding uterus |
| Subinvolusi uterus | : Suatu kondisi pasca persalinan dimana uterus tidak kembali ke ukuran normalnya |
| Solusio plasenta | : Terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya |

## J. Daftar Pustaka

Agass, R., & Patel, S. (2016). Maternity triage: A guide for trainees. British Journal of Hospital Medicine, 77(12), C186–C189. https://doi.org/10.

12968/hmed.2016.77.12.C186

Agnès Le Gouez, Alexandra Benachi, Frédéric J. Mercier. (2016) Fever and pregnancy. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine. Volume 35, Supplement 1, Pages S5-S12, ISSN 2352-5568, https://doi.org/10.1016/j.accpm.2016.06.007. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352556816300686)

Ahmad, F. 2019. Kehamilan, Janin, & Nutrisi . Yogyakarta : CV Budi Utama

Akselsson, A., Lindgren, H., Georgsson, S., Pettersson, K., Steineck, G., Skokic, V., & Rådestad, I. (2020). Mindfetalness to increase women's awareness of fetal movements and pregnancy outcomes: A clusterrandomised controlled trial including 39,865 women. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 127(7), 829–837. https://doi.org/10.1111/ 1471-0528.16104

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). Antepartum fetal surveillance: ACOG Practice Bulletin No. 229. Obstetrics & Gynecology, 137(6), e116–e127. https://doi.org/10.1097/AOG. 0000000000004410

Asrinah. 2010. Asuhan Kebidanan Masa Kehamilan. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Bradford, B., & Maude, R. (2018). Maternal perception of fetal movements in the third trimester: A qualitative description. Women and Birth, 31(5), e287–e293. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.12.007

Bradford, B., & Maude, R. (2019). A diurnal fetal movement pattern: Findings from a cross-sectional study of maternally perceived fetal movements in the third trimester of pregnancy. PloS one, 14(6), e0217583. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217583

Centers for Disease Control and Prevention. (2022a). Black mothers are more likely to experience stillbirth compared to Hispanic and White mothers. https://www.cdc.gov/ncbddd/stillbirth/features/kf-black-mothers-stillbirth.html

Centers for Disease Control and Prevention. (2022b). What is stillbirth?. https://www.cdc.gov/ncbddd/stillbirth/facts.html

Courtney A. Woodfield. Elizabeth Lazarus. Karen C. Chen. Wlliam W. Mayo- Smith. (2012). Abdominal Pain in Pregnancy: Diagnoses and Imaging Unique to Pregnancy—*Review.* American Journal of Roentgenology. Volume 194. Issue 6 supplement. June 2010. Pages: WS14 - WS30

Heazell, A. E. P., Warland, J., Stacey, T., Coomarasamy, C., Budd, J., Mitchell, E. A., &

O'Brien, L. M. (2017). Stillbirth is associated with perceived alterations in fetal activity—Findings from an international case control study. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1), Article 369. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1555-6

Jakes, A. D., Whybrow, R., Spencer, C., & Chappell, L. C. (2018). Reduced fetal movements. BMJ, 360, Article k570. https://doi.org/10.1136/bmj.k570

Lai, J., Nowlan, N. C., Vaidyanathan, R., Shaw, C. J., & Lees, C. C. (2016). Fetal movements as a predictor of health. Acta Obstetricia et Gynecologia Scandinavica, 95(9), 968–975. https://doi.org/10.1111/aogs. 12944

Liu, Y., Xuan, R., He, Y., Ren, F., & Gu, Y. (2022). Computation of fetal kicking in various fetal health examinations: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), Article 4366. https://doi.org/10.3390/ijerph19074366

Mangesi, L., Hofmeyr, G. J., Smith, V., & Smyth, R. M. (2015). Fetal movement counting for assessment of fetal wellbeing. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015(10), Article CD004909. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004909.pub3

Royal College of Obstetrics and Gynaecologists. (2011). Reduced fetal movements: Green-top Guideline No. 57. https://www.rcog.org.uk/media/2gxndsd3/gtg_57.pdf

Rukiyah, dkk. 2013. Asuhan Kebidanan I (Kehamilan). Jakarta : CV. Trans Info Media.

Tsakiridis, I., Zerva, C., Mamopoulos, A., Kalogiannidis, I., Athanasiadis, A., & Dagklis, T. (2022). Maternal perception of fetal movements: Onset and associated factors. Journal of Perinatal Medicine, 50(9), 1174–1179. https://doi.org/10.1515/jpm-2021-0606

Warland, J., Heazell, A. E. P., Stacey, T., Coomarasamy, C., Budd, J., Mitchell, E. A., & O'Brien, L. M. (2018). "They told me all mothers have worries," stillborn mother's experiences of having a "gut instinct" that something is wrong in pregnancy: Findings from an international case–control study. Midwifery, 62, 171–176. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.04.009

Woods, J. R., & Heazell, A. E. P. (2018). Stillbirth: Is it preventable? Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine, 28(5), 148–154. https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2018.03.006

# BAB 3

## DETEKSI DINI ANEMIA DAN MASALAH GIZI: HB, STATUS GIZI, DAN INTERVENSI AWAL

**CP (Capaian Pembelajaran) Bab**

*Mahasiswa mampu mendemonstrasikan deteksi dini Anemia dan masalah gizi yang tepat sesuai standar, mengidentifikasi red flags, dan melakukan intervensi awal yang tepat sesuai kewenangan.*

**Mapping CP Bab → CPMK → CPL**

| CP Bab | CPMK | CPL |
|---|---|---|
| Deteksi Dini Anemia dan Masalah Gizi: Hb, Status Gizi, dan Intervensi Awal | CPMK 6 | CPL 3 dan CPL 4 |

| | |
|---|---|
| CPMK-6 | Mengidentifikasi tanda bahaya dan masalah prioritas pada kehamilan (termasuk hipertensi/preeklamsia, anemia/gizi, keluhan umum) serta menetapkan tindak lanjut awal dan kebutuhan rujukan. |

| | | |
|---|---|---|
| CPL-3 | Mampu menginterpretasi temuan klinis dan penunjang untuk mengenali masalah serta risiko kehamilan. | CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6 |
| CPL-4 | Mampu menetapkan tindak lanjut, intervensi awal, dan rencana rujukan berdasarkan hasil pemeriksaan. | CPMK-6, CPMK-7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bab 11. Deteksi Dini Anemia dan Masalah Gizi: Hb, Status Gizi, dan Intervensi Awal | 11.1 Melakukan skrining anemia dan status gizi serta klasifikasi derajat masalah. | 11.2 Menetapkan intervensi awal dan indikator pemantauan perbaikan. | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CPMK-5 | Ujian interpretasi penunjang (case-based) | Klasifikasi hasil lab/USG (normal–abnormal) tepat; integrasi temuan penunjang dengan data klinis menghasilkan simpulan masalah yang logis | 12 | Lembar jawaban; lembar analisis kasus penunjang |
| CPMK-6 | Ujian berbasis skenario (OSCE/CBT) manajemen awal & rujukan | Tanda bahaya/komplikasi terdeteksi dan tingkat urgensi tepat; rencana tindakan awal, tindak lanjut, dan rujukan sesuai prioritas masalah | 20 | Checklist/lembar jawaban skenario; rencana tindak lanjut–rujukan |
| CPMK-7 | Role-play konseling (rubrik) + tugas dokumentasi (portofolio) | Pesan konseling terstruktur dan dipahami (terverifikasi); dokumentasi standar lengkap, konsisten, dan mendukung keputusan klinis | 10 | Video/lembar observasi konseling; SOAP/format ANC; cuplikan Buku KIA (simulasi) |

**Rubrik CPMK-6**

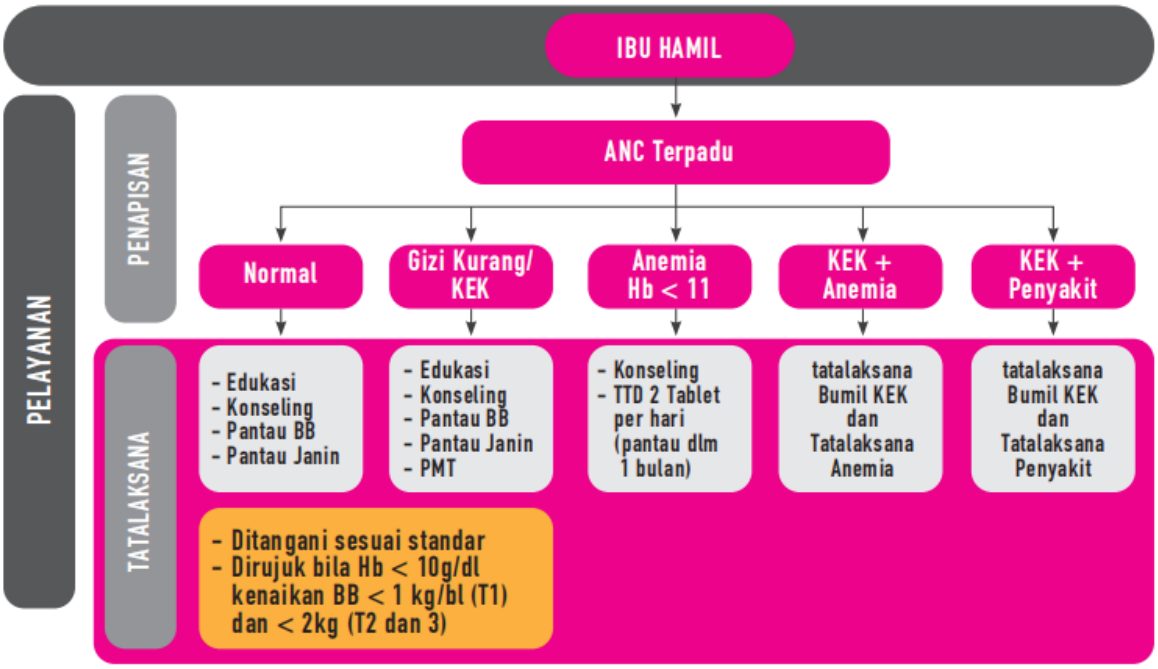
| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Ketepatan deteksi masalah prioritas & urgensi | Tanda bahaya/komplikasi tidak dikenali; urgensi salah | Mengenali sebagian; klasifikasi urgensi belum konsisten | Mengenali masalah prioritas; urgensi tepat dengan kekurangan minor | Mengenali masalah secara komprehensif; urgensi sangat tepat dan berorientasi keselamatan |
| 6.2 Ketepatan tindakan awal, tindak lanjut, dan rujukan | Tindakan awal tidak sesuai; rujukan tidak tepat/terlambat | Tindakan awal cukup; rencana tindak lanjut/rujukan masih umum | Tindakan awal sesuai; rencana tindak lanjut/rujukan tepat | Tindakan awal sangat tepat dan terukur; rencana tindak lanjut/rujukan jelas, realistis, dan berbasis prioritas |

## Uraian Materi

### A. Deteksi Dini Anemia dan Masalah Gizi

Semua ibu hamil memiliki hak untuk memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Pengalaman yang bersifat positif adalah pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya sebagai perempuan, istri dan ibu. Namun kondisi di Indonesia saat ini, angka kematian ibu masih tinggi. Penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan pasca persalinan (post partum). Sedangkan, penyebab kematian pada kelompok perinatal disebabkan oleh komplikasi intrapartum sebanyak 28,3% dan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 19%. Ini menggambarkan bahwa kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat menentukan persalinan dengan kondisi bayi yang dilahirkan. Perdarahan pasca persalinan berkaitan dengan anemia saat remaja dan saat hamil. Berdasarkan Riskesdas, terdapat peningkatan kasus yang cukup signifikan terkait anemia pada ibu hamil dari 37,1% pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018. Ibu hamil dengan anemia berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Bila BBLR tidak ditangani dengan baik memiliki risiko kematian dan stunting. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan deteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil. Agar selanjutnya dapat dilaksanakannya tatalaksana terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini mungkin atau rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada. Deteksi dini anemia dan masalah gizi pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan Hemoglobin (Hb) serta status gizi. Hal ini sangat krusial, terutama pada remaja putri dan ibu hamil, untuk mencegah komplikasi serius seperti stunting pada anak dan kematian ibu.

Bagan 1. Alur Pelayanan Gizi Pada Ibu Hamil




## B. Deteksi Dini Anemia

### 1. Definisi Anemia

Anemia adalah suatu kondisi tubuh yang ditandai dengan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari normal, yang bisa disebabkan jumlah sel darah merah yang kurang (contohnya pada perdarahan berat akibat

kecelakaan, atau sebab lainnya), atau jumlah sel darah merah cukup tapi kandungan Hb didalam sel darah merah kurang. Kadar hemoglobin (Hb) normal pada ibu hamil adalah 11 gr/dL.

Batas nilai Hb adalah:

a. Ibu hamil anemia jika kadar Hb kurang dari 11 g/dL.
b. Anak 12-14 tahun dan perempuan tidak hamil (usia lebih dari 15 tahun) anemia jika kadar Hb kurang dari 12 g/dL.

Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Kekurangan oksigen dalam jaringan akan menyebabkan fungsi jaringan terganggu. Misalnya kekurangan oksigen pada jaringan otak dan otot, yang akan menyebabkan gejala kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas.

### 2. Tanda dan Gejala Anemia

Gejala anemia pada umumnya muncul akibat kurangnya oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh karena rendahnya Hb, sehingga jaringan yang

kekurangan oksigen tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal dan muncul gejala anemia. Anemia terjadi secara perlahan, sehingga gejalanya sering tidak terasa. Saat gejala sudah terasa, biasanya anemia sudah cukup berat.

Gejala anemia yang sering terjadi sesuai dengan kategorinya adalah:

a. Anemia Ringan: pada tahap ini, umumnya penderita tidak mengalami gejala yang mencolok. Contohnya, bila otot mengalami pasokan oksigen yang lebih rendah dari kebutuhannya maka gejala yang timbul berupa mudah merasa lelah, letih, lesu dan lemah setelah beraktifitas atau berolahraga. Gejala-gejala ini sering dianggap sebagai kondisi biasa, bukan sakit. Bila pasokan oksigen ke otak kurang dibandingkan dengan kebutuhannya, maka bisa muncul gejala mudah lupa (lalai) dan kurang konsentrasi. Gejal-gejala tersebut sering disebut sebagai gejala 5 L (Lesu, Letih, Lemah, Lelah dan Lalai).
b. Anemia Sedang: pada tahap ini mulai timbul gejala yang lebih nyata, misalnya berupa jantung terasa sering berdebar, lebih sering merasa lelah dengan aktivitas biasa, sesak nafas, dan terlihat lebih pucat dari biasanya.
c. Anemia Berat: Timbul gejala yang lebih berat berupa kelelahan yang berkepanjangan, menggigil, jantung berdebar cepat, pucat lebih nyata, sesak nafas, nyeri dada, dan gangguan fungsi organ lainnya.

**3. Penyebab Anemia/Kekurangan Darah**

Anemia secara umum disebabkan oleh 3 hal berikut:

a. Kekurangan asupan zat gizi (zat besi, asam folat, vitamin B12, dan protein) sehingga mengganggu pembentukan hemoglobin; Rata-rata pola konsumsi masyarakat Indonesia berisiko menderita anemia, terutama anemia defisiensi/kekurangan besi karena kurang asupan pangan sumber zat besi. Makanan sumber zat besi seperti:
   1) Sumber makanan yang kaya besi adalah pangan hewani karena mengandung zat besi
   2) Zat besi yang berasal dari pangan nabati disebut besi non-heme, walaupun jumlahnya banyak, namun besi non-heme ini sangat sedikit yang dapat diserap.
b. Keluarnya darah dalam jumlah yang banyak atau pendaharahaan baik akut maupun kronis. Perdarahan akut biasanya disebabkan oleh kecelakaan, sedangkan perdarahan kronis disebabkan oleh menstruasi yang berlangsung lama dan banyak, perdarahan akibat kecacingan (cacing menghisap darah dan merusak dinding usus) dan perdarahan akibat malaria yang menyebabkan sel darah merah rusak (hemolysis).
c. Faktor keturunan (penyakit thalassemia yang menyebabkan sel darah merah rusak

**4. Dampak Anemia pada Ibu Hamil**

Anemia akan memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek seperti menurunnya produktifitas, kebugaran dan daya tahan tubuh sedangkan jangka panjang menyebabkan risiko perdarahan, melahirkan bayi BBLR dan prematur yang selanjutnya meningkatkan risiko terjadinya stunting, AKI dan AKB.

Anemia defisiensi besi pada kehamilan dapat meningkatkan:

a. Risiko komplikasi perdarahan yang meningkatkan risiko kematian ibu.
b. Menurunnya fungsi kekebalan tubuh, sehingga mudah menderita penyakit infeksi.
c. Menghambat pertumbuhan janin:
    1) Bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah (BBLR) dan panjang badan lahir rendah (PBLR).
    2) Risiko sakit dan anemia pada bayi yang dapat menyebabkan kematian.
    3) Risiko stunting pada usia bayi dan anak usia kurang 2 tahun (1000 HPK) dan dalam jangka panjang berdampak pada menurunnya kecerdasan dan meningkatnya risiko penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes, jantung dan stroke) yang akan berdampak terhadap 3 generasi dari ibu ke cucunya

**5. Skrining Anemia:**

Skrining anemia pada ibu hamil wajib dilakukan melalui pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) minimal dua kali, yaitu pada trimester pertama dan ketiga. Ibu hamil yang anemia dengan konsentrasi hemoglobin yang rendah dapat meningkatkan risiko persalinan prematur, BBLR, hingga kematian ibu/janin. Pencegahannya melibatkan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dan edukasi gizi.

Tujuan Skrining Anemia: Mengetahui status anemia ibu hamil

Sasaran Skrining Anemia: Seluruh Ibu hamil

Frekuensi Skrining Anemia: Sekurang-kurangnya 2x selama kehamilan yaitu Trimester 1 (K1) dan Trimester 3 (K5)

Metode Skrining Anemia: Pemeriksaan kadar hemoglobin dilakukan dengan Hematology Analyzer.

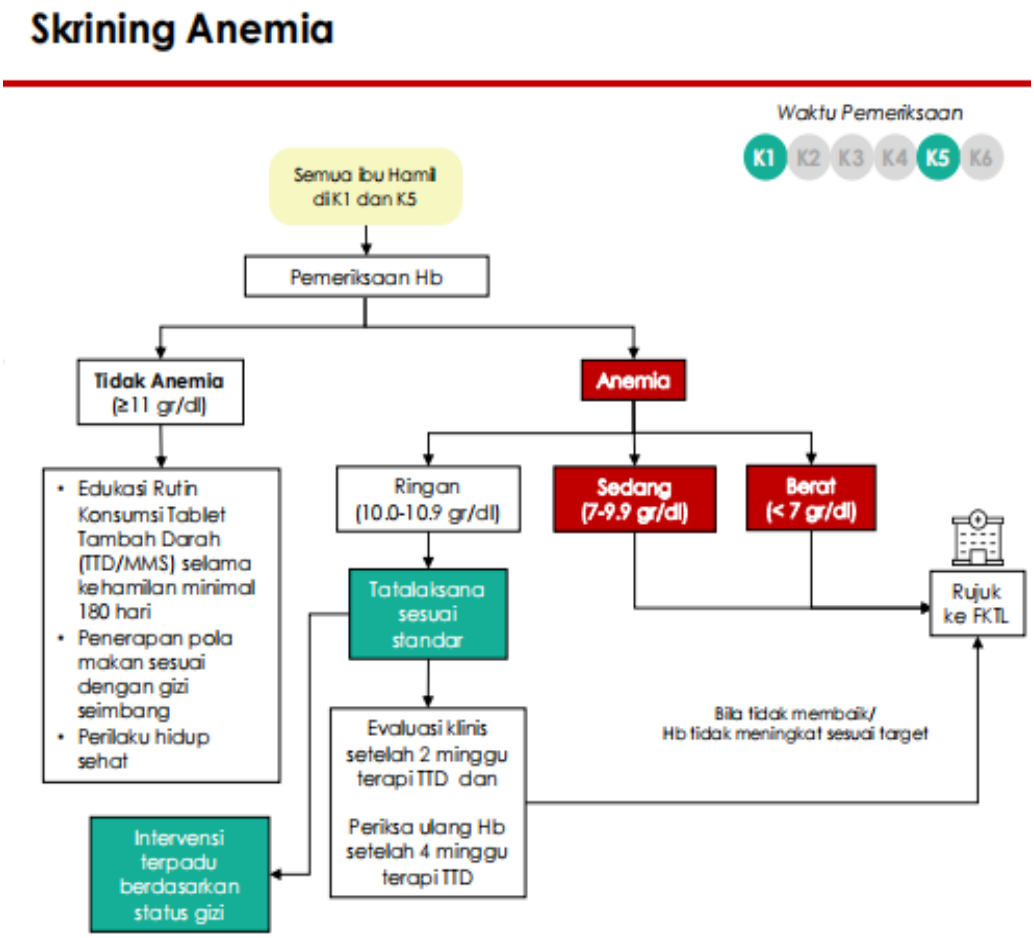
Berdasarkan kadar Hb, anemia pada ibu hamil diklasifikasikan menjadi 3 kategori:

a. Anemia Ringan: 10,0 – 10,9 gr/dL
b. Anemia Sedang: 7,0 – 9,9 gr/dL
c. Anemia Berat: < 7 gr/dL

**6. Interpretasi dan Tindak lanjut:**

a. Tidak Anemia → Edukasi Hamil Sehat

b. Anemia Ringan → Tatalaksana sesuai standar dan periksa ulang sesudah 2-4 minggu terapi TTD (Tablet Tambah darah). Rujuk ke dokter jika Hb < 10 gr/dL, Leukosit > 18.000 sel/uL,Trombosit < 150.000 sel/uL, MCV dan MCH kurang dari normal (MCV , 80 fL. MCH , 27 pg
c. Anemia Sedang → Rujuk ke FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)
d. Anemia Berat → Rujuk ke FKTL




**Gambar 11.1 Bagan Skrining Anemia, Pedoman Kluster 2**

## C. Deteksi Dini Masalah Gizi

Setiap ibu hamil harus mendapatkan ANC terpadu. Setiap ANC dilakukan penapisan untuk mendeteksi masalah gizi pada ibu hamil. Metode Penilaian masalah gizi dilakukan dengan:

**1. Penimbangan dan Pengukuran**

a. Berat Badan (K1-K6)
b. Tinggi Badan (K1)
c. Lingkar Lengan Atas (K1 dan K2-K6 jika LILA< 23,5 cm

**2. Penentuan Status Gizi dengan membandingkan Indeks Massa Tubuh (IMT) sesuai standar**

Kenaikan berat badan ibu selama kehamilan dapat menjadi gambaran perkembangan janin dan kesehatan Ibu. Catat kenaikan berat badan ibu selama kehamilan di buku KIA. Pertambahan BB selama kehamilan direkomendasikan sesuai IMT sebelum hamil.

Rekomendasi kenaikan berat badan selama kehamilan (dibandingkan dengan sebelum hamil)

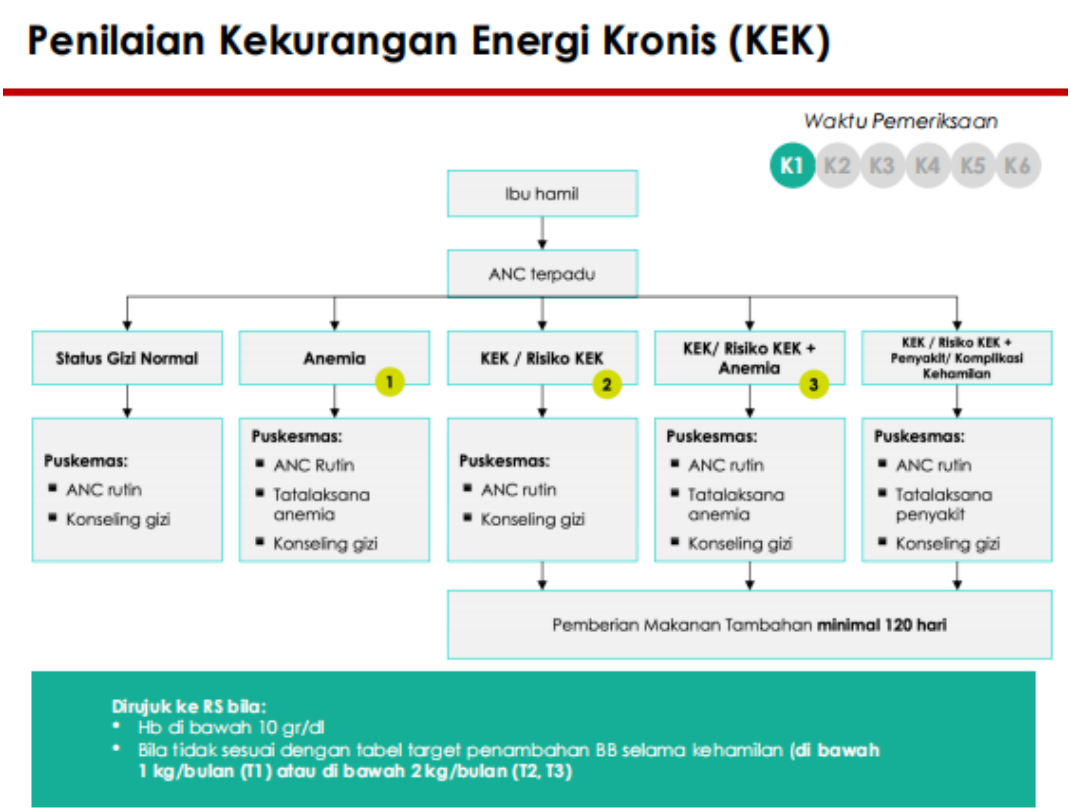
a. Kurus. : 12,5-18 kg
b. Normal. : 11,5-16 kg
c. Gemuk. : 7-11,5 kg
d. Obesitas. : 5-9 kg

Pemantauan berat badan selama kehamilan selama kehamilan dilakukan setiap kunjungan.

a. Jika berat badan normal tetapi tidak mengalami peningkatan sesuai anjuran, periksa penyebabnya. Mual muntah sering menjadi penyebab berat badan pada awal kehamilan tidak naik sesuai standar.
b. Tatalaksana keluhan, berikan anjuran gizi seimbang bagi Ibu hamil dan
c. Jika berat badan naik terlalu cepat → periksakeluhan atau tanda gejala lain, lakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai. Berikan konseling Gizi pada kedua keadaan tersebut.

Tata laksana kasus terkai masalah gizi:

a. Jika Anemia saja: konseling gizi dan tatalaksana anemia
b. Anemia ringan (Hb 10 – 10,9 gr/dl): TTD 2 x 1/ hari sampai kadar Hb normal
c. Anemia sedang s.d berat (< 10 gr/dl) dirujuk ke RS
d. Pemantauan kadar Hb ibu hamil dengan anemia dilakukan setelah 3 bulan tatalaksana
e. Jika KEK / Risiko KEK saja: diberi MT disertai edukasi/konseling gizi
f. Jika KEK / Risiko KEK + Anemia: diberi MT, konseling gizi dan tatalaksana anemia
g. Jika KEK / Risiko KEK + penyakit: diberi MT, konseling gizi, tatalaksana penyakit penyerta atau dirujuk.
h. Jika ditemukan kadar Hb <10 gr/dl atau kenaikan BB tidak sesuai usia kehamilan di bawah 1 kg/bulan (T1) atau di bawah 2 kg/bulan (T2, T3), maka harus dirujuk.
i. PMT bagi Ibu hamil KEK/Risiko KEK diberikan selama minimal 120 hari.




**Gambar 3.2 Bagan Penilaian KEK, Pedoman Kluster 2**

Tata Laksana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil:

a. Pada trimester I diberikan 2 keping biskuit lapis per hari.
b. Pada trimester II dan III diberikan 3 keping biskuit lapis per hari.
c. Tiap bungkus Makanan Tambahan (MT) ibu hamil berisi keping biskuit lapis (60 gram).
d. Untuk ibu hamil normal, MT diberikan dengan waktu pemberian maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan edukasi.
e. MT Ibu Hamil ini dapat juga digunakan pada situasi darurat.
f. Untuk ibu hamil KEK (LiLA < 23,5 cm) diberikan MT disertai konseling yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi ibu dengan jangka waktu pemberian MT pada ibu hamil KEK dapat lebih dari 1 bulan.
g. Ibu hamil harus menghabiskan MT yang diterima dan melakukan kunjungan ANC termasuk melakukan pemantauan pertambahan berat badan sesuai standar kenaikan berat badan ibu hamil dan atau LiLA.

Penanggulangan Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil

Penanggulangan ibu hamil KEK seharusnya secara ideal dimulai sejak sebelum hamil bahkan sejak usia remaja putri. . Penyediaan makan pada ibu hamil KEK diawali dengan perhitungan kebutuhan, pemberian diet (termasuk komposisi zat gizi, bentuk makanan, dan frekuensi pemberian dalam sehari). Ibu hamil KEK perlu

penambahan energi sebesar 500 kkal yang dapat berupa pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, PMT pabrikan atau minuman padat gizi.

**3. Indikasi merujuk ke dokter**

a. Terkait kadar HB
   1) Hb <10 g/dl
   2) Leukosit >18.000 sel/uL atau Trombosit <150.000 sel/uL
   3) MCV dan MCH kurang dari normal (MCV < 80 fL, MCH <27pg)
   4) Gejala anemia (pucat, nadi cepat) Nadi > 100x per menit atau <60x per menit

b. Terkait Berat badan
   1) IMT >30
   2) BB turun>2kg/bulan pada trimester 1
   3) BB naik <1 kg/bulan pada trimester 2
   4) BB naik >2 kg/bulan pada trimester 3

c. Konseling Gizi Ibu Hamil

   Gizi selama kehamilan:
   1) Minum tablet tambah darah tiap hari
   2) Prinsip gizi seimbang bagi ibu hamil
   3) Pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil yaitu untuk memenuhi kebutuhan ibu sendiri serta perkembangan dan pertumbuhan janin
   4) Penambahan kebutuhan kalori dan zat gizi mikro selama hamil
   5) Cara memilih makanan yang tepat, contoh makanan dengan gizi seimbang bagi ibu hamil (makanan utama dan selingan yang padat gizi)
   6) Tidak ada pantangan makanan bagi ibu selama hamil, kecuali ada riwayat alergi

**Asesmen (Piramida Miller)**

| Level Miller | Metode |
|---|---|
| Knows / Knows How | Ujian berbasis skenario (CBT) **kasus anemia /masalah gizi** |
| Shows How | **OSCE manajemen awal dan rujukan kasus anemia /masalah gizi** |

## D. Aktivitas 1 — *Knows How*

**Ujian berbasis skenario (CBT)** kasus anemia /masalah gizi

Soal Skenario CBT:

1. Seorang perempuan, umur 19 tahun, G1P0A1 hamil 30 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mudah lelah sejak seminggu lalu. Hasil anamnesis: merasa pusing dan pandangan berkunang. Hasil pemeriksaan: TD 90/70 mmHg, N 96 x/menit, P 18 x/menit, S 36,8ºC, DJJ 140 x/menit, teratur, Hb 8 gr/dL. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut?
2. Seorang perempuan, umur 28 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 26 minggu, datang ke puskesmas untuk kunjungan ulang dengan keluhan mudah lelah. Hasil anamnesis: makan 2 kali sehari karena kurang nafsu makan, BB sebelum hamil 40 kg. Hasil pemeriksaan: KU baik, BB 48 kg, TB 150 cm, IMT 17,8 kg/m², LILA 20 cm, TD 110/80 mmHg, N 88 /menit, P 20 x/menit, S 36,6ºC, TFU 24 cm, DJJ 140 x/menit, teratur. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut?
3. Seorang perempuan, umur 26 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 24 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan kurang nafsu makan. Hasil anamnesis: sering berdiri lama karena bekerja sebagai penjaga toko, pola makan tidak teratur, jarang makan sayuran hijau dan protein hewani, BB sebelum hamil 50 kg. Hasil pemeriksaan: KU baik, BB 48 kg, TB 160 cm, IMT 19,5 kg/m², LILA 24 cm, TD 100/80 mmHg, N 80 /menit, P 22 x/menit, S 36,5ºC, konjungtifa pucat, TFU 22 cm, DJJ 148 x/menit, teratur. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut?

Jawaban Soal Skenario CBT:

1. Berdasarkan skenario kasus, sesuai kadar hemoglobin 8 gr/dL maka masuk kategori anemia dengan klasifikasi anemia sedang (7,0-9,9 gr/dL). Maka sesuai standar, tindakan bidan pada kasus tersebut berupa pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dengan dosis 2 tablet Fe 60 mg/hari (total 120 mg/hari). Pantau ulang kadar hemoglobin dalam 4 minggu. Jika kadar hemoglobin naik menjadi 11 gr.dL

atau lebih maka TTD dilanjutkan dengan dosis 1x 60 mg/hari untuk mencegah anemia berulang. Jika kadar hemoglobin tidak naik, evaluasi cara konsumsi, kepatuhan dan asupan nutrisi. Jika tidak ada kenaikan dalam 90 hari maka lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Jika kadar hemoglobin ditemkan < 7 gr/dL (Anemia berat), lakukan rujukan untuk tanfusi darah.

2. Berdasarkan data dalam soal didapatkan IMT 17,8 kg/m² (kurus), LILA 20 cm, maka dapat ditegakkan diagnosa Kuang Energi Kronis (KEK). tata laksana untuk ibu hamil dengan KEK:
   a. Ibu hamil KEK membutuhkan penambahan energi 500 kkal yang dapat diberikan berupa pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal atau PMT pabrikan dari kemenkes atau minuman padat gizi
   b. Untuk menangani ibu hamil KEK dibutuhkan kolaborasi dengan ahli gizi untuk perhitungan kebutuhan kalori dan pemberian diet termasuk komposisi zat gizi, bentuk makanan dan frekwensi pemeberian makanan dalam sehari
   c. Pantau Berat Badan ibu dan pertumbuhan janin, jika dalam 1 bulan kenaikan berat badan < 1 kg/bulan di trimester 1 atau < 2kg/bulan ditrimester 2 dan 3, atau hemoglobin <10 gr/dL maka lakukan rujukan.
3. Gejala mudah lelah, konjungtiva pucat, diet rendah zat besi (jarang makan sayur dan protein hewani), umur kehamilan 24 minggu mengarah ke gejala anemia defisiensi besi ringan pada kehamilan, kasus seperti ini masih bisa ditangani di TPMB. Tindakan yang paling tepat diberikan adalah memberikan suplementasi besi (Tablet Tambah Darah/TTD) 2-3 kali sehari dan edukasi pola makan bergizi berupa diet kaya zat besi ( sayuran hijau, daging, hati, ikan, telut, ayam, kacang-kacangan) serta cara konsusi TTD yang benar yaitu diminum dengan air putih atau jus buah. Menghindari teh, kopi, susu, obat mag dengan jarak waktu 2 jam.

## E. Latihan Soal

| | | |
|---|---|---|
| 1. | No. station | 3 |
| 2. | Waktu yang dibutuhkan | 10 menit |
| 3. | Judul stasiun: kasus yang akan diujikan | ***BOLD*** salah satu kategori:<br><br>1. Masa Antara/**prakonsepsi: normal**/deteksi dini<br>2. Kehamilan Normal<br>3. Kehamilan: Deteksi Dini/Gadar<br>4. Persalinan Normal |

| | | |
|---|---|---|
| | | 5. Persalinan: Deteksi Dini/Gadar<br>6. Nifas/Masa Laktasi: Normal/Deteksi Dini<br>7. Neonatus sd. 28 hari: Normal/Deteksi Dini/Gadar<br>8. Keluarga Berencana: Normal/Deteksi dini |
| 4. | Kasus | **Pendidikan Kesehatan tentang Tablet Tambah Darah pada Catin** |
| 5. | Tujuan: memberi penilaian pada kompetensi yang diujikan | ***BOLD*** kompetensi yang akan diujikan<br>1. **Anamnesis**<br>2. **Pemeriksaan fisik** dan/atau laboratorium sederhana<br>3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah<br>4. Prosedur tindakan klinis<br>5. **KIE/konseling**<br>6. Kolaborasi/Rujukan<br>7. Pendokumentasian<br>8. **Perilaku profesional** |
| 6. | Soal: **Skenario** kasus dan **Tugas** | **Skenario klinis:**<br>Seorang perempuan, umur 23 tahun, datang ke Puskesmas untuk menjalani pemeriksaan calon pengantin. Hasil anamnesis: rencana menikah bulan depan, mengeluh sering lemas dan pusing. Hasil pemeriksaan laboratorium: Hb: 9 gr/dL.<br><br>**Tugas:**<br>1. Lakukan anamnesis 4 pertanyaan terfokus tanpa harus menanyakan biodata/hal lain.<br>Bila penguji menyebutkan "tidak ada data", Anda tidak perlu menanyakan atau mengulang dengan pertanyaan serupa.<br>2. Lanjutkan pemeriksaan terfokus (antopometri, TD, Nadi, pemeriksaan fisik terfokus)<br>Setelah selesai melakukan pemeriksaan, ambil kertas yang berisikan hasil pemeriksaan dari penguji.<br>3. Lakukan KIE/konseling terkait pemberian tablet tambah darah pada catin |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Instruksi penguji | **INSTRUKSI PENGUJI**<br>**Instruksi Umum**:<br>1. Pastikan identitas peserta sesuai dengan kartu ujian<br>2. Tulislah 4 digit terakhir atau minimal 2 digit dari nomor peserta ujian pada lembar penilaian.<br>3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian:<br>• *Actual mark* (0/1/2/3)<br>• *Global rating* (TL/B/L/S)<br>4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.<br>5. Taat aturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE.<br>**Instruksi Khusus**:<br>1. Penguji boleh mendekati peserta ujian bila jarak pandang kurang jelas untuk mengamati peserta ujian ketika melakukan tindakan. Syaratnya, penguji harus menghindari kontak mata dengan cara berdiri di belakang punggung peserta;<br>2. Setelah peserta ujian selesai melakukan pemeriksaan, **penguji menyerahkan catatan yang berisikan:**<br>• **BB 52 kg, TB 150 cm, LILA 24 cm**<br>• **TD 90/70 mmHg, N 78 x/menit**<br>• **Wajah pucat, konjungtiva pucat, bibir pucat**<br>• **Hb : 9 gr%**<br>3. Penguji menyebutkan **"tidak ada data"** bila pertanyaan atau pernyataan tidak sesuai dengan skenario. Bila peserta ujian telah menanyakan 3 pertanyaan fokus, penguji dapat menyebutkan **"cukup, silakan melanjutkan ke pemeriksaan".** |

<table>
<tr><td></td><td></td><td><u>Tugas tambahan:</u><br>Bersama dengan laboran merapikan alat untuk digunakan oleh peserta ujian yang berikutnya</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Kebutuhan dan Instruksi pasien/pemeran simulasi yang terstandar</td><td>Ada, seorang perempuan yang dikondisikan sekitar umur 19 tahun, berpakaian rapi, duduk berhadapan dengan peserta ujian yang dibatasi oleh meja kerja.<br>Dialog Peserta Ujian (PU) dengan Pasien Simulasi (PS)
<table>
<tr><th>PU</th><th>PS</th></tr>
<tr><td>Menyapa PS</td><td>Membalas sapaan (tidak dilakukan bila PU tidak menyapa)</td></tr>
<tr><td>Anamnesis :<br>• Mengklarifikasi maksud kedatangan pasien<br>• Menanyakan siklus haid<br>• Menanyakan kapan haid terakhir<br>• Apakah ada masalah dengan haid<br>• Menanyakan pola istirahat<br>• Menanyakan kebiasaan pola makan/ minum</td><td>• Menjawab “mau pemeriksaan calon pengantin ” sambil agak tersipu<br>• Menjawab “teratur, sekitar 28-30 hari”<br>• Menjawab “1 minggu yang lalu”<br>• Menjawab “tidak ada masalah”<br>• Menjawab “sering begadang pada malam hari”<br>• Menjawab “sering mengkonsumsi mie instan dan makanan siap saji”</td></tr>
<tr><td>Pemeriksaan:<br>• Mengukur tekanan darah<br>• Mengukur tinggi</td><td>• Menunjuk/memegang model anatomi lengan</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>badan, berat badan, dan LILA<br><br>• Meminta PS kembali ke tempat duduk</td><td>• Ikuti saja ke arah mana posisi timbangan dan alat pengukur tinggi badan yang ditunjukkan oleh peserta ujian. Ikuti perintah dari peserta ujian.<br>• Ikuti saja dan duduk kembali di tempat semula</td></tr>
<tr><td>KIE/konseling:<br>1. Menjelaskan kondisi pasien bahwa pasien dengan mengalami anemia<br>2. Menjelaskan kepada pasien terkait dengan pemberian tablet tambah darah</td><td>1. “iya”<br><br>2. “iya”, sambil memperhatikan tablet tambah darah yang akan diberikan</td></tr>
<tr><td>Mengakhiri pertemuan<br>Mengucapkan salam penutup</td><td>Membalas salam sambil mengucapkan “terima kasih”</td></tr>
</table>
Catatan:<br>PS diam saja bila:<br>• Peserta ujian menanyakan diluar skenario<br>• Penguji mengatakan tidak ada data
</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Tipe Ruangan</td><td>Ruang pemeriksaan</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Kebutuhan laboran</td><td>Ada, dengan tugas:<br>Merapikan alat yang telah digunakan seperti semula untuk persiapan peserta yang berikutnya</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Kebutuhan manekin dan alat</td><td>Ada,<br>- Model anatomi tangan yang dapat digunakan untuk dipasang manset ketika melakukan prosedur pemeriksaan tekanan darah</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- Model anatomi tersebut diletakkan di sisi tempat tidur<br><br><table><tr><th>Jenis alat dan bahan</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Baki yang dialasi dengan kain hijau berisikan:<br>▪ sarung tangan<br>▪ Lila meter<br>▪ 1 set Tensimeter aneroid<br>▪ Thermometer digital<br>▪ Alkohol swab<br>▪ Tisu<br>▪ Hand sanitizer<br>▪ Jam tangan</td><td>Sejumlah peserta + cadangan<br>2<br>2<br>2<br>2<br>Sejumlah peserta + cadangan<br>Secukupnya<br>1<br>1</td></tr><tr><td>▪ Timbangan BB dan TB</td><td>1 set</td></tr><tr><td>▪ Tempat sampah medis/non-medis</td><td>1/1 buah</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Penulis</td><td>Jurusan Kebidanan</td></tr>
<tr><td></td><td>Reviewer</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Referensi</td><td>Kementerian Kesehatan RI, 2021. Buku Saku Merencanakan Kehamilan Sehat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kompetensi yang diujikan</th><th>Prosedur</th><th>Skoring</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Anamnesis tentang haid</td><td>Peserta ujian menanyakan minimal 4 data focus:<br>Menanyakan haid terakhir<br>Menanyakan masalah haid</td><td><table><tr><td colspan="2">Skor</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>Bobot</td><td>AM</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>Semua (4) pertanyaan dilakukan dengan tepat</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>3 dari 4 pertanyaan dilakukan</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Menanyakan pola istirahat<br>Menanyakan pola makan/ minum</td><td><table><tr><td></td><td>1</td><td>2 dari 4 pertanyaan dilakukan</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>Tidak dilakukan</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>Pemeriksaan antropometri (BB,TB,LILA), Tanda Vital (TD,N), pemeriksaan fisik terfokus (wajah, bibir, mata)</td><td>Peserta ujian melakukan langkah-langkah berikut ini:<br>Mempersiapkan alat<br>Mempersiapkan diri<br>Melakukan pemeriksaan BB ,TB dan LILA<br>Memposisikan pasien dengan tepat<br>Menilai hasil ukur BB<br>Menilai hasil ukur TB<br>Menilai hasil ukur LILA<br>Mengukur Tanda Vital (Tekanan darah, Nadi)<br>Menilai hasil ukur tekanan darah</td><td><table><tr><td colspan="2">Skor</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>Bobot</td><td>AM</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>Semua (11) langkah dilakukan dengan tepat</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>8-10 dari 11 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian kecil kurang tepat</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>4-7 dari 11 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian besar kurang tepat</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td><4 yang dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali atau semua langkah dilakukan tetapi tidak ada satu pun yang tepat</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Menilai hasil ukur Nadi<br>Melakukan pemeriksaan fisik terfokus untuk mengecek gejala anemia<br>Memeriksa pucat pada wajah<br>Memeriksan pucat pada konjungtiva<br>Meneriksa pucat pada bibir</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>KIE/konseling: masa subur</td><td>Peserta ujian melakukan langkah-langkah berikut ini:<br>Mendiskusikan kondisi pasien saat ini<br>Menjelaskan tentang dampak anemia pada catin<br>Menjelaskan tentang pemberian tablet tambah darah<br>Memberikan kesempatan /</td><td><table>
<tr><td colspan="2">Skor</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>AM</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>3</td><td>Semua (5) langkah dilakukan dengan tepat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3-4 dari 5 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian kecil kurang tepat</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1-2 dari 5 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian besar kurang tepat</td></tr>
<tr><td>0</td><td>Tidak dilakukan atau semua langkah dilakukan tetapi tidak</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>menanggapi respon pasien<br>Menyimpulkan hasil diskusi/konseling</td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>ada satu pun yang tepat</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Perilaku professional: komunikasi dan kinerja</td><td>Peserta ujian menunjukkan perilaku profesional seperti berikut ini:<br>Komunikasi:<br>Mempertahankan kontak mata<br>Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti<br>Bersuara dengan intonasi yang jelas<br>Mempertahankan komunikasi 2 arah<br>Kinerja:<br>Mengutamakan keselamatan pasien, diri, dan lingkungan<br>Menerapkan prinsip PI</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">Skor</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>Bobot</td><td>AM</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>3</td><td>Semua (8) perilaku profesional ditunjukkan oleh peserta ujian</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5-7 dari 8 perilaku profesional ditunjukkan oleh peserta ujian</td></tr>
<tr><td>1</td><td>3-4 dari 8 perilaku profesional ditunjukkan oleh peserta ujian</td></tr>
<tr><td>0</td><td><2 yang ditunjukkan atau Tidak ditunjukkan satu pun perilaku professional oleh peserta ujian</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Berkomunikasi walaupun berhadapan dengan model anatomi<br>Menjaga privasi | |

Global Rating Scale ( Global Performance)

Lingkari huruf yang sesuai penilaian global rating scale untuk penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

| TIDAK LULUS (TL) | BORDERLINE (B) | LULUS (L) |
|---|---|---|

Keterangan: Global Performance dibawah rata-rata mahasiswa borderline (Tidak Lulus/TL), Global Performance meragukan (Borderline/B),

Global Performance baik (Lulus/L), Global Performance sangat meyakinkan (Superior/S)

## F. Ringkasan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa deteksi dini anemia dan masalah gizi pada ibu hamil merupakan bagian penting dalam pelayanan antenatal terpadu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu sejak awal kehamilan sehingga berbagai risiko seperti perdarahan, bayi berat badan lahir rendah, prematuritas, stunting, hingga kematian ibu dan bayi dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat menentukan proses persalinan serta kesehatan bayi yang dilahirkan.

Anemia pada ibu hamil ditandai dengan kadar hemoglobin di bawah normal, yaitu kurang dari 11 g/dL. Rendahnya kadar hemoglobin menyebabkan terganggunya pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh sehingga menimbulkan keluhan seperti lesu, letih, lemah, lelah, lalai, pusing, berdebar, sesak napas, pucat,

bahkan gangguan fungsi organ pada kondisi berat. Penyebab anemia dapat berasal dari kurangnya asupan zat gizi, perdarahan, maupun faktor keturunan.

Skrining anemia wajib dilakukan melalui pemeriksaan kadar hemoglobin minimal dua kali selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan trimester ketiga. Berdasarkan hasil Hb, anemia pada ibu hamil dapat diklasifikasikan menjadi anemia ringan, sedang, dan berat, sehingga tindak lanjut dapat diberikan sesuai kondisi ibu. Ibu hamil yang tidak anemia tetap diberikan edukasi hamil sehat, sedangkan ibu dengan anemia perlu memperoleh tatalaksana sesuai standar atau dirujuk apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Selain anemia, masalah gizi pada ibu hamil juga perlu dideteksi melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar lengan atas, serta penentuan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh. Pemantauan kenaikan berat badan selama kehamilan penting untuk menilai kesehatan ibu dan perkembangan janin. Jika ditemukan Kekurangan Energi Kronik atau risiko KEK, ibu perlu mendapatkan makanan tambahan, konseling gizi, serta pemantauan secara berkala.

Dengan demikian, deteksi dini anemia dan masalah gizi tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemeriksaan, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan edukasi, konseling, pemberian Tablet Tambah Darah, makanan tambahan, pemantauan, kolaborasi, maupun rujukan. Bidan memiliki peran penting dalam melakukan penapisan, memberikan informasi yang mudah dipahami, membantu ibu memperbaiki pola makan, serta memastikan ibu hamil memperoleh pelayanan yang aman, tepat, dan berkelanjutan. Penguatan deteksi dini dan konseling gizi diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ibu, mendukung pertumbuhan janin, serta menurunkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan.

## G. Daftar Pustaka


Aditya MartantyDestianita ChresianiRahmawati Yeni (2021) "The Effect of Blood Supplementation Tablet Consumption on the Delivery Process and Haemoglobin Levels in Pregnant Women" National Semonar University Od Ma Chung3037 DOI: https://doi.org/10.33479/snumc.v1i.216

Apri Sulistianingsih, Nurwinda Saputri, St Halimatusyaadiah, Yeti Septiasari, Ni Gusti Ayu Pramita Aswitami, Baiq Iin Rumintang, Lina Sundayani, Nur Amsiah. (2023). Effect of new Maternal and Child Health Book on Iron Supplementation Obedience and Labour Outcome in Pregnant Women, Pringsewu District, Lampung Province, Indonesia. Jurnal Africa Journal of Nursing & Midwifery. https://journals.co.za/doi/abs/10.25159/2520-5293/12897

Astari Ruri YuniKirani Tita (2020), "Relationship of Knowledge Level with the Utilization of Maternal and Child Health (MCH) Books in Pregnant Women" Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung 122 DOI: https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v12i2.1786

Beaton, G. H. (2000). Iron needs during pregnancy: do we need to rethink our targets? Am J Clin Nutr, 72, 265S–71S.

deficiency in pregnant women. Taiwanese Journal of

Hariyani.Sri, D. (2019). Prevention of Anemia in Pregnant Women at the Kuta Baro Health Center, Aceh Besar. JIM FKEP, IV(1), 122–127.

Imai, K. (2020). Parity-based assessment of anemia and iron

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Antenatal terpadu Edisi ketiga. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan RI. (2023). Buku Saku Pencegahan Anemia pada Ibu Hamil dan Remaja Putri. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Kesehatan RI. (2024). Pedoman Kerja Puskesmas Klaster II Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Obstetrics and Gynecology, 59(6), 838–841.

Setiawati, A., & Rumintang, B. I. (2019). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Tablet Tambah Darah (TTD) Pada Kelas Ibu Hamil Terhadap Kepatuhan Ibu Dalam Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah Di UPT BLUD Puskesmas Meninting Tahun 2018. Jurnal Midwifery Update (MU), 1(1), 28–36. https://doi.org/10.32807/jmu.v1i1.36

# BAB 4

## KELUHAN UMUM KEHAMILAN: PENILAIAN PENYEBAB DAN TATA LAKSANA NON FARMAKOLOGIS"

**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menguasai konsep ilmiah dan evidence-based terkait pemeriksaan antenatal terpadu. | CPMK-1, CPMK-5 |
| CPL-2 | Mampu melaksanakan pemeriksaan antenatal terpadu secara sistematis, aman, dan efektif. | CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4 |
| CPL-3 | Mampu menginterpretasi temuan klinis dan penunjang untuk mengenali masalah serta risiko kehamilan. | CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6 |
| CPL-4 | Mampu menetapkan tindak lanjut, intervensi awal, dan rencana rujukan berdasarkan hasil pemeriksaan. | CPMK-6, CPMK-7 |
| CPL-5 | Mampu berkomunikasi terapeutik dan melakukan konseling kesehatan ibu secara kolaboratif. | CPMK-2, CPMK-7 |
| CPL-6 | Menunjukkan profesionalisme (etika, privasi, keselamatan pasien, pencegahan infeksi, dokumentasi) dalam pelayanan ANC. | CPMK-1, CPMK-3, CPMK-7 |

**CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Menganalisis konsep dasar pemeriksaan antenatal terpadu, standar pelayanan ANC, serta prinsip privasi, keselamatan pasien, dan pencegahan infeksi. |
| CPMK-2 | Melaksanakan anamnesis terstruktur pada ibu hamil untuk menghimpun data penting dan mengenali faktor risiko. |
| CPMK-3 | Melaksanakan pemeriksaan tanda vital, antropometri, dan pemeriksaan fisik umum ibu hamil sesuai prosedur serta menafsirkan temuan dasar. |

| | |
|---|---|
| CPMK-4 | Melaksanakan pemeriksaan abdomen obstetri dan penilaian kesejahteraan janin secara sistematis serta menginterpretasi hasil pemantauan klinis. |
| CPMK-5 | Menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang kehamilan (laboratorium dasar dan USG) dan mengintegrasikannya dengan temuan klinis. |
| CPMK-6 | Mengidentifikasi tanda bahaya dan masalah prioritas pada kehamilan (termasuk hipertensi/preeklamsia, anemia/gizi, keluhan umum) serta menetapkan tindak lanjut awal dan kebutuhan rujukan. |
| CPMK-7 | Melaksanakan konseling ANC terpadu dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam format standar untuk mendukung keputusan klinis dan komunikasi layanan. |

**Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK**

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 1. Konsep Dasar Pemeriksaan Antenatal Terpadu dan Standar Pelayanan ANC | 1.1 Menjelaskan tujuan, komponen, dan alur pemeriksaan antenatal terpadu. | 1.2 Menguraikan standar pelayanan ANC (jadwal, komponen minimal, indikator mutu) sebagai dasar praktik. | CPMK-1 | CPMK-7 |
| Bab 2. Persiapan Pemeriksaan ANC: Alat, Lingkungan, Privasi, dan Pencegahan Infeksi | 2.1 Menyiapkan alat, lingkungan, dan alur pemeriksaan yang ergonomis dan aman. | 2.2 Menerapkan privasi, informed consent, dan pencegahan infeksi selama ANC. | CPMK-1 | CPMK-3; CPMK-7 |
| Bab 3. Anamnesis Terstruktur pada Ibu Hamil: Riwayat Obstetri, Penyakit, dan Faktor Risiko | 3.1 Melakukan anamnesis terstruktur mencakup riwayat obstetri, penyakit, obat, dan faktor sosial. | 3.2 Menyusun faktor risiko dan prioritas tindak lanjut dari hasil anamnesis. | CPMK-2 | CPMK-6; CPMK-7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bab 4. Pemeriksaan Tanda Vital dan Antropometri Ibu Hamil: Teknik dan Interpretasi | 4.1 Melakukan pengukuran tanda vital sesuai prosedur. | 4.2 Mengukur antropometri dan menafsirkan implikasinya pada kehamilan. | CPMK-3 | CPMK-6 |
| Bab 5. Pemeriksaan Fisik Umum: Kepala–Leher, Jantung–Paru, Abdomen Non-Obstetri, dan Ekstremitas | 5.1 Melakukan pemeriksaan fisik umum sistematis dengan teknik pemeriksaan yang tepat. | 5.2 Mengidentifikasi temuan abnormal yang relevan terhadap kehamilan. | CPMK-3 | CPMK-6; CPMK-1 |
| Bab 6. Pemeriksaan Abdomen Obstetri: Leopold, Tinggi Fundus, Presentasi, dan Penurunan Bagian Terendah | 6.1 Melakukan manuver Leopold, mengukur tinggi fundus, dan menilai presentasi/posisi janin. | 6.2 Menilai penurunan bagian terendah dan kesesuaian usia kehamilan berbasis TFU. | CPMK-4 | CPMK-3; CPMK-6 |
| Bab 7. Penilaian Kesejahteraan Janin: DJJ, Gerak Janin, dan Pemantauan Pertumbuhan | 7.1 Menilai kesejahteraan janin melalui DJJ dan pola gerak janin. | 7.2 Mengevaluasi pertumbuhan janin berbasis pemantauan klinis serial dan menentukan kebutuhan pemantauan lanjut. | CPMK-4 | CPMK-6; CPMK-5 |
| Bab 8. Pemeriksaan Penunjang Kehamilan: Laboratorium Dasar, USG, dan Interpretasi Hasil | 8.1 Menentukan pemeriksaan penunjang dasar kehamilan sesuai indikasi dan waktu pemeriksaan. | 8.2 Menginterpretasi hasil laboratorium/USG dan mengintegrasikan dengan temuan klinis. | CPMK-5 | CPMK-6; CPMK-1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bab 9. Identifikasi Tanda Bahaya Kehamilan: Perdarahan, Nyeri Hebat, Demam, dan Penurunan Gerak Janin | 9.1 Mengenali tanda bahaya utama melalui anamnesis terarah dan pemeriksaan cepat. | 9.2 Menentukan tindakan awal dan keputusan rujukan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan. | CPMK-6 | CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7 |
| Bab 10. Deteksi Dini Hipertensi Kehamilan dan Preeklamsia: Skrining, Kriteria, dan Tindak Lanjut | 10.1 Melaksanakan skrining hipertensi/preeklamsia melalui teknik pengukuran dan penilaian gejala. | 10.2 Menerapkan kriteria tindak lanjut/rujukan pada hipertensi/preeklamsia berdasarkan derajat. | CPMK-6 | CPMK-3; CPMK-5 |
| Bab 11. Deteksi Dini Anemia dan Masalah Gizi: Hb, Status Gizi, dan Intervensi Awal | 11.1 Melakukan skrining anemia dan status gizi serta klasifikasi derajat masalah. | 11.2 Menetapkan intervensi awal dan indikator pemantauan perbaikan. | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-7 |
| Bab 12. Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Nonfarmakologis | 12.1 Mengkaji keluhan umum untuk membedakan fisiologis vs patologis. | 12.2 Memberikan tata laksana nonfarmakologis dan menentukan indikasi evaluasi lanjut/rujukan. | CPMK-6 | CPMK-2; CPMK-7 |
| Bab 13. Konseling ANC Terpadu: Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan | 13.1 Melaksanakan konseling ANC terpadu mencakup gizi, aktivitas, tanda bahaya, dan kepatuhan kunjungan. | 13.2 Menyusun rencana persalinan dan rencana rujukan bersama ibu/keluarga. | CPMK-7 | CPMK-6; CPMK-1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bab 14. Dokumentasi Hasil Pemeriksaan ANC: SOAP/Format ANC, Buku KIA, dan Keputusan Klinis | 14.1 Mendokumentasikan hasil ANC pada format standar secara lengkap dan legal. | 14.2 Mensintesis data untuk keputusan klinis dan komunikasi antar-layanan. | CPMK-7 | CPMK-5; CPMK-6; CPMK-1 |

## Uraian Materi

Keluhan umum kehamilan merupakan kondisi ketidaknyamanan yang sering dialami oleh ibu hamil sebagai akibat dari proses adaptasi fisiologis tubuh terhadap kehamilan. Perubahan ini melibatkan berbagai sistem tubuh, termasuk sistem hormonal, gastrointestinal, kardiovaskular, dan muskuloskeletal. Hormon kehamilan seperti *human chorionic gonadotropin* (hCG), estrogen, dan progesteron meningkat secara signifikan dan berperan dalam munculnya berbagai keluhan, terutama pada trimester pertama (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, 2018). Selain itu, pembesaran uterus serta perubahan postur tubuh juga turut memengaruhi munculnya keluhan fisik pada ibu hamil.

Keluhan yang umum dijumpai antara lain mual dan muntah, pusing, nyeri punggung, konstipasi, serta sering berkemih. Mual dan muntah (*emesis gravidarum*) merupakan keluhan yang paling sering terjadi, terutama pada trimester pertama, dan berkaitan erat dengan peningkatan hormon HCG (Matthews et al., 2015) . Pusing dapat disebabkan oleh perubahan hemodinamik, seperti penurunan tekanan darah akibat vasodilatasi (Cunningham et al., 2022). Nyeri punggung terjadi akibat perubahan pusat gravitasi tubuh serta peningkatan beban pada tulang belakang (Vermani et al., n.d.) Sementara itu, konstipasi disebabkan oleh perlambatan motilitas usus akibat pengaruh hormon progesteron(Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

Sebagian besar keluhan tersebut bersifat fisiologis, artinya merupakan bagian dari proses normal kehamilan dan tidak membahayakan ibu maupun janin. Namun demikian, tenaga kesehatan perlu melakukan penilaian secara cermat untuk membedakan antara keluhan fisiologis dan kondisi patologis. Keluhan dikatakan patologis apabila bersifat berat, menetap, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai tanda bahaya, seperti muntah berlebihan, penurunan berat badan, dehidrasi, atau gangguan kesadaran (American College of Obstetricians and Gynecologists (Gynecologists, 2018). Oleh karena itu, kemampuan dalam melakukan *assessment* yang tepat sangat penting dalam pelayanan antenatal care (ANC).

Penilaian keluhan dilakukan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis meliputi penggalian informasi mengenai jenis keluhan, durasi, frekuensi, faktor pencetus, serta dampaknya terhadap aktivitas ibu. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai kondisi umum ibu, termasuk tanda vital dan status hidrasi. Selain itu, tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi adanya tanda bahaya yang memerlukan penanganan lebih lanjut atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi(World Health Organization, 2020)

Tata laksana keluhan umum kehamilan pada kondisi ringan hingga sedang umumnya dilakukan dengan pendekatan nonfarmakologis. Pendekatan ini dipilih

karena aman bagi ibu dan janin, mudah dilakukan, serta memiliki risiko efek samping yang minimal. Pada keluhan mual dan muntah, ibu dianjurkan untuk makan dalam porsi kecil tetapi sering, menghindari makanan berlemak dan berbau tajam, serta mengonsumsi bahan alami seperti jahe. Selain itu, terapi tambahan seperti aromaterapi dan akupresur juga terbukti efektif dalam mengurangi gejala (Matthews et al., 2015)

Pada keluhan pusing, ibu dianjurkan untuk beristirahat yang cukup, menghindari perubahan posisi secara tiba-tiba, serta memastikan asupan cairan yang adekuat. Nyeri punggung dapat diatasi dengan memperbaiki postur tubuh, melakukan senam hamil, serta menggunakan kompres hangat pada area yang nyeri (Vermani et al., 2010). Untuk konstipasi, ibu dianjurkan meningkatkan konsumsi makanan berserat, memperbanyak minum air, serta melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

Selain penatalaksanaan, aspek edukasi dan konseling juga menjadi bagian penting dalam asuhan kehamilan. Tenaga kesehatan perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kondisi yang dialami ibu, cara mengatasi keluhan, serta tanda bahaya yang harus diwaspadai. Konseling yang efektif akan membantu meningkatkan pemahaman ibu, meningkatkan kepatuhan terhadap anjuran kesehatan, serta mencegah terjadinya komplikasi (World Health Organization, 2020)

Apabila keluhan tidak membaik dengan penatalaksanaan nonfarmakologis atau disertai tanda bahaya, maka ibu hamil perlu dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dengan demikian, pendekatan yang sistematis, berbasis evidence, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan janin menjadi kunci dalam penatalaksanaan keluhan umum kehamilan.

## A. Konsep Dasar Kehamilan

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang dimulai dari fertilisasi hingga kelahiran janin. Menurut World Health Organization (WHO), kehamilan adalah kondisi di mana seorang wanita mengandung embrio atau janin di dalam uterus selama kurang lebih 40 minggu sejak hari pertama haid terakhir (World Health Organization, 2020)

Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis yang meliputi sistem hormonal, kardiovaskular, muskuloskeletal, serta gastrointestinal. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, namun juga dapat menimbulkan berbagai keluhan yang bersifat fisiologis.

## B. Keluhan Umum pada Kehamilan

Keluhan umum kehamilan adalah ketidaknyamanan yang sering dialami oleh ibu hamil sebagai akibat dari perubahan fisiologis selama masa gestasi. Perubahan ini terjadi sebagai bentuk adaptasi tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Meskipun sebagian besar keluhan bersifat ringan dan tidak berbahaya, kondisi ini dapat memengaruhi kenyamanan serta kualitas hidup ibu hamil sehari-hari (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

Perubahan fisiologis yang terjadi meliputi peningkatan hormon, perubahan sistem peredaran darah, pembesaran uterus, serta perubahan postur tubuh. Hormon progesteron, misalnya, dapat menyebabkan relaksasi otot polos sehingga berdampak pada sistem pencernaan dan memicu keluhan seperti konstipasi dan heartburn. Sementara itu, peningkatan hormon hCG dan estrogen berperan dalam munculnya mual dan muntah pada awal kehamilan (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, 2018)

Keluhan pada kehamilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluhan fisiologis dan keluhan patologis.

**1. Keluhan fisiologis**

Keluhan fisiologis merupakan keluhan yang normal terjadi selama kehamilan dan merupakan bagian dari proses adaptasi tubuh ibu. Contohnya meliputi mual dan muntah ringan, sering buang air kecil, nyeri punggung, kelelahan, dan konstipasi. Keluhan ini biasanya tidak memerlukan pengobatan khusus dan dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup atau pendekatan nonfarmakologis. Namun, tetap diperlukan pemantauan untuk memastikan keluhan tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius(Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, 2015)

**2. Keluhan patologis**

Keluhan patologis adalah keluhan yang tidak normal, bersifat berat, atau menunjukkan adanya gangguan kesehatan yang dapat membahayakan ibu maupun janin. Contohnya seperti muntah berlebihan (hiperemesis gravidarum), perdarahan, nyeri hebat, atau edema yang disertai hipertensi. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera karena berisiko menimbulkan komplikasi (American College of Obstetricians and Gynecologists (Gynecologists, 2018)

Penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk mampu membedakan kedua jenis keluhan tersebut melalui penilaian yang tepat. Deteksi dini terhadap keluhan patologis sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut serta meningkatkan keselamatan ibu dan janin.

## C. Jenis-Jenis Keluhan Umum pada Kehamilan

1. **Mual dan Muntah (Nausea and Vomiting of Pregnancy)**

Mual dan muntah merupakan keluhan yang paling sering dialami oleh ibu hamil, terutama pada trimester pertama. Kondisi ini biasanya mulai muncul pada usia kehamilan 4–6 minggu dan mencapai puncaknya pada minggu ke-8 hingga ke-12, kemudian akan berangsur membaik setelah trimester pertama (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, 2018)

Mual dan muntah pada kehamilan terutama disebabkan oleh peningkatan hormon human chorionic gonadotropin (hCG) dan estrogen. Selain itu, faktor lain seperti sensitivitas lambung, perubahan metabolisme karbohidrat, serta faktor psikologis juga dapat berperan dalam memperberat gejala (Matthews et al., 2015)

Gejala yang dialami dapat berupa rasa mual, muntah, penurunan nafsu makan, serta ketidaknyamanan terhadap bau tertentu. Kondisi ini sering disebut sebagai morning sickness, meskipun pada kenyataannya dapat terjadi kapan saja sepanjang hari.

Pada sebagian besar kasus, mual dan muntah bersifat ringan dan tidak membahayakan. Namun, apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu keadaan mual dan muntah yang berat dan berlebihan hingga menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, serta penurunan berat badan. Hiperemesis gravidarum memerlukan penanganan medis lebih lanjut karena dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin(Gynecologists, 2018)

Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan penilaian secara tepat terhadap frekuensi, durasi, serta tingkat keparahan gejala, sehingga dapat membedakan antara kondisi fisiologis dan patologis serta menentukan penatalaksanaan yang sesuai.

2. **Nyeri Punggung**

Nyeri punggung merupakan salah satu keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Keluhan ini terjadi akibat perubahan pusat gravitasi tubuh seiring dengan bertambahnya ukuran uterus, sehingga ibu cenderung menyesuaikan postur tubuhnya dengan condong ke belakang. Kondisi ini menyebabkan peningkatan beban pada otot punggung dan tulang belakang(Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, 2015)

Selain itu, peningkatan hormon relaksin selama kehamilan menyebabkan pelonggaran ligamen, terutama pada daerah panggul dan tulang belakang. Pelonggaran ini bertujuan mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan, namun juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi dan memicu nyeri punggung.

Faktor lain yang turut berperan antara lain peningkatan berat badan, kelemahan otot perut, serta kebiasaan postur tubuh yang kurang baik, seperti berdiri atau duduk terlalu lama. Aktivitas sehari-hari yang tidak ergonomis juga dapat memperberat keluhan(Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

Nyeri punggung biasanya dirasakan pada daerah lumbal (punggung bawah) dan dapat menjalar ke panggul atau paha. Pada umumnya, kondisi ini bersifat fisiologis dan tidak berbahaya. Namun, apabila nyeri dirasakan sangat hebat, menetap, atau disertai gejala lain seperti kesemutan, kelemahan ekstremitas, atau gangguan mobilitas, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menyingkirkan kondisi patologis.

Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan penilaian terhadap karakteristik nyeri, faktor pencetus, serta dampaknya terhadap aktivitas ibu, sehingga dapat menentukan penatalaksanaan yang tepat.

**3. Sering Buang Air Kecil**

Sering buang air kecil merupakan keluhan yang umum dialami oleh ibu hamil, terutama pada trimester pertama dan trimester ketiga. Kondisi ini terjadi akibat tekanan uterus yang membesar terhadap kandung kemih, sehingga kapasitas kandung kemih menjadi berkurang (Prawirohardjo, 2016)

Pada trimester pertama, peningkatan frekuensi berkemih juga dipengaruhi oleh perubahan hormonal dan peningkatan aliran darah ke ginjal. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi urine (diuresis). Sementara itu, pada trimester ketiga, keluhan kembali meningkat karena posisi janin yang mulai turun ke panggul sehingga menekan kandung kemih secara langsung (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, 2018)

Selain faktor mekanis dan hormonal, peningkatan laju filtrasi glomerulus selama kehamilan juga berkontribusi terhadap peningkatan volume urine(Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020) . Akibatnya, ibu hamil menjadi lebih sering merasakan keinginan untuk berkemih, bahkan pada malam hari (nokturia).

Keluhan ini umumnya bersifat fisiologis dan tidak berbahaya. Namun, tenaga kesehatan perlu membedakan kondisi ini dengan gangguan patologis, seperti infeksi saluran kemih (ISK). Jika sering buang air kecil disertai dengan nyeri saat berkemih, rasa terbakar, urine keruh, atau demam, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Oleh karena itu, penting dilakukan penilaian yang tepat melalui anamnesis dan pemeriksaan sederhana untuk memastikan bahwa keluhan yang dialami masih dalam batas normal kehamilan.

**4. Konstipasi**

a. Pengertian

Konstipasi merupakan kondisi sulit buang air besar yang ditandai dengan frekuensi defekasi yang jarang, feses keras, serta perasaan tidak tuntas setelah buang air besar. Pada kehamilan, konstipasi merupakan keluhan yang umum terjadi akibat perubahan fisiologis dalam tubuh ibu (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

b. Penyebab

Konstipasi pada kehamilan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot polos usus
2) Tekanan uterus yang membesar terhadap usus
3) Kurangnya asupan serat dan cairan
4) Penurunan aktivitas fisik
5) Konsumsi suplemen zat besi yang dapat memperkeras feses(Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, 2018)(Prawirohardjo, 2016)

c. Patofisiologi

Peningkatan hormon progesteron selama kehamilan menyebabkan relaksasi otot polos, termasuk pada saluran pencernaan. Akibatnya, peristaltik usus menjadi lebih lambat sehingga waktu transit makanan di dalam usus meningkat. Kondisi ini menyebabkan penyerapan air dari feses menjadi lebih banyak, sehingga feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan.

Selain itu, pembesaran uterus memberikan tekanan pada usus, terutama kolon, sehingga menghambat pergerakan feses. Kombinasi antara perlambatan motilitas usus dan tekanan mekanis ini menjadi penyebab utama terjadinya konstipasi pada ibu hamil(Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

d. Asuhan / Tata Laksana Nonfarmakologis (Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, 2015)(Sulistyawati, 2013)

Penatalaksanaan konstipasi pada kehamilan umumnya dilakukan dengan pendekatan nonfarmakologis, meliputi:

1) Peningkatan asupan serat
   - Mengonsumsi sayur, buah, dan biji-bijian

- Serat membantu meningkatkan massa feses dan merangsang peristaltik usus

2) Peningkatan asupan cairan
   - Minum air minimal 8 gelas per hari
   - Membantu melunakkan feses
3) Aktivitas fisik ringan
   - Jalan kaki atau senam hamil
   - Meningkatkan motilitas usus
4) Kebiasaan buang air besar yang teratur
   - Tidak menahan keinginan BAB
   - Membiasakan waktu BAB yang teratur
5) Edukasi ibu hamil
   - Menjelaskan bahwa konstipasi merupakan kondisi umum
   - Memberikan cara pencegahan dan penanganan yang tepat

Apabila konstipasi tidak membaik atau disertai keluhan lain seperti nyeri hebat atau perdarahan, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut oleh tenaga kesehatan (WHO, 2020).

**5. Edema**

a. Pengertian

Edema adalah kondisi penumpukan cairan berlebih di dalam jaringan tubuh yang ditandai dengan pembengkakan, terutama pada ekstremitas seperti kaki, pergelangan kaki, dan tangan. Pada kehamilan, edema merupakan keluhan yang sering terjadi, khususnya pada trimester kedua dan ketiga, dan umumnya bersifat fisiologis (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, 2018)

b. Penyebab

Edema pada kehamilan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Peningkatan volume plasma darah selama kehamilan
2) Retensi cairan akibat pengaruh hormone
3) Tekanan uterus yang membesar terhadap pembuluh darah vena, terutama vena cava inferior
4) Penurunan aliran balik vena dari ekstremitas bawah
5) Berdiri atau duduk terlalu lama (Lowdermilk et al., 2020; Prawirohardjo, 2016)

c. Patofisiologi

Selama kehamilan terjadi peningkatan volume darah hingga sekitar 30–50% untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Peningkatan ini menyebabkan

tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah meningkat, sehingga cairan lebih mudah keluar dari pembuluh darah ke jaringan interstisial.

Selain itu, hormon progesteron menyebabkan relaksasi dinding pembuluh darah, yang turut memperlambat aliran balik vena. Pembesaran uterus juga menekan vena besar di rongga abdomen, sehingga menghambat aliran darah dari bagian bawah tubuh kembali ke jantung. Kombinasi kondisi tersebut menyebabkan penumpukan cairan di jaringan, terutama pada ekstremitas bawah.

d. Asuhan / Tata Laksana Nonfarmakologis

Penatalaksanaan edema fisiologis pada kehamilan umumnya dilakukan secara nonfarmakologis, meliputi:

1) Istirahat dengan posisi yang tepat
   - Mengangkat kaki saat beristirahat
   - Tidur miring ke kiri untuk meningkatkan aliran darah
2) Menghindari berdiri atau duduk terlalu lama
   - Mengubah posisi secara berkala
   - Menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman
3) Menghindari pakaian ketat yang menghambat sirkulasi
   - Melakukan aktivitas fisik ringan
   - Jalan kaki atau senam hamil untuk melancarkan sirkulasi darah
4) Mengurangi konsumsi garam berlebihan
   - Untuk mencegah retensi cairan berlebih
5) Edukasi ibu hamil
   - Menjelaskan bahwa edema ringan adalah kondisi normal
   - Memberikan informasi tanda bahaya

Meskipun edema sering bersifat normal, tenaga kesehatan perlu waspada jika edema terjadi secara tiba-tiba, berat, atau disertai gejala lain seperti hipertensi, sakit kepala, dan gangguan penglihatan, karena dapat mengarah pada preeklamsia. Dalam kondisi tersebut, diperlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

**6. Heartburn (Nyeri Ulu Hati) (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020) (Prawirohardjo, 2016)**

a. Pengertian

Heartburn atau nyeri ulu hati adalah sensasi terbakar atau tidak nyaman di daerah dada bagian bawah atau ulu hati yang sering dirasakan oleh ibu hamil. Keluhan ini terjadi akibat refluks (aliran balik) asam lambung ke esofagus (kerongkongan).

b. Penyebab

Heartburn pada kehamilan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Relaksasi sfingter esofagus bawah akibat peningkatan hormon progesterone
2) Tekanan uterus yang membesar terhadap lambung
3) Perlambatan pengosongan lambung
4) Konsumsi makanan tertentu seperti makanan berlemak, pedas, atau asam

c. Patofisiologi

Selama kehamilan, hormon progesteron menyebabkan relaksasi otot polos, termasuk sfingter esofagus bawah yang berfungsi mencegah naiknya asam lambung. Ketika sfingter ini melemah, asam lambung lebih mudah naik ke esofagus sehingga menimbulkan sensasi terbakar.

Selain itu, pembesaran uterus meningkatkan tekanan intraabdomen yang mendorong isi lambung ke arah esofagus. Perlambatan pengosongan lambung juga memperpanjang waktu kontak asam dengan dinding lambung, sehingga meningkatkan risiko refluks. Kombinasi faktor hormonal dan mekanis inilah yang menyebabkan terjadinya heartburn pada ibu hamil.

d. Asuhan / Tata Laksana Nonfarmakologis

Penatalaksanaan heartburn pada kehamilan umumnya dilakukan secara nonfarmakologis, meliputi:

1) Modifikasi pola makan
   - Makan dalam porsi kecil tetapi sering
   - Menghindari makanan berlemak, pedas, dan asam
   - Tidak langsung berbaring setelah makan
2) Posisi tubuh
   - Duduk tegak setelah makan
   - Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi
   - Menghindari posisi membungkuk
3) Kebiasaan sehari-hari
   - Menghindari makan sebelum tidur
   - Menggunakan pakaian longgar
   - Menghindari konsumsi kafein
4) Manajemen berat badan dan aktivitas
   - Menjaga kenaikan berat badan sesuai anjuran
   - Melakukan aktivitas fisik ringan
5) Edukasi ibu hamil
   - Menjelaskan bahwa keluhan ini umum terjadi
   - Memberikan cara pencegahan dan pengendalian

Apabila keluhan tidak membaik atau disertai gejala berat seperti nyeri hebat, muntah berulang, atau gangguan menelan, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan kemungkinan terapi medis.

**7. Kram Kaki**

a. Pengertian

Kram kaki adalah kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba, tidak disengaja, dan menimbulkan rasa nyeri, biasanya pada otot betis. Pada kehamilan, kram kaki sering terjadi terutama pada malam hari dan dapat mengganggu kenyamanan serta kualitas tidur ibu hamil (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

b. Penyebab

Kram kaki pada kehamilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Perubahan sirkulasi darah akibat tekanan uterus pada pembuluh darah
2) Ketidakseimbangan elektrolit, seperti kalsium dan magnesium
3) Kelelahan otot akibat peningkatan berat badan
4) Penurunan aliran darah ke ekstremitas bawah
5) Kurangnya aktivitas fisik atau posisi tubuh yang tidak tepat (Prawirohardjo, 2016)

c. Patofisiologi

Selama kehamilan, pembesaran uterus dapat menekan pembuluh darah di daerah panggul sehingga menghambat aliran darah ke ekstremitas bawah. Hal ini menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke otot, sehingga otot menjadi lebih mudah mengalami kejang atau kram.

Selain itu, perubahan metabolisme mineral seperti kalsium dan magnesium dapat memengaruhi fungsi kontraksi otot. Ketidakseimbangan elektrolit ini menyebabkan peningkatan iritabilitas saraf dan otot, sehingga memicu terjadinya kontraksi otot yang tiba-tiba. Kondisi ini sering diperparah oleh kelelahan otot dan posisi tidur yang kurang tepat.(Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)(Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, 2018)

d. Asuhan / Tata Laksana Nonfarmakologis

Penatalaksanaan kram kaki pada kehamilan umumnya dilakukan secara nonfarmakologis, meliputi:

1) Peregangan otot (stretching)
   a) Melakukan peregangan otot betis sebelum tidur
   b) Meluruskan kaki dan menarik jari kaki ke arah tubuh saat kram terjadi
2) Aktivitas fisik ringan
   a) Jalan kaki secara teratur

b) Senam hamil untuk meningkatkan sirkulasi darah

3) Perbaikan posisi tubuh
   a) Menghindari berdiri atau duduk terlalu lama
   b) Mengatur posisi tidur yang nyaman
4) Pijatan dan kompres hangat
   a) Memijat area yang kram
   b) Menggunakan kompres hangat untuk relaksasi otot
5) Pemenuhan nutrisi
   a) Mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan magnesium
   b) Memastikan asupan cairan yang cukup
6) Edukasi ibu hamil
   a) Menjelaskan bahwa kram kaki merupakan kondisi umum
   b) Memberikan cara pencegahan dan penanganan mandiri

Apabila kram terjadi sangat sering, menetap, atau disertai pembeng(Gynecologists, 2018)kakan dan nyeri hebat pada satu kaki, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menyingkirkan kemungkinan gangguan lain seperti trombosis vena dalam.(Gynecologists, 2018)

## D. Penilaian Penyebab Keluhan Kehamilan(World Health Organization, 2020)

Penilaian terhadap keluhan kehamilan merupakan langkah penting dalam pelayanan antenatal care (ANC) untuk membedakan antara keluhan fisiologis (normal) dan kondisi patologis yang memerlukan penanganan medis. Penilaian yang tepat akan membantu tenaga kesehatan dalam menentukan tindakan yang sesuai serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dan janin.

### 1. Anamnesis

Anamnesis merupakan tahap awal dalam pengkajian yang dilakukan melalui wawancara dengan ibu hamil. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi lengkap mengenai keluhan yang dialami.

Hal-hal yang perlu dikaji dalam anamnesis meliputi:

a. Riwayat keluhan: mencakup jenis keluhan, frekuensi, durasi, tingkat keparahan (intensitas), serta faktor yang memperberat atau mengurangi keluhan
b. Usia kehamilan: penting untuk mengetahui apakah keluhan sesuai dengan trimester kehamilan
c. Pola makan dan aktivitas: untuk menilai kemungkinan faktor pencetus seperti kurang nutrisi atau kelelahan
d. Riwayat kesehatan: termasuk riwayat penyakit sebelumnya, riwayat kehamilan terdahulu, serta penggunaan obat atau suplemen

Anamnesis yang baik membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi penyebab keluhan serta menentukan apakah kondisi tersebut masih dalam batas normal(Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

**2. Pemeriksaan Fisik**

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk melengkapi data hasil anamnesis dan menilai kondisi umum ibu hamil. Pemeriksaan ini meliputi:

a. Tanda vital

Meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi adanya gangguan seperti hipertensi atau infeksi.

b. Pemeriksaan abdomen

Dilakukan untuk menilai pembesaran uterus, posisi janin, serta adanya nyeri tekan yang tidak normal.

c. Evaluasi edema

Mengamati adanya pembengkakan pada ekstremitas, lokasi edema, serta derajatnya. Edema ringan dapat bersifat normal, tetapi perlu diwaspadai jika terjadi secara berlebihan atau disertai gejala lain.

Pemeriksaan fisik membantu memastikan apakah keluhan yang dialami masih fisiologis atau mengarah pada kondisi patologis (Sulistyawati, 2013)

**3. Identifikasi Tanda Bahaya**

Identifikasi tanda bahaya merupakan bagian penting dalam penilaian keluhan kehamilan. Tanda bahaya adalah gejala yang menunjukkan adanya kemungkinan komplikasi serius yang memerlukan penanganan segera.

Beberapa tanda bahaya yang perlu diwaspadai antara lain:

a. Muntah berlebihan yang dapat menyebabkan dehidrasi (hiperemesis gravidarum)
b. Nyeri hebat yang tidak normal, terutama pada perut atau kepala
c. Perdarahan dari jalan lahir
d. Edema disertai hipertensi, yang dapat mengarah pada preeklamsia

Selain itu, tanda lain seperti penurunan kesadaran, demam tinggi, atau gerakan janin berkurang juga perlu diperhatikan.

Apabila ditemukan salah satu atau lebih tanda bahaya tersebut, ibu hamil harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Deteksi dini dan rujukan tepat waktu sangat penting untuk mencegah komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan janin(Gynecologists, 2018)

## E. Tata Laksana Nonfarmakologis

Tata laksana nonfarmakologis merupakan upaya penanganan keluhan kehamilan tanpa menggunakan obat-obatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang dialami ibu hamil dengan cara yang aman, sederhana, dan minim efek samping, sehingga tidak membahayakan ibu maupun janin. Oleh karena itu, tata laksana nonfarmakologis menjadi pilihan utama dalam mengatasi keluhan ringan hingga sedang selama kehamilan (World Health Organization, 2020)

Pendekatan ini berfokus pada perubahan perilaku, pola hidup sehat, serta pemanfaatan metode alami yang dapat dilakukan secara mandiri oleh ibu hamil dengan bimbingan tenaga kesehatan. Selain membantu mengurangi keluhan, metode ini juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis ibu.

### 1. Prinsip Penatalaksanaan

a. Aman Bagi Ibu Dan Janin

Setiap intervensi yang dilakukan harus mempertimbangkan keamanan ibu dan janin. Pendekatan nonfarmakologis dipilih karena tidak melibatkan zat kimia atau obat yang berpotensi menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, metode seperti modifikasi pola makan, aktivitas fisik ringan, dan teknik relaksasi lebih dianjurkan sebagai penanganan awal.

b. Berbasis Edukasi

Edukasi merupakan komponen utama dalam tata laksana nonfarmakologis. Ibu hamil perlu diberikan informasi yang jelas mengenai penyebab keluhan, cara mengatasi, serta langkah pencegahan. Dengan pemahaman yang baik, ibu dapat melakukan perawatan mandiri secara tepat dan meningkatkan kepatuhan terhadap anjuran kesehatan.

c. Mengutamakan Perubahan Gaya Hidup

Penatalaksanaan difokuskan pada perbaikan gaya hidup, seperti:

1) Pola makan sehat dan seimbang
2) Aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kehamilan
3) Istirahat yang cukup
4) Postur tubuh yang benar

Perubahan gaya hidup ini tidak hanya membantu mengurangi keluhan, tetapi juga mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin secara optimal (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

d. Bersifat Preventif Dan Promotif

Pendekatan nonfarmakologis tidak hanya bertujuan mengatasi keluhan, tetapi juga mencegah timbulnya keluhan yang lebih berat serta meningkatkan

kesehatan ibu secara keseluruhan. Upaya promotif dilakukan melalui edukasi dan konseling, sedangkan upaya preventif dilakukan dengan mendorong perilaku hidup sehat sejak awal kehamilan.

Secara keseluruhan, tata laksana nonfarmakologis merupakan pendekatan yang efektif, aman, dan mudah diterapkan dalam praktik kebidanan. Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan edukasi, membimbing ibu, serta memantau perkembangan kondisi ibu hamil secara berkelanjutan.

## F. Bentuk Tata Laksana Nonfarmakologis (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

Tata laksana nonfarmakologis pada kehamilan dilakukan melalui berbagai pendekatan yang berfokus pada perubahan gaya hidup, peningkatan kenyamanan, serta pencegahan keluhan yang lebih berat. Pendekatan ini mudah diterapkan, aman, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh ibu hamil dengan bimbingan tenaga kesehatan.

### 1. Modifikasi Pola Makan

Modifikasi pola makan merupakan salah satu cara utama dalam mengatasi berbagai keluhan kehamilan, terutama yang berkaitan dengan sistem pencernaan seperti mual, muntah, konstipasi, dan heartburn.

Beberapa prinsip yang dianjurkan antara lain:

a. Makan dalam porsi kecil tetapi sering untuk mengurangi beban kerja lambung dan mencegah mual
b. Menghindari makanan berlemak, pedas, dan berbau tajam yang dapat memicu keluhan
c. Mengonsumsi makanan tinggi serat, seperti sayur, buah, dan biji-bijian untuk mencegah konstipasi
d. Memastikan asupan cairan yang cukup untuk menjaga hidrasi

Pola makan yang baik tidak hanya membantu mengurangi keluhan, tetapi juga mendukung kebutuhan nutrisi ibu dan janin

### 2. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik ringan sangat dianjurkan selama kehamilan karena memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ibu. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain:

a. Senam hamil, yang dirancang khusus untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh
b. Jalan kaki ringan, untuk melancarkan sirkulasi darah
c. Peregangan otot, untuk mengurangi ketegangan otot

Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi keluhan seperti nyeri punggung, konstipasi, dan kram kaki, serta meningkatkan kebugaran dan kualitas tidur ibu hamil (Cunningham et al., 2018).

**3. Posisi Tubuh dan Istirahat**

Pengaturan posisi tubuh dan istirahat yang tepat sangat penting untuk mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan. Beberapa anjuran yang dapat diberikan antara lain:

Tidur miring ke kiri, untuk meningkatkan aliran darah ke plasenta dan janin

Menghindari berdiri atau duduk terlalu lama, karena dapat menyebabkan kelelahan dan edema

Menggunakan bantal penyangga, terutama pada punggung dan perut untuk meningkatkan kenyamanan saat istirahat

Posisi tubuh yang baik juga dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan meningkatkan kualitas istirahat (Prawirohardjo, 2016)

**4. Teknik Relaksasi**

Teknik relaksasi bertujuan untuk mengurangi stres, kecemasan, dan ketegangan fisik yang sering dialami selama kehamilan. Beberapa metode yang dapat dilakukan antara lain:

a. Latihan pernapasan, untuk membantu relaksasi dan meningkatkan oksigenasi
b. Yoga prenatal, yang menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan, dan relaksasi
c. Meditasi, untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres

Teknik relaksasi terbukti efektif dalam meningkatkan kenyamanan serta kesejahteraan psikologis ibu hamil(World Health Organization, 2020)

**5. Edukasi dan Konseling**

Edukasi dan konseling merupakan bagian penting dalam tata laksana nonfarmakologis. Peran tenaga kesehatan sangat diperlukan dalam memberikan informasi dan dukungan kepada ibu hamil.

Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

a. Memberikan informasi tentang keluhan normal selama kehamilan agar ibu tidak merasa cemas
b. Mengajarkan cara mengatasi keluhan secara mandiri
c. Memberikan dukungan psikologis, termasuk melibatkan keluarga dalam perawatan ibu hamil

Edukasi yang baik dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu dalam menjaga kesehatannya selama kehamilan serta mencegah terjadinya komplikasi (Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

## G. Peran Tenaga Kesehatan(World Health Organization, 2020)

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan selama kehamilan. Peran ini tidak hanya berfokus pada penanganan keluhan, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk menjaga kesehatan ibu dan janin secara optimal.

Beberapa peran utama tenaga kesehatan antara lain:

1. **Deteksi dini keluhan dan komplikasi**

   Tenaga kesehatan bertugas melakukan pengkajian secara menyeluruh melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemantauan rutin selama antenatal care (ANC). Deteksi dini sangat penting untuk membedakan keluhan fisiologis dan patologis serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Dengan penilaian yang tepat, tenaga kesehatan dapat segera menentukan apakah ibu memerlukan penanganan lanjutan atau rujukan.

2. **Edukasi ibu hamil**

   Edukasi merupakan bagian penting dalam asuhan kebidanan. Tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami mengenai perubahan yang terjadi selama kehamilan, keluhan yang normal, serta cara mengatasinya. Edukasi juga mencakup pola hidup sehat, nutrisi, aktivitas fisik, serta tanda bahaya kehamilan. Dengan edukasi yang baik, ibu hamil akan lebih siap dan mampu melakukan perawatan mandiri(Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, 2020)

3. **Pendampingan selama kehamilan**

   Tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping yang memberikan dukungan secara berkelanjutan kepada ibu hamil. Pendampingan ini meliputi pemantauan kondisi kesehatan, memberikan motivasi, serta membantu ibu dalam menghadapi ketidaknyamanan fisik dan perubahan psikologis selama kehamilan. Hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan ibu hamil dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap anjuran kesehatan.

4. **Promosi kesehatan**

   Tenaga kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan. Promosi kesehatan dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan pemberdayaan keluarga agar ikut berperan dalam mendukung kesehatan ibu. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kehamilan yang sehat dan aman(Prawirohardjo, 2016)

5. **Pendekatan Holistik dalam Asuhan Kehamilan**

   Dalam memberikan pelayanan, tenaga kesehatan perlu menerapkan pendekatan holistik, yaitu memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan

budaya ibu hamil. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kondisi medis, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan emosional, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial ibu.

Pendekatan holistik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu secara menyeluruh serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal. Dengan demikian, asuhan yang diberikan menjadi lebih komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan ibu (woman centered care).

## H. Metode Dokumentasi (SOAP) pada Keluhan Umum Kehamilan

Dokumentasi SOAP digunakan untuk mencatat secara sistematis hasil penilaian keluhan ibu hamil serta tindakan yang diberikan. Pada topik keluhan umum kehamilan, SOAP sangat penting untuk membantu tenaga kesehatan dalam membedakan kondisi fisiologis dan patologis serta menentukan tata laksana nonfarmakologis yang tepat.

**1. S (Subjective) – Data Subjektif**

Bagian ini berisi keluhan yang dirasakan langsung oleh ibu hamil dan diperoleh melalui anamnesis.

Dalam konteks keluhan kehamilan, data yang perlu digali meliputi:

a. Jenis keluhan (misalnya mual, nyeri punggung, konstipasi, sering BAK)
b. Waktu munculnya keluhan (trimester ke berapa)
c. Frekuensi dan intensitas keluhan
d. Faktor pencetus dan pereda
e. Dampak terhadap aktivitas sehari-hari
f. Pola makan, istirahat, dan aktivitas

Data subjektif sangat penting untuk menilai penyebab keluhan dan menentukan apakah keluhan masih dalam batas normal.

**2. O (Objective) – Data Objektif**

Berisi hasil pemeriksaan fisik dan observasi tenaga kesehatan.

Pada keluhan umum kehamilan, pemeriksaan meliputi:

a. Tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu)
b. Status hidrasi (terutama pada mual muntah)
c. Pemeriksaan abdomen
d. Evaluasi edema (lokasi, derajat)
e. Kondisi umum ibu

Data objektif digunakan untuk mengkonfirmasi kondisi klinis dan mendeteksi adanya tanda bahaya.

**3. A (Assessment) – Penilaian**

Merupakan interpretasi dari data subjektif dan objektif.

Dalam topik ini, assessment berfokus pada:

a. Menentukan apakah keluhan fisiologis (normal) atau patologis
b. Mengidentifikasi penyebab keluhan (misalnya hormonal, mekanik, atau gaya hidup)
c. Menilai ada tidaknya red flags (tanda bahaya)
d. Menetapkan diagnosis atau masalah kebidanan

Tahap ini merupakan inti dari clinical reasoning dalam kebidanan.

Contoh: Ny E Umur 28 tahun G1P0A0 20 minggu janin hidup tunggal dengan Hyperemesis gravidarum

**4. P (Penatalaksanaan)**

Berisi tindakan yang diberikan berdasarkan hasil assessment. Pada keluhan umum kehamilan, penatalaksanaan difokuskan pada pendekatan nonfarmakologis, meliputi:

a. Modifikasi pola makan (misalnya makan sedikit tapi sering untuk mual)
b. Aktivitas fisik ringan (senam hamil, peregangan untuk nyeri punggung)
c. Pengaturan istirahat dan posisi tubuh
d. Teknik relaksasi (napas, yoga)
e. Edukasi dan konseling
f. Pemantauan dan kontrol ulang
g. Rujukan jika ditemukan tanda bahaya

Penatalaksanaan harus aman, berbasis edukasi, dan sesuai kondisi ibu.

## I. Aktivitas 1 — Knows How

**Mini-case tertulis (diskusi kelompok)**

Petunjuk Diskusi

- Diskusi dilakukan dalam kelompok (3–5 orang)
- Gunakan pendekatan klinis berbasis evidence
- Tuliskan hasil diskusi secara sistematis

**Skenario Kasus**

Seorang ibu hamil usia 24 tahun, G1P0A0, dengan usia kehamilan 10 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan muntah sejak 2 minggu terakhir. Ibu mengatakan muntah terjadi sekitar 3–4 kali sehari, terutama pada pagi hari. Nafsu makan menurun, namun ibu masih mampu makan dan minum. Ibu tidak mengeluhkan demam, tidak mengalami penurunan berat badan yang signifikan, dan masih dapat melakukan aktivitas ringan sehari-hari di rumah. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, dan suhu tubuh

36,7°C. Tidak ditemukan tanda-tanda dehidrasi, dan kondisi umum ibu dalam keadaan baik.

Diskusikan kasus di atas dan jawab pertanyaan berikut:

**Identifikasi Masalah**

1. Apa keluhan utama pada kasus ini?
2. Apakah kondisi ini termasuk fisiologis atau patologis? Jelaskan alasan Anda

**Analisis Penyebab**

1. Jelaskan penyebab keluhan berdasarkan perubahan fisiologis kehamilan
2. Faktor apa yang memicu keluhan pada kasus ini?

**Penilaian Klinis (Assessment)**

1. Data apa saja yang perlu digali lebih lanjut melalui anamnesis?
2. Apakah terdapat tanda bahaya pada kasus ini? Jelaskan

**Tata Laksana Nonfarmakologis**

1. Sebutkan minimal 3 intervensi nonfarmakologis yang dapat diberikan
2. Jelaskan rasional dari masing-masing intervensi

**Konseling**

1. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu?
2. Kapan ibu harus kembali atau dirujuk?

## J. Aktivitas 2 — Shows How

**Simulasi/skill lab**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | No. Stasiun | 5 |
| 2. | Judul | Pilih judul dengan menebalkan satu kategori berikut:<br>Masa antara/prakonsepsi: normal/deteksi dini<br>Kehamilan: Normal/Deteksi Dini/Gadar<br>Persalinan: Normal/Deteksi Dini/Gadar<br>Nifas/Buteki: Normal/Deteksi Dini<br>Bayi barul ahir, bayi dan balita: Normal/Deteksi Dini/Gadar<br>Keluarga Berencana: Normal/Deteksi dini |
| 3. | Kasus | Nyeri pinggang fisiologis pada kehamilan trimester III |
| 4. | Tujuan | Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dengan menebalkan beberapa kompetensi berikut:<br>Anamnesis<br>Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana<br>Perumusan diagnosis dan/atau masalah<br>Prosedur tindakan klinis<br>KIE/konseling<br>Kolaborasi/Rujukan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Pendokumentasian<br>Perilaku profesional |
| 5. | Soal:<br>Skenario dan tugas peserta ujian | SKENARIO<br>Seorang perempuan usia 28 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri pada bagian pinggang. Ibu merasa khawatir karena keluhan semakin sering dirasakan.. Hasil pemeriksaan fisik: keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 x/menit, suhu 36,5°C. Tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan dan denyut jantung janin 140 x/menit.<br><br>TUGAS<br>Lakukan anamnesis terarah sesuai dengan kasus yang diberikan.<br>Sampaikan diagnosis atau masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh.<br>Lakukan penatalaksanaan edukasi dan konseling (KIE) yang sesuai dengan kasus tersebut ! |
| 6. | Instruksi penguji | INSTRUKSI UMUM<br>Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.<br>Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:<br>Ujian lokal<br>2-digit jika peserta berjumlah 01-99<br>3-digit jika perserta berjumlah 100-999<br>4-digit terakhir jika menggunakan NIM peserta<br>Ujian nasional<br>4-digit jika peserta berjumlah ribuan<br>Atau 4-digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka.<br>Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian:<br>Actual mark (0/1/2/3)<br>Global rating (1/2/3/4)<br>Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apapun (interupsi, bertanya, menghentikan, dst) kepada peserta selain yang ditentukan.<br>Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE<br><br>INSTRUKSI KHUSUS<br>Penguji melakukan pengamatan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Jika peserta melakukan anamnesis, PS menjawab sebagai berikut:<br>Keluhan utama :"Pinggang saya sakit, Bu."<br>Sejak kapan: "Sekitar satu minggu ini."<br>Karakter nyeri: "Seperti pegal, tidak menjalar."<br>Pencetus: "Kalau berdiri lama atau capek."<br>Pereda: "Kalau istirahat agak mendingan."<br>Gerakan janin : "masih aktif dirasakan"<br>Gejala penyerta (jika ditanya) Demam → "Tidak ada."Nyeri saat BAK → "Tidak." Perdarahan → "Tidak ada."<br>Riwayat penyakit: "Tidak ada."<br>Kekhawatiran pasien:"Saya takut ini berbahaya untuk bayi saya, Bu."<br>Diagnosis yang disampaikan peserta : G2P1A0, hamil 36 minggu janin tunggal hidup dengan keadaan baik<br>Masalah : Nyeri pinggang fisiologis pada kehamilan trimester III<br>Menyimak uraian edukasi dan konseling (KIE),focus kan pada :<br>Edukasi postur tubuh<br>Hindari berdiri terlalu lama<br>Gunakan posisi tubuh yang benar saat duduk/berdiri<br>Istirahat yang cukup<br>Anjurkan tidur miring kiri<br>Hindari aktivitas berat<br>Kompres hangat<br>Pada area pinggang untuk mengurangi nyeri<br>Latihan ringan / senam hamil<br>Peregangan otot punggung<br>Meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi nyeri<br>Penggunaan alas kaki yang nyaman<br>Hindari sepatu hak tinggi<br>KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)<br>Menjelaskan kondisi normal pada trimester III<br>Menenangkan ibu<br>Menjelaskan tanda bahaya:<br>Nyeri hebat menetap<br>Nyeri menjalar<br>Disertai kontraksi<br>Perdarahan<br>Demam<br>INSTRUKSI TAMBAHAN |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap untuk digunakan oleh peserta ujian berikutnya.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Kebutuhan dan instruksi PS</td><td>Ada<br>Instruksi Pasien :<br>Tampak sedikit tidak nyaman saat duduk atau berdiri<br>Sesekali memegang pinggang<br>Ekspresi khawatir ringan<br>Kooperatif saat diwawancarai</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Dialog PS</td><td>Ada/Tidak ada<br>Keluhan utama :“Pinggang saya sakit, Bu.”<br>Sejak kapan: “Sekitar satu minggu ini.”<br>Karakter nyeri: “Seperti pegal, tidak menjalar.”<br>Pencetus: “Kalau berdiri lama atau capek.”<br>Pereda: “Kalau istirahat agak mendingan.”<br>Gerakan janin : “masih aktif dirasakan”<br>Gejala penyerta (jika ditanya) Demam → “Tidak ada.”Nyeri saat BAK → “Tidak.” Perdarahan → “Tidak ada.”<br>Riwayat penyakit: “Tidak ada.”<br>Kekhawatiran pasien:“Saya takut ini berbahaya untuk bayi saya, Bu.”<br>Gejala Penyerta (Hanya jika ditanya)<br>Demam : “Tidak ada.”<br>Nyeri saat BAK : “Tidak.”<br>Perdarahan :“Tidak ada.”<br>Respons Jika Diberikan Penjelasan/KIE :<br>PS tampak lebih tenang<br>PS berkata: “Oh begitu ya, Bu. Saya jadi lebih tenang.”<br>Jangan memberikan informasi tambahan di luar skenario<br>Respons harus konsisten antar peserta</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Kebutuhan manikin</td><td>Tidak Ada</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Kebutuhan laboran</td><td>Tidak Ada</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Kebutuhan alat</td><td>
<table>
<tr><td>No.</td><td>Alat dan Bahan</td><td>Jumlah<br>(sesuai jumlah peserta dalam satu putaran + 20% cadangan)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Meja dan kursi untuk peserta, penguji dan pasien</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Tempat tidur/periksa | 1 |
| | | 3 | Handrub | 1 |
| | | 4 | Tisu | 1 |
| | | 5 | Lembar soal | 1 |
| | | 6 | Pen | 1 |
| | | 7 | Kertas kosong | 1 |
| 12 | Penulis | Nurulicha, SST.,M.Keb | | |
| 13 | Referensi | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/320/2020). Kementerian Kesehatan RI. | | |

**RUBRIK PENILAIAN OSCE**

Kompetensi 1 :Anamnesis

| No | Komponen yang Dinilai | Bobot | Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | Membuka komunikasi (salam, perkenalan, persetujuan) | | |
| 2 | Menggali keluhan utama | | |
| 3 | Menggali karakter nyeri (lokasi, durasi, pencetus, pereda) | | |
| 4 | Menggali gejala penyerta (demam, BAK, perdarahan, kontraksi) | | |
| 5 | Menggali gerakan janin | | |
| 6 | Menggali kekhawatiran pasien | | |

**Skoring KOMPETENSI 1**

- **3** = Jika peserta melakukan **6 langkah anamnesis dengan benar dan sistematis**
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 langkah dengan benar**
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 langkah dengan benar**
- **0** = Jika peserta **tidak melakukan anamnesis**

**Kompetensi 2:** Diagnosis / Masalah

| No | Komponen | Bobot | Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketepatan diagnosis | | |
| 2 | Kejelasan penjelasan diagnosis | | |

**Skoring KOMPETENSI 2**

· **3** = Jika peserta **menyampaikan diagnosis dan masalah secara tepat dan lengkap**

· **2** = Jika peserta **diagnosis hampir tepat tetapi kurang lengkap**

· **1** = Jika peserta **diagnosis kurang tepat / hanya sebagian benar**

· **0** = Jika peserta **tidak dapat menyampaikan diagnosis**

Kompetensi 3: **Penatalaksanaan & KIE**

| No | Komponen | Bobot | Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | Menjelaskan kondisi (normal/fisiologis) | | |
| 2 | Edukasi postur & aktivitas | | |
| 3 | Anjuran istirahat & posisi tidur | | |
| 4 | Anjuran kompres/senam | | |
| 5 | Menyampaikan tanda bahaya | | |
| 6 | Komunikasi (empati, bahasa sederhana) | | |

**Skoring KOMPETENSI 3**

· **3** = Jika peserta melakukan **≥5–6 langkah penatalaksanaan dan KIE dengan benar**

· **2** = Jika peserta melakukan **3–4 langkah dengan benar**

· **1** = Jika peserta melakukan **1–2 langkah dengan benar**

· **0** = Jika peserta **tidak melakukan penatalaksanaan/KIE**

**Profesionalisme (Global)**

| No | Komponen | Bobot | Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan secara sistematis | | |
| 2 | Menjaga privasi dan keselamatan pasien | | |
| 3 | Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama nyeri | | |
| 4 | Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif | | |
| 5 | Percaya diri dan tidak ragu-ragu | | |

**Skoring KOMPETENSI 4**

· **3** = Jika peserta menunjukkan **≥4–5 aspek profesionalisme dengan baik**

· **2** = Jika peserta menunjukkan **2–3 aspek**

· **1** = Jika peserta menunjukkan **1 aspek**

· **0** = Jika peserta **tidak menunjukkan sikap professional**

**TOTAL SKOR DAN KELULUSAN**

**TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3**

*(dicatat di rubrik penilaian)*

**IV. Global Performance**

**Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian**

| TIDAK LULUS | BORDERLINE | LULUS | SUPERIOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), .....

.....

Penguji :.....

**RUBRIK PENILAIAN OSCE**

**Station 5 : Nyeri Pinggang Fisiologis Pada Kehamilan Trimester III**

| KOMPETENSI | SKOR (S) | | | | BOBOT (B) | NILAI (S X B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | | |
| Anamnesis | Jika peserta tidak melakukan anamnesis | Jika peserta melakukan 1–3 langkah dengan benar | Jika peserta melakukan 4–5 langkah dengan benar | Jika Peserta ujian melakukan 6 langkah anamnesis dengan benar dan sistematis :<br>Membuka komunikasi (salam, perkenalan, persetujuan)<br>Menggali keluhan utama<br>Menggali karakter nyeri (lokasi, durasi, pencetus, pereda)<br>Menggali gejala penyerta (demam, BAK, | 3 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | perdaraha n, kontraksi)<br>Menggali gerakan janin<br>Menggali kekhawatir an pasien | | |
| Perumu san diagnosi s dan/ata u masalah | Jika peserta tidak dapat menyamp aikan diagnosis | Jika peserta diagno sis kurang tepat / hanya sebagi an benar | Jika peserta diagnosi s hampir tepat tetapi kurang lengkap | Jika peserta menyampa ikan diagnosis dan masalah secara tepat dan lengkap:<br>Diagnosis: G2P1A0, hamil 36 minggu janin tunggal hidup dengan keadaan baik<br>Masalah : Nyeri pinggang fisiologis pada kehamilan trimester III | 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIE/Konseling | Jika peserta tidak melakukan penatalaksanaan/KIE | Jika peserta melakukan 1–2 langkah dengan benar | Jika peserta melakukan 3–4 langkah dengan benar | Jika peserta melakukan ≥5–6 langkah penatalaksanaan dan KIE dengan benar:<br>Menjelaskan kondisi (normal/fisiologis)<br>Edukasi postur & aktivitas<br>Anjuran istirahat & posisi tidur<br>Anjuran kompres/senam<br>Menyampaikan tanda bahaya<br>Komunikasi (empati, bahasa sederhana) | 3 | |
| Perilaku profesional | Jika peserta tidak menunjukkan sikap professional | Jika peserta menunjukkan 1 aspek | Jika peserta menunjukkan 2–3 aspek | Jika peserta menunjukkan ≥4–5 aspek profesionalisme | 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dengan baik<br>Melaksanakan secara sistematis<br>Menjaga privasi dan keselamatan pasien<br>Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri<br>Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif<br>Percaya diri dan tidak ragu-ragu | | |

**TOTAL SKOR DAN KELULUSAN**

AM = Skor x Bobot (skor = 0/1/2/3, Bobot total 10)

Jumlah Total Skore = nilai kompetensi 1 + nilai kompetensi 2 + nilai kompetensi 3 + nilai kompetensi 4

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 = \ldots\ldots\ldots$$

(Kota), .....

.....

Penguji :.....

**Global performance**

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

| TIDAK LULUS 1 | BORDERLINE 2 | LULUS 3 | SUPERIOR 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DOPS (Does)**

**DOPS di Lahan Praktik**

| Komponen | Deskripsi | Menetapkan Tindak Lanjut Awal Dan Kebutuhan Rujukan Pada Keluhan Umum Kehamilan |
|---|---|---|
| Metode penilaian | DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap kemampuan klinis mahasiswa, dengan fokus pada keselamatan pasien, penentuan prioritas masalah, dan pengambilan keputusan klinis. | Pembimbing mengamati bagaimana mahasiswa menilai keluhan ibu hamil, mendeteksi tanda bahaya, menentukan tingkat urgensi, serta menetapkan tindakan awal dan keputusan rujukan secara tepat. |
| Tujuan penilaian | Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi tanda bahaya, menentukan tingkat urgensi kasus, serta | Mahasiswa diharapkan mampu membedakan kondisi fisiologis dan patologis, mengenali tanda bahaya sejak dini, serta mengambil |

| | | |
|---|---|---|
| | merencanakan tindakan awal, tindak lanjut, dan rujukan sesuai prioritas masalah. | keputusan klinis yang tepat dan aman. |
| Kasus klinik | Kasus berbasis situasi klinis nyata dengan kemungkinan adanya atau tidak adanya tanda bahaya. | Seorang perempuan 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu, datang dengan keluhan mual muntah sejak 1 minggu. Muntah 8–10 kali per hari, tidak mampu makan, tampak lemas, mukosa kering, dan penurunan berat badan 2 kg. |
| Aktivitas mahasiswa yang diamati | Mahasiswa melakukan penilaian klinis menyeluruh dan mengambil keputusan berbasis prioritas. | Mahasiswa melakukan anamnesis terarah (frekuensi muntah, asupan, tanda dehidrasi), mengidentifikasi tanda bahaya, menyimpulkan kondisi patologis, menentukan urgensi tinggi, menjelaskan kondisi kepada pasien, dan merencanakan rujukan segera. |
| Aspek yang dinilai | 1. Deteksi tanda bahaya/komplikasi 2. Penentuan tingkat urgensi 3. Ketepatan rencana tindakan awal 4. Ketepatan rujukan dan tindak lanjut | Pembimbing menilai apakah mahasiswa mengenali dehidrasi dan penurunan BB sebagai tanda bahaya, menetapkan kondisi sebagai hiperemesis gravidarum, dan memutuskan rujukan sebagai prioritas utama. |
| Fokus observasi pembimbing | Ketepatan clinical reasoning dalam menentukan prioritas masalah dan keselamatan pasien. | Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa: - Tidak menganggap kasus sebagai fisiologis - Cepat mengenali kondisi gawat - Tidak menunda rujukan - Menghindari tindakan yang tidak sesuai |
| Umpan balik | Umpan balik diberikan segera, berfokus pada kemampuan deteksi tanda bahaya dan pengambilan keputusan. | Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah mampu mengenali tanda bahaya, namun perlu meningkatkan kecepatan dalam menentukan |

| | | |
|---|---|---|
| | | urgensi atau memperjelas edukasi kepada pasien. |
| Keputusan penilaian | Berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menentukan prioritas klinis dan keselamatan pasien. | Kompeten: tepat deteksi + tepat rujukan Perlu supervisi: deteksi benar, keputusan belum tegas Remedial: gagal mengenali tanda bahaya atau salah keputusan |
| Makna dalam OBE | Menunjukkan pencapaian kompetensi pada level “does”, khususnya dalam clinical reasoning dan patient safety. | Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengambil keputusan klinis berbasis prioritas secara nyata dalam praktik. |

| Komponen | Deskripsi | Menetapkan Tindak Lanjut Awal Dan Kebutuhan Rujukan Pada Keluhan Umum Kehamilan |
|---|---|---|
| Metode penilaian | DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinis mahasiswa dengan penekanan pada clinical reasoning (proses berpikir klinis) dan patient safety (keselamatan pasien). Penilai mengamati bagaimana mahasiswa mengumpulkan data, menginterpretasi, dan mengambil keputusan yang aman. | Pembimbing mengamati bagaimana mahasiswa mengidentifikasi keluhan, menilai risiko, menentukan prioritas masalah, serta mengambil keputusan yang aman dan tepat terkait tindakan awal dan rujukan. |
| Tujuan penilaian | Menilai kemampuan mahasiswa dalam:<br>Melakukan clinical reasoning secara sistematis,<br>Mendeteksi tanda bahaya,<br>Menentukan tingkat urgensi, dan<br>Menjamin keselamatan pasien melalui keputusan yang tepat. | Mahasiswa diharapkan mampu membedakan kondisi normal dan berisiko, serta mengambil keputusan yang mencegah keterlambatan penanganan atau rujukan. |

| | | |
|---|---|---|
| Kasus klinik | Kasus dirancang untuk menuntut analisis klinis dan keputusan berbasis risiko. | Seorang perempuan 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 10 minggu, datang dengan keluhan mual muntah sejak 1 minggu. Muntah 8–10 kali/hari, tidak bisa makan, tampak lemas, mukosa kering, dan penurunan berat badan 2 kg. |
| Aktivitas mahasiswa yang diamati | Mahasiswa melakukan proses berpikir klinis mulai dari pengumpulan data hingga pengambilan keputusan berbasis keselamatan pasien. | Mahasiswa menggali frekuensi muntah, tanda dehidrasi, dan asupan nutrisi, mengidentifikasi tanda bahaya, menyimpulkan kondisi sebagai hiperemesis gravidarum, menentukan urgensi tinggi, serta merencanakan rujukan segera. |
| Aspek yang dinilai | Clinical reasoning: kemampuan menginterpretasi data dan menentukan diagnosis/masalah<br>Deteksi tanda bahaya<br>Penentuan tingkat urgensi<br>Patient safety: ketepatan tindakan awal dan keputusan rujukan | Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan gejala dengan risiko dehidrasi, mengenali kondisi gawat, dan tidak menunda rujukan yang dapat membahayakan pasien. |
| Fokus observasi pembimbing | Fokus pada kualitas proses berpikir dan dampaknya terhadap keselamatan pasien. | Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa:<br>Berpikir sistematis (data → interpretasi → keputusan)<br>Menghindari underdiagnosis/overdiagnosis<br>Mengambil keputusan yang aman<br>Tidak melakukan tindakan yang berisiko |
| Umpan balik | Umpan balik menekankan pada perbaikan clinical reasoning dan peningkatan kesadaran patient safety. | Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah mampu mengenali tanda bahaya, tetapi perlu meningkatkan kecepatan dalam menentukan urgensi atau |

| | | |
|---|---|---|
| | | memperjelas alasan rujukan kepada pasien. |
| Keputusan penilaian | Berdasarkan ketepatan clinical reasoning dan keamanan keputusan klinis. | Kompeten: reasoning tepat dan keputusan aman Perlu supervisi: reasoning cukup, keputusan kurang tegas Remedial: gagal mengenali risiko atau membahayakan pasien |
| Makna dalam OBE | DOPS mengukur capaian pembelajaran pada level "does" dengan menilai performa nyata berbasis clinical reasoning dan patient safety. | Mahasiswa menunjukkan kemampuan tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengambil keputusan klinis yang aman, tepat, dan bertanggung jawab dalam praktik nyata. |

**Rubrik Penilaian DOPS Per Aspek (Skala 1–5)**

**Anamnesis Terarah**

| Skor | Deskripsi |
|---|---|
| 5 | Menggali lengkap, sistematis, termasuk tanda bahaya |
| 4 | Hampir lengkap, ada sedikit yang terlewat |
| 3 | Data dasar didapat, tapi tidak sistematis |
| 2 | Banyak data penting tidak tergali |
| 1 | Tidak mampu menggali informasi relevan |

**Clinical Reasoning (Analisis & Diagnosis)**

| Skor | Deskripsi |
|---|---|
| 5 | Analisis sangat tepat, mampu membedakan fisiologis vs patologis dengan jelas |
| 4 | Analisis tepat, minor keraguan |
| 3 | Analisis cukup, masih perlu bantuan |
| 2 | Analisis kurang tepat |
| 1 | Salah interpretasi / tidak mampu menarik kesimpul |

**Deteksi Tanda Bahaya**

| Skor | Deskripsi |
|---|---|
| 5 | Mengidentifikasi semua tanda bahaya dengan cepat dan tepat |
| 4 | Mengidentifikasi sebagian besar tanda bahaya |
| 3 | Mengidentifikasi sebagian, tapi terlambat/ragu |

| | |
|---|---|
| 2 | Melewatkan tanda bahaya penting |
| 1 | Tidak mengenali tanda bahaya sama sekali |

**Penentuan Tingkat Urgensi**

| Skor | Deskripsi |
|---|---|
| 5 | Menentukan urgensi dengan sangat tepat dan cepat |
| 4 | Tepat, sedikit lambat |
| 3 | Cukup tepat, masih ragu |
| 2 | Kurang tepat |
| 1 | Salah menentukan urgensi |

**Tatalaksana Nonfarmakologis**

| Skor | Deskripsi |
|---|---|
| 5 | Edukasi lengkap, tepat, dan sesuai kondisi pasien |
| 4 | Edukasi tepat, sedikit kurang lengkap |
| 3 | Edukasi cukup, kurang spesifik |
| 2 | Edukasi kurang tepat |
| 1 | Edukasi salah / berisiko |

**Keputusan Rujukan & Tindak Lanjut**

| Skor | Deskripsi |
|---|---|
| 5 | Keputusan rujukan sangat tepat, cepat, dan sesuai prioritas |
| 4 | Tepat, sedikit ragu |
| 3 | Cukup tepat, perlu arahan |
| 2 | Kurang tepat |
| 1 | Tidak merujuk / salah rujuka |

**Komunikasi & Edukasi**

| Skor | Deskripsi |
|---|---|
| 5 | Komunikasi sangat jelas, empatik, mudah dipahami |
| 4 | Komunikasi baik, minor kekurangan |
| 3 | Cukup jelas, kurang empatik |
| 2 | Kurang jelas |
| 1 | Komunikasi buruk / membingungkan |

**Patient Safety (Keselamatan Pasien)**

| Skor | Deskripsi |
|---|---|
| 5 | Semua keputusan aman, tidak ada risiko |
| 4 | Aman, minor potensi risiko |
| 3 | Cukup aman, masih perlu supervisi |
| 2 | Berisiko bagi pasien |
| 1 | Membahayakan pasie |

| Aspek | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 | Skor 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anamnesis | Tidak lengkap | Kurang sistematis | Cukup | Baik | Sangat lengkap & sistematis |
| Clinical reasoning | Salah analisis | Kurang tepat | Cukup | Baik | Sangat tepat & logis |
| Deteksi tanda bahaya | Tidak mengenali | Sebagian kecil | Sebagian | Hampir semua | Semua terdeteksi cepat |
| Urgensi | Salah | Kurang tepat | Cukup | Tepat | Sangat tepat & cepat |
| Tatalaksana | Salah | Kurang tepat | Cukup | Baik | Sangat tepat & sesuai |
| Rujukan | Tidak/salah | Kurang tepat | Cukup | Tepat | Sangat tepat & prioritas |
| Komunikasi | Buruk | Kurang jelas | Cukup | Baik | Sangat empatik & jelas |
| Patient safety | Membahayakan | Berisiko | Cukup aman | Aman | Sangat aman |

**Format Skor Akhir**

| Aspek | Skor (1–5) |
|---|---|
| Anamnesis | |
| Clinical reasoning | |
| Deteksi tanda bahaya | |
| Urgensi | |
| Tatalaksana | |

| | |
|---|---|
| Rujukan | |
| Komunikasi | |
| Patient safety | |

Total Skor: ____ / 40

**Interpretasi Nilai**

| Rentang Skor | Kategori |
|---|---|
| 32–40 | Sangat kompeten |
| 24–31 | Kompeten |
| 16–23 | Perlu supervisi |
| <16 | Remedial |

Mahasiswa otomatis **tidak kompeten** jika:

- Tidak mengenali tanda bahaya
- Salah menentukan urgensi
- Tidak merujuk kasus gawat
- Memberikan tindakan/edukasi yang membahayakan

**Portofolio**

**Tabel Model Portofolio**

| Komponen | Deskripsi | Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Nonfarmakologis |
|---|---|---|
| **Hakikat portofolio** | Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan untuk menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa. Dalam OBE, portofolio menilai proses dan hasil belajar secara autentik. | Pada topik ini, portofolio menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengkaji keluhan ibu hamil, menganalisis penyebab (fisiologis vs patologis), memberikan edukasi nonfarmakologis, serta memastikan keselamatan pasien melalui keputusan klinis yang tepat. |
| **Tujuan portofolio** | Mendokumentasikan capaian kompetensi mahasiswa, | Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan |

| | | |
|---|---|---|
| | termasuk kemampuan klinis, komunikasi, dokumentasi, dan refleksi diri selama praktik. | dalam memberikan konseling terstruktur, memastikan pemahaman pasien (teach-back), serta mendokumentasikan asuhan secara lengkap dan konsisten untuk mendukung keputusan klinis. |
| **OSCE & DOPS** | OSCE dan DOPS menjadi bukti keterampilan mahasiswa, baik dalam simulasi terstruktur maupun praktik nyata di lahan klinik. | OSCE digunakan untuk menilai keterampilan konseling pada keluhan umum kehamilan, sedangkan DOPS menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian, mendeteksi tanda bahaya, memberikan edukasi nonfarmakologis, serta menentukan kebutuhan rujukan pada kasus nyata. |
| **Catatan kasus** | Catatan kasus berisi ringkasan pasien yang ditangani, mencakup data subjektif, objektif, analisis, tindakan, dan hasil. | Mahasiswa mendokumentasikan kasus ibu hamil dengan keluhan seperti mual muntah, termasuk frekuensi keluhan, kondisi umum, hasil analisis (fisiologis/patologis), serta rencana asuhan dan tindak lanjut. |
| **Konseling terstruktur** | Konseling dilakukan secara sistematis, jelas, dan disertai verifikasi pemahaman pasien (teach-back). | Mahasiswa menjelaskan penyebab keluhan dan tata laksana nonfarmakologis (misalnya makan sedikit tapi sering), kemudian meminta pasien mengulang kembali informasi untuk memastikan pemahaman, sehingga mengurangi risiko kesalahan perawatan di rumah. |

| | | |
|---|---|---|
| **Dokumentasi** | Dokumentasi dilakukan secara lengkap, konsisten, dan sesuai standar (SOAP/ANC), serta mendukung kesinambungan pelayanan. | Mahasiswa mencatat SOAP secara lengkap: S (keluhan), O (kondisi klinis), A (analisis fisiologis/patologis), P (edukasi dan tindak lanjut). Dokumentasi ini menjadi dasar komunikasi klinis dan pengambilan keputusan yang aman. |
| **Refleksi** | Refleksi merupakan proses evaluasi diri mahasiswa terhadap pengalaman praktik untuk meningkatkan pembelajaran. | Mahasiswa merefleksikan pentingnya membedakan keluhan normal dan tanda bahaya, serta menyadari bahwa kesalahan interpretasi dapat berdampak pada keselamatan pasien (patient safety). |
| **Feedback** | Umpan balik dari dosen/CI digunakan sebagai dasar perbaikan kompetensi mahasiswa. | Mahasiswa menerima masukan terkait kemampuan konseling, ketelitian dalam menggali tanda bahaya, serta ketepatan dalam menentukan rujukan, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan praktik selanjutnya. |
| **Makna OBE** | Portofolio memberikan bukti autentik pencapaian pembelajaran pada level "does" dalam piramida Miller. | Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan clinical reasoning, komunikasi, dokumentasi, dan pengambilan keputusan secara konsisten dalam praktik nyata yang berorientasi pada keselamatan pasien. |

**KASUS PORTOFOLIO**

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER I DENGAN MUAL MUNTAH

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Identitas
   - Nama : Ny. E
   - Usia : 32 tahun
   - Gravida/Para/Abortus : G2P1A0
   - Usia kehamilan : ±10 minggu
   - Tanggal : 10 Mei 2025
2. Keluhan Utama

   Ibu mengatakan sering mual dan muntah sejak 1 minggu, frekuensi muntah 3–4 kali/hari, masih bisa makan sedikit dan tidak lemas.
3. Riwayat Menstruasi
   - Menarche: 12 tahun
   - Siklus: 28 hari (teratur)
   - Lama: 6–7 hari
   - HPHT: 28 Juni 2025
   - HPL: 12 Januari 2026
4. Riwayat Kehamilan Sekarang
   - ANC pertama kali
   - Imunisasi TT: belum
   - Riwayat penyakit: tidak ada
5. Riwayat Obstetri
   - G2P1A0
   - Persalinan sebelumnya spontan, cukup bulan, ditolong bidan, tanpa komplikasi
6. Pola Kebutuhan Sehari-hari
   - Nutrisi: makan 2–3 kali/hari, minum cukup
   - Eliminasi: normal
   - Istirahat: cukup (7–8 jam malam, 1 jam siang)
   - Aktivitas: ibu rumah tangga
7. Riwayat Kesehatan
   - Penyakit ibu: tidak ada
   - Penyakit keluarga: tidak ada
8. Psikososial
   - Kehamilan diinginkan
   - Dukungan keluarga baik
   - Ibu memahami kehamilan dari pengalaman sebelumnya

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan Umum
   - Baik
   - Kesadaran: compos mentis
2. Tanda Vital
   - T: 110/70 mmHg
   - Nadi: 80 x/menit
   - RR: 21 x/menit
   - Suhu: 36,8°C
3. Antropometri
   - TB: 158 cm
   - BB sebelum hamil: 58 kg
   - BB sekarang: 64 kg
   - IMT: 25,6 kg/m²
   - LILA: 27 cm
4. Pemeriksaan Fisik
   - Kepala: normal, tidak ada edema
   - Mata: konjungtiva tidak pucat
   - Mulut: bersih
   - Leher: tidak ada pembesaran kelenjar
   - Payudara: normal, areola hiperpigmentasi
   - Abdomen: Teraba Ballottement
   - Ekstremitas: tidak edema
   - Genetalia: normal
5. Pemeriksaan Penunjang
   - Hb: 12,1 g/dL
   - GDS: 69 mg/dL
   - HIV: non reaktif
   - Sifilis: non reaktif
   - Hepatitis B: non reaktif

**ANALISA (A)**

**Diagnosa Kebidanan:**

Ny. E usia 32 tahun G2P1A0 hamil 12 minggu dengan kondisi normal.

**Masalah:**

Mual muntah ringan (emesis gravidarum ringan) sejak 1 minggu, frekuensi 3–4 kali/hari.

**Kebutuhan:**

- Edukasi tentang ketidaknyamanan trimester I
- Manajemen mual muntah
- Pemenuhan nutrisi dan cairan
- Dukungan psikologis

PENATALAKSANAAN (P)

1. Melakukan informed consent sebelum tindakan
   **Evaluasi:** Ibu menyetujui
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa kondisi ibu dan janin baik, usia kehamilan ±10 minggu
   **Evaluasi:** Ibu memahami
3. Memberikan KIE bahwa mual muntah pada trimester I merupakan kondisi fisiologis akibat perubahan hormon
   **Evaluasi:** Ibu mengerti
4. Menganjurkan makan dalam porsi kecil tetapi sering (5–6 kali/hari)
   **Evaluasi:** Ibu bersedia
5. Menganjurkan menghindari makanan berlemak, berminyak, dan berbau tajam
   **Evaluasi:** Ibu memahami
6. Menganjurkan makan makanan kering sebelum bangun tidur (biskuit/roti)
   **Evaluasi:** Ibu bersedia
7. Menganjurkan minum sedikit tetapi sering dan tidak bersamaan dengan makan
   **Evaluasi:** Ibu memahami
8. Menganjurkan istirahat cukup dan menghindari kelelahan
   **Evaluasi:** Ibu bersedia
9. Menganjurkan konsumsi jahe hangat atau aromaterapi (lemon) untuk mengurangi mual
   **Evaluasi:** Ibu bersedia mencoba
10. Memberikan terapi sesuai indikasi (Vitamin B6)
    **Evaluasi:** Ibu bersedia
11. Menganjurkan pemenuhan nutrisi dan cairan untuk mencegah dehidrasi
    **Evaluasi:** Ibu memahami
12. Memberikan edukasi tanda bahaya: Muntah berlebihan, tidak bisa makan/minum, lemas/dehidrasi
    **Evaluasi:** Ibu memahami
13. Menganjurkan kontrol ulang 1 minggu atau jika ada keluhan
    **Evaluasi:** Ibu bersedia

**RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO**

**Identitas**

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Semester : .....

Kasus : Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Trimester I dengan Mual Muntah

Rubrik Penilaian

| No | Komponen Penilaian | Indikator | Bobot | Skor (1–4) | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Data Subjektif (S)** | Kelengkapan anamnesis (identitas, keluhan, riwayat menstruasi, obstetri, kesehatan, psikososial) | 10% | | |
| 2 | | Kesesuaian data dengan kasus | 5% | | |
| 3 | **Data Objektif (O)** | Kelengkapan pemeriksaan (fisik & penunjang) | 10% | | |
| 4 | | Ketepatan interpretasi hasil pemeriksaan | 5% | | |
| 5 | **Analisa (A)** | Ketepatan diagnosa kebidanan | 10% | | |
| 6 | | Ketepatan identifikasi masalah & kebutuhan | 10% | | |
| 7 | **Penatalaksanaan (P)** | Kesesuaian intervensi dengan diagnosa | 10% | | |
| 8 | | Kelengkapan tindakan (KIE, terapi, monitoring, rujukan) | 10% | | |
| 9 | | Adanya evaluasi setiap tindakan | 5% | | |
| 10 | **KIE (Edukasi)** | Kejelasan, relevansi, dan aplikatif | 10% | | |
| 11 | **Bahasa & Sistematika** | Bahasa ilmiah, kerapian, sistematika SOAP | 10% | | |
| 12 | **Kesesuaian Teori** | Tidak ada kesalahan konsep (usia kehamilan, pemeriksaan, dll) | 5% | | |

Kriteria Skor

| Skor | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Kurang (tidak sesuai/tidak lengkap) |
| 2 | Cukup (kurang lengkap/kurang tepat) |
| 3 | Baik (cukup lengkap dan sesuai) |
| 4 | Sangat Baik (lengkap, tepat, sistematis, dan ilmiah) |

Perhitungan Nilai

**Nilai Akhir = Σ (Skor × Bobot)**

Kategori Nilai

| Nilai | Kategori |
|---|---|
| 85 – 100 | Sangat Baik |
| 75 – 84 | Baik |
| 65 – 74 | Cukup |
| < 65 | Kurang |

**Catatan Penguji**

.....

**Case Report**

**Tabel. Case Report pada Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Nonfarmakologis**

| Komponen | Deskripsi | Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Nonfarmakologis |
|---|---|---|
| Hakikat Case Report | Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik sebagai bukti kemampuan analisis klinis. | Mahasiswa menyusun laporan tentang ibu hamil trimester I dengan keluhan mual muntah (emesis gravidarum ringan) sebagai keluhan umum kehamilan. |
| Tujuan | Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, analisis masalah, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. | Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab mual muntah pada trimester I serta memberikan tata laksana nonfarmakologis yang tepat dan aman. |

| | | |
|---|---|---|
| Isi Laporan | Mencakup identitas pasien, data subjektif, objektif, analisa, diagnosis kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran kasus. | Kasus berisi ibu hamil 10–12 minggu dengan keluhan mual muntah 3–4 kali/hari, masih dapat makan, tidak ada tanda dehidrasi, diagnosa emesis gravidarum ringan, penatalaksanaan berupa edukasi pola makan, istirahat, dan terapi nonfarmakologis. |
| Fokus Penilaian | Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinis, tindakan, dan evaluasi. | Mahasiswa dinilai dari kemampuan menghubungkan perubahan hormonal trimester I sebagai penyebab mual muntah serta memberikan intervensi nonfarmakologis yang sesuai tanpa over treatment. |
| Nilai Edukatif | Mengembangkan clinical reasoning, dokumentasi ilmiah, dan refleksi praktik klinik. | Mahasiswa memahami bahwa mual muntah ringan adalah kondisi fisiologis yang dapat ditangani tanpa obat melalui modifikasi gaya hidup dan edukasi ibu. |
| Makna dalam OBE | Menunjukkan kemampuan mahasiswa menerapkan teori dalam praktik nyata secara sistematis. | Mahasiswa mampu menerapkan teori tentang ketidaknyamanan kehamilan trimester I ke dalam asuhan kebidanan berbasis evidensi dan pendekatan holistik. |

**Tabel. Refleksi Patient Safety pada Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Non farmakologis**

| **Komponen** | **Deskripsi** | Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Non farmakologis |
|---|---|---|
| **Hakikat Refleksi Patient Safety** | Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, | Pada kasus ibu hamil trimester I dengan mual muntah, mahasiswa merefleksikan bahwa ketidaktepatan penilaian kondisi dapat menyebabkan |

| | | |
|---|---|---|
| | menganalisis penyebab, dan merencanakan pencegahan. | keterlambatan deteksi hiperemesis gravidarum. |
| **Tujuan** | Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam setiap tindakan kebidanan. | Mahasiswa memahami bahwa keluhan yang tampak ringan seperti mual muntah tetap memerlukan pengkajian yang tepat agar tidak berkembang menjadi kondisi berat. |
| **Fokus Refleksi** | Meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran dari praktik klinik. | Fokus pada kemampuan membedakan emesis gravidarum ringan dengan hiperemesis gravidarum serta penatalaksanaan nonfarmakologis yang aman. |
| **Risiko yang Diidentifikasi** | Mahasiswa harus mampu mengenali kondisi yang berpotensi membahayakan pasien. | Risiko yang mungkin terjadi: dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, penurunan berat badan, kurang nutrisi, serta keterlambatan rujukan jika kondisi memburuk. |
| **Analisis Penyebab Risiko** | Menjelaskan faktor yang menyebabkan munculnya risiko. | Risiko terjadi akibat kurangnya pemantauan frekuensi muntah, tidak adekuatnya asupan nutrisi, kurang edukasi ibu, serta keterlambatan mengenali tanda bahaya. |
| **Tindakan Pencegahan** | Menjelaskan langkah konkret untuk mencegah risiko keselamatan pasien. | Melakukan edukasi pola makan (sedikit tapi sering), anjuran minum cukup, istirahat, penggunaan terapi nonfarmakologis (jahe/aromaterapi), pemantauan kondisi ibu, serta pemberian informasi tanda bahaya dan rujukan bila diperlukan. |
| **Pembelajaran Mahasiswa** | Menunjukkan refleksi terhadap pengalaman klinik | Mahasiswa belajar bahwa pengkajian yang tepat dan |

| | | |
|---|---|---|
| | dan dampaknya pada praktik selanjutnya. | edukasi yang efektif dapat mencegah komplikasi serta meningkatkan keselamatan ibu hamil. |
| **Makna dalam OBE** | Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis. | Mahasiswa mampu menerapkan prinsip patient safety dalam asuhan kebidanan dengan pendekatan promotif dan preventif pada keluhan umum kehamilan. |

## K. Ringkasan

Keluhan umum kehamilan merupakan ketidaknyamanan yang sering dialami oleh ibu hamil sebagai akibat dari perubahan fisiologis tubuh selama masa kehamilan. Perubahan ini melibatkan berbagai sistem tubuh, seperti sistem hormonal, kardiovaskular, gastrointestinal, dan muskuloskeletal. Peningkatan hormon kehamilan seperti human chorionic gonadotropin (HCG), estrogen, dan progesteron berperan penting dalam munculnya berbagai keluhan, terutama pada trimester pertama. Selain itu, pembesaran uterus dan perubahan postur tubuh juga turut memengaruhi kondisi fisik ibu hamil.

Keluhan yang sering dialami antara lain mual dan muntah, nyeri punggung, sering buang air kecil, konstipasi, edema, heartburn, dan kram kaki. Sebagian besar keluhan tersebut bersifat fisiologis atau normal sebagai bagian dari proses adaptasi tubuh ibu. Namun, keluhan dapat menjadi patologis apabila bersifat berat, menetap, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai tanda bahaya seperti muntah berlebihan, perdarahan, nyeri hebat, atau edema yang disertai hipertensi.

Penilaian keluhan kehamilan sangat penting dilakukan untuk membedakan kondisi normal dan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Penilaian dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan identifikasi tanda bahaya. Anamnesis meliputi penggalian informasi tentang jenis, durasi, frekuensi, serta faktor pencetus keluhan, juga usia kehamilan dan riwayat kesehatan ibu. Pemeriksaan fisik meliputi pengukuran tanda vital, pemeriksaan abdomen, serta evaluasi adanya edema. Apabila ditemukan tanda bahaya, maka ibu hamil harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Penatalaksanaan keluhan umum kehamilan pada kondisi ringan hingga sedang umumnya dilakukan dengan pendekatan nonfarmakologis. Pendekatan ini menjadi pilihan utama karena aman bagi ibu dan janin, mudah dilakukan, serta memiliki risiko efek samping yang minimal. Prinsip utama dalam tata laksana

nonfarmakologis meliputi keamanan, berbasis edukasi, perubahan gaya hidup, serta bersifat preventif dan promotif.

Bentuk penatalaksanaan nonfarmakologis meliputi modifikasi pola makan, aktivitas fisik, pengaturan posisi tubuh dan istirahat, teknik relaksasi, serta edukasi dan konseling. Modifikasi pola makan dilakukan dengan makan dalam porsi kecil tetapi sering, menghindari makanan pemicu, serta meningkatkan konsumsi serat dan cairan. Aktivitas fisik ringan seperti senam hamil, jalan kaki, dan peregangan dapat membantu m engurangi keluhan serta meningkatkan kebugaran. Pengaturan posisi tubuh, seperti tidur miring ke kiri dan penggunaan bantal penyangga, dapat meningkatkan kenyamanan dan sirkulasi darah. Teknik relaksasi seperti latihan pernapasan, yoga, dan meditasi juga efektif dalam mengurangi stres dan ketidaknyamanan.

Edukasi dan konseling merupakan bagian penting dalam penatalaksanaan, di mana tenaga kesehatan memberikan informasi mengenai kondisi yang dialami ibu, cara mengatasi keluhan, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat penting dalam melakukan deteksi dini, memberikan edukasi, mendampingi ibu selama kehamilan, serta melakukan promosi kesehatan.

Dalam memberikan asuhan, tenaga kesehatan perlu menerapkan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu secara menyeluruh serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal. Dengan demikian, penanganan keluhan umum kehamilan harus dilakukan secara sistematis, berbasis evidence, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan janin.

**Tabel Red Flags & Eskalasi: Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Nonfarmakologis**

| Red Flags (Tanda Bahaya) | Makna Klinis | Tindakan Eskalasi |
|---|---|---|
| Muntah berlebihan (>5–10x/hari), tidak bisa makan/minum | Mengarah ke hiperemesis gravidarum, risiko dehidrasi & gangguan elektrolit | Rujuk segera ke fasilitas kesehatan, lakukan rehidrasi dan evaluasi lanjutan |
| Penurunan berat badan signifikan | Menandakan malnutrisi atau dehidrasi | Rujuk untuk penanganan nutrisi dan cairan |

| | | |
|---|---|---|
| Nyeri hebat (abdomen/punggung/kepala) | Kemungkinan kondisi patologis (infeksi, komplikasi kehamilan) | Evaluasi segera, rujuk jika nyeri menetap atau berat |
| Perdarahan pervaginam | Risiko abortus, plasenta previa, atau solusio plasenta | Rujuk darurat ke fasilitas rujukan |
| Edema mendadak pada wajah/tangan + hipertensi | Tanda preeklamsia | Rujuk segera, monitoring tekanan darah dan kondisi ibu |
| Sakit kepala berat dan gangguan penglihatan | Indikasi preeklamsia berat | Rujuk darurat untuk penanganan intensif |
| Demam tinggi | Kemungkinan infeksi | Evaluasi dan rujuk untuk terapi lebih lanjut |
| Nyeri saat BAK dan urine keruh | Infeksi saluran kemih (ISK) | Pemeriksaan urin dan terapi medis |
| Kram kaki dengan bengkak satu sisi dan nyeri hebat | Kemungkinan trombosis vena dalam (DVT) | Rujuk segera untuk evaluasi vaskular |
| Heartburn berat disertai muntah terus-menerus | Gangguan gastrointestinal atau komplikasi lain | Evaluasi dan rujuk bila tidak membaik |
| Gerakan janin berkurang atau tidak terasa | Tanda gangguan kesejahteraan janin | Rujuk segera untuk pemeriksaan janin |
| Lemas berat, tanda dehidrasi (mulut kering, turgor jelek) | Gangguan keseimbangan cairan | Rujuk dan lakukan terapi cairan |

**Form Checklist "Saya sudah bisa…"**

**Topik: Keluhan Umum Kehamilan: Penilaian Penyebab dan Tata Laksana Nonfarmakologis**

**Nama Mahasiswa** : _____

**NIM** : _____

**Tanggal** : _____

**Tempat Praktik / Skill Lab** : _____

**Petunjuk:** Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

| No | Pernyataan | Sudah | Belum | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saya sudah bisa menjelaskan pengertian keluhan umum kehamilan | ☐ | ☐ | _____ |
| 2 | Saya sudah bisa membedakan keluhan fisiologis dan patologis pada kehamilan | ☐ | ☐ | _____ |
| 3 | Saya sudah bisa menyebutkan jenis-jenis keluhan umum kehamilan | ☐ | ☐ | _____ |
| 4 | Saya sudah bisa menjelaskan penyebab keluhan berdasarkan perubahan fisiologis kehamilan | ☐ | ☐ | _____ |
| 5 | Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil dengan keluhan umum | ☐ | ☐ | _____ |
| 6 | Saya sudah bisa menggali karakteristik keluhan (frekuensi, durasi, pencetus, pereda) | ☐ | ☐ | _____ |
| 7 | Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik dasar (tanda vital, abdomen, edema) | ☐ | ☐ | _____ |
| 8 | Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya pada kehamilan | ☐ | ☐ | _____ |
| 9 | Saya sudah bisa membedakan kondisi normal dan kondisi yang memerlukan rujukan | ☐ | ☐ | _____ |
| 10 | Saya sudah bisa menentukan tindakan awal nonfarmakologis sesuai keluhan | ☐ | ☐ | _____ |
| 11 | Saya sudah bisa memberikan edukasi terkait pola makan yang tepat | ☐ | ☐ | _____ |
| 12 | Saya sudah bisa memberikan edukasi aktivitas fisik dan istirahat pada ibu hamil | ☐ | ☐ | _____ |
| 13 | Saya sudah bisa mengajarkan teknik relaksasi sederhana pada ibu hamil | ☐ | ☐ | _____ |
| 14 | Saya sudah bisa memberikan konseling dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami | ☐ | ☐ | _____ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya kepada ibu dan keluarga | ☐ | ☐ | _____ |
| 16 | Saya sudah bisa menentukan kapan ibu harus kontrol ulang atau dirujuk | ☐ | ☐ | _____ |
| 17 | Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil pengkajian dan tindakan secara sistematis (SOAP) | ☐ | ☐ | _____ |
| 18 | Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional (empati, komunikasi, privasi, keselamatan pasien) | ☐ | ☐ | _____ |

**Glosarium**

Antenatal Care (ANC)

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin.

Anamnesis

Proses pengumpulan data melalui wawancara untuk mengetahui keluhan, riwayat kesehatan, dan kondisi ibu hamil.

Assessment (Penilaian Klinis)

Proses interpretasi data untuk menentukan kondisi ibu, apakah fisiologis atau patologis.

Clinical Reasoning

Proses berpikir sistematis dalam menganalisis data klinis untuk menentukan diagnosis dan tindakan yang tepat.

Emesis Gravidarum

Mual dan muntah ringan pada kehamilan yang masih dalam batas normal.

Hiperemesis Gravidarum

Mual dan muntah berat pada kehamilan yang dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan elektrolit.

Edema

Pembengkakan akibat penumpukan cairan di jaringan tubuh, terutama pada ekstremitas.

Heartburn (Nyeri Ulu Hati)

Rasa terbakar di dada akibat refluks asam lambung ke esofagus.

Konstipasi

Kesulitan buang air besar dengan feses keras dan frekuensi jarang.

Kram Kaki

Kontraksi otot mendadak pada kaki yang menimbulkan nyeri, sering terjadi pada malam hari.

Nyeri Punggung

Rasa nyeri pada daerah punggung akibat perubahan postur dan beban tubuh selama kehamilan.

Keluhan Fisiologis

Keluhan normal akibat adaptasi tubuh selama kehamilan yang tidak membahayakan ibu dan janin.

Keluhan Patologis

Keluhan yang tidak normal dan berpotensi membahayakan, sehingga memerlukan penanganan medis.

Red Flags (Tanda Bahaya)

Gejala yang menunjukkan kemungkinan komplikasi serius pada kehamilan.

Eskalasi

Tindakan lanjutan berupa peningkatan penanganan, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan.

Tata Laksana Nonfarmakologis

Penanganan keluhan tanpa penggunaan obat, seperti perubahan gaya hidup dan edukasi.

Modifikasi Pola Makan

Pengaturan pola makan untuk mengurangi keluhan, misalnya makan sedikit tetapi sering.

Aktivitas Fisik Ringan

Kegiatan seperti jalan kaki atau senam hamil untuk menjaga kebugaran dan mengurangi keluhan.

Teknik Relaksasi

Metode seperti pernapasan, yoga, atau meditasi untuk mengurangi stres dan ketegangan.

Edukasi dan Konseling

Proses pemberian informasi dan dukungan kepada ibu hamil agar mampu mengelola keluhan secara mandiri.

Patient Safety (Keselamatan Pasien)

Upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan atau komplikasi dalam pelayanan kesehatan.

Woman-Centered Care

Pendekatan pelayanan yang berfokus pada kebutuhan, kenyamanan, dan kondisi ibu.

Teach-Back

Metode evaluasi pemahaman pasien dengan meminta pasien mengulang kembali informasi yang diberikan.

SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)

Format dokumentasi klinis yang sistematis dalam asuhan kebidanan.

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Metode penilaian keterampilan klinis melalui observasi langsung di lahan praktik.
OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
Metode ujian praktik terstruktur untuk menilai keterampilan klinis mahasiswa.
Portofolio
Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa.
Case Report
Laporan kasus klinis yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan kemampuan analisis mahasiswa.
Refleksi
Proses evaluasi diri terhadap pengalaman praktik untuk meningkatkan pembelajaran.

## L. Daftar Pustaka


Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). *Williams obstetrics*. McGraw-Hill. https://www.mheducation.com/highered/mhp/product/williams-obstetrics-25th-edition.html?utm_source=chatgpt.com&viewOption=student

Gynecologists, A. C. of O. and. (2018). Nausea and vomiting of pregnancy. *ACOG*.

Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2020). *Maternity and women's health care*. Elsevier.

Matthews, A., Dm, H., Dp, O. M., & Dowswell, T. (2015). *Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy ( Review )*. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007575.pub4.www.cochranelibrary.com

Prawirohardjo, S. (2016). *Ilmu kebidanan*. PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Sulistyawati, A. (2013). *Asuhan kebidanan pada masa kehamilan*. Salemba Medika.

Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2015). *Varney's midwifery* (Jones & Bartlett Learning. (ed.); 5th ed.).

Vermani, E., Mittal, R., & Weeks, A. (n.d.). *Pelvic Girdle Pain and Low Back Pain in Pregnancy : A Review*. 60–71.

World Health Organization. (2020). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*.

# BAB 5

## KONSELING ANC TERPADU: GIZI, AKTIVITAS, PERSIAPAN PERSALINAN, DAN RENCANA RUJUKAN

**Tabel CPL**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menguasai konsep ilmiah dan evidence-based terkait pemeriksaan antenatal terpadu. | CPMK-1, CPMK-5 |
| CPL-2 | Mampu melaksanakan pemeriksaan antenatal terpadu secara sistematis, aman, dan efektif. | CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4 |
| CPL-3 | Mampu menginterpretasi temuan klinis dan penunjang untuk mengenali masalah serta risiko kehamilan. | CPMK-4, CPMK-5, CPMK-6 |
| CPL-4 | Mampu menetapkan tindak lanjut, intervensi awal, dan rencana rujukan berdasarkan hasil pemeriksaan. | CPMK-6, CPMK-7 |
| CPL-5 | Mampu berkomunikasi terapeutik dan melakukan konseling kesehatan ibu secara kolaboratif. | CPMK-2, CPMK-7 |
| CPL-6 | Menunjukkan profesionalisme (etika, privasi, keselamatan pasien, pencegahan infeksi, dokumentasi) dalam pelayanan ANC. | CPMK-1, CPMK-3, CPMK-7 |

**Tabel CPMK**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Menganalisis konsep dasar pemeriksaan antenatal terpadu, standar pelayanan ANC, serta prinsip privasi, keselamatan pasien, dan pencegahan infeksi. |
| CPMK-2 | Melaksanakan anamnesis terstruktur pada ibu hamil untuk menghimpun data penting dan mengenali faktor risiko. |
| CPMK-3 | Melaksanakan pemeriksaan tanda vital, antropometri, dan pemeriksaan fisik umum ibu hamil sesuai prosedur serta menafsirkan temuan dasar. |

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-4 | Melaksanakan pemeriksaan abdomen obstetri dan penilaian kesejahteraan janin secara sistematis serta menginterpretasi hasil pemantauan klinis. |
| CPMK-5 | Menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang kehamilan (laboratorium dasar dan USG) dan mengintegrasikannya dengan temuan klinis. |
| CPMK-6 | Mengidentifikasi tanda bahaya dan masalah prioritas pada kehamilan (termasuk hipertensi/preeklamsia, anemia/gizi, keluhan umum) serta menetapkan tindak lanjut awal dan kebutuhan rujukan. |
| CPMK-7 | Melaksanakan konseling ANC terpadu dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam format standar untuk mendukung keputusan klinis dan komunikasi layanan. |

## Uraian Materi

### A. Konseling ANC Terpadu: Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan

Konseling Terpadu ANC (Antenatal Care) adalah merupakan bagian dari pelayanan antenatal komprehensif yang memberikan informasi, dukungan, dan edukasi kepada ibu hamil untuk memastikan kesehatan fisik dan mental yang optimal selama masa kehamilan hingga persalinan. Tujuan utama Konseling Terpadu ANC adalah untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi melalui pendekatan preventif dan edukatif yang komprehensif. Antara lain mendeteksi dini faktor risiko dan komplikasi, yang berisi analisis Risiko yaitu mengidentifikasi potensi tanda-tanda bahaya sejak dini melalui pemeriksaan rutin untuk meminimalkan risiko persalinan prematur, gangguan pertumbuhan janin, hingga kematian ibu dan bayi. Selanjutnya intervensi yang tepat memungkinkan penyedia layanan kesehatan memberikan perawatan perinatal yang sesuai dengan tingkat risiko masing-masing ibu. Selanjutnya mempersiapkan Persalinan yang aman dan lancar yaitu Program P4K, melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), ibu dibantu merencanakan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk menjamin keselamatan serta kesiapan mental & fisik ibu yang memberikan gambaran mengenai proses kelahiran agar ibu lebih siap menghadapi persalinan tanpa kecemasan berlebih. Edukasi gizi menjelaskan tentang gizi seimbang yaitu memberikan pemahaman mengenai Pedoman Gizi Seimbang (PGS) sebagai kunci keselamatan dari risiko komplikasi. Sementara itu aktifitas ibu hamil: adalah segala bentuk pergerakan tubuh atau kegiatan fisik yang dilakukan oleh ibu selama masa kehamilan untuk menjaga kebugaran, memperlancar aliran darah, dan mempersiapkan kekuatan otot tubuh menjelang persalinan. Selanjutnya rencana rujukan yaitu proses perencanaan strategis yang disusun oleh tenaga kesehatan bersama ibu hamil dan keluarganya untuk menentukan langkah-langkah darurat dan prosedur perpindahan perawatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (seperti Puskesmas atau Praktik Mandiri Bidan) ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap (Rumah Sakit) jika terjadi komplikasi atau tanda bahaya. Selanjutnya mendukung kesehatan mental ibu yaitu dukungan kesehatan mental ibu dengan menyampaikan edukasi tentang adaptasi psikologis sehingga membantu ibu mengelola perubahan emosional dan tanggung jawab baru sebagai orang tua. Serta melakukan Skrining Gangguan Mental yaitu dengan memberikan dukungan pada ibu hamil, data menunjukkan sekitar 10-13% ibu hamil dan baru melahirkan berisiko mengalami gangguan mental.

Hal-hal penting dalam Konseling Terpadu ANC antara lain:

**1. Definisi Operasional:**

Defenisi Operasional merupakan Kegiatan pemberian bimbingan dan tindak lanjut bagi ibu hamil yang memerlukan analisis mendalam mengenai masalah kesehatan tertentu. Dalam konteks pelayanan kesehatan (khususnya di Puskesmas atau Rumah Sakit), Definisi Operasional dari kegiatan konseling merujuk pada langkah-langkah konkret yang dilakukan tenaga medis saat menemukan ibu hamil dengan kondisi khusus.

Komponen dari defenisi opersional terdiri dari:

a. Kegiatan Pemberian Bimbingan

Kegiatan pemberian bimbingan Ini bukan sekadar obrolan biasa, melainkan proses komunikasi interpersonal dan konseling terarah. Tenaga kesehatan akan memberikan informasi medis yang disesuaikan dengan kondisi spesifik ibu, misalnya:

- Cara mengatur diet bagi ibu hamil dengan diabetes (Diabetes Gestasional). Latihan fisik atau posisi tidur tertentu bagi ibu dengan kelainan letak janin. Edukasi khusus mengenai risiko preeklamsia jika tekanan darah mulai tinggi.

b. Memerlukan Analisis Mendalam

Dalam memberikan konseling kita memerlukan analisis mendalam sesuai kebituhan ibu. Misalnya ibu hamil tersebut masuk dalam kategori Risiko Tinggi (Risti) atau memiliki komplikasi. Maka dilakukan analisis mendalam yang terdiri dari:

1) Pemeriksaan Penunjang: Melakukan tes laboratorium tambahan (seperti cek protein urine, gula darah, atau infeksi menular).
2) Penelusuran Riwayat: Menggali lebih dalam riwayat medis keluarga atau kehamilan sebelumnya (misal: pernah keguguran berulang atau sesak napas).
3) Kolaborasi Lintas Program: Dokter umum akan berkonsultasi dengan ahli gizi, petugas laboratorium, bahkan psikolog jika diperlukan.

c. Tindak Lanjut (Follow-up)

Pada bagian tindak lanjut Ini adalah bagian paling penting, setelah masalah diidentifikasi, tenaga kesehatan harus menentukan langkah berikutnya, seperti:

1) Rujukan: Mengirim ibu ke dokter spesialis kandungan (Sp.OG) di RS yang lebih lengkap.
2) Kunjungan Rumah (P4K): Bidan desa mendatangi rumah ibu untuk memastikan lingkungan rumah mendukung kesehatannya.
3) Pemantauan Ketat: Menambah frekuensi kontrol (misal dari sebulan sekali menjadi seminggu sekali).

d. Masalah Kesehatan Tertentu

Masalah Kesehatan "tertentu" di sini maksudnya adalah kondisi ibu hamil dengan keadaan di luar kehamilan normal, misalnya:

1) Kekurangan Energi Kronis (KEK): Ibu yang terlalu kurus (LILA < 23,5 cm).
   Penyakit Penyerta: Seperti Anemia berat, Jantung, HIV/Sifilis, atau Hepatitis B.
2) Komplikasi Kebidanan: Seperti plasenta previa atau janin sungsang.

**2. Sifat Terpadu**

Sifat terpadu ini melibatkan berbagai tenaga kesehatan secara lintas program, seperti bidan, dokter umum, dokter gigi, ahli gizi, dan petugas laboratorium. Sifat Terpadu dalam ANC (Antenatal Care) berarti pelayanan kesehatan bagi ibu hamil tidak hanya dilakukan oleh satu orang (misalnya bidan saja), melainkan melalui kolaborasi antartenaga ahli (interprofesi) untuk memastikan kesehatan ibu dan janin secara menyeluruh.

Peran masing-masing tenaga kesehatan dalam sistem lintas program tersebut adalah

a. Bidan

Peran bidan yaitu melakukan pemeriksaan rutin (timbangan, tekanan darah, denyut jantung janin), pemantauan pertumbuhan janin, serta memberikan edukasi awal. Tugas Terpadu bidan Adalah mengidentifikasi risiko awal. Jika ditemukan kejanggalan, bidan akan langsung mengarahkan ibu ke dokter atau unit terkait di dalam puskesmas/RS.

b. Dokter Umum

Peran dokter umum melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh (skrining medis) pada trimester pertama dan ketiga. Tugas Terpadu dokter umum Adalah mendiagnosa penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, atau infeksi. Dokter juga yang memutuskan apakah ibu perlu dirujuk ke Dokter Spesialis Kebidanan (Sp.OG).

c. Dokter Gigi

Peran dokter gigi adalah memeriksa kesehatan mulut dan gusi ibu hamil. Sedangkan Tugas Terpadu dokter gigi Adalah mengidentifikasi Infeksi pada gusi (periodontitis) pada ibu hamil terbukti secara medis dapat memicu persalinan prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Maka, pemeriksaan gigi adalah bagian wajib dari ANC Terpadu.

d. Ahli Gizi (Nutrisionis)

Ahli Gizi berperan menilai status gizi ibu melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dan berat badan. Dan Tugas Terpadu: Memberikan diet khusus bagi

ibu yang mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis), Anemia (kurang darah), atau obesitas agar pertumbuhan janin tetap optimal.

e. Petugas Laboratorium

Petugas Laboratorium berperan: Melakukan tes darah dan urine. Sedangkan Tugas Terpadu petugas laboratorium mendeteksi kondisi yang tidak terlihat dari luar, seperti kadar Hemoglobin (Hb), golongan darah, kadar gula darah, serta skrining penyakit menular seperti HIV, Sifilis, dan Hepatitis B (Triple Eliminasi).

Pentingnya sistem lintas program ini dibuat agar tidak ada masalah kesehatan yang "terlewat". Dengan kerja sama ini, ibu hamil mendapatkan pelayanan satu pintu (one-stop service) yang komprehensif, sehingga risiko kematian ibu dan bayi dapat ditekan seminimal mungkin.

**3. Standar Pelaksanaan:**

Standar pelaksanaan merupakan bagian dari standar pelayanan "10 T" atau "14 T" dalam ANC, khususnya pada poin Temu Wicara (Konseling). Dalam standar pelayanan kesehatan di Indonesia, Temu Wicara (Konseling) adalah salah satu pilar utama dalam rangkaian pemeriksaan kehamilan, dimana bidan atau dokter duduk bersama ibu hamil (dan suami/keluarga) untuk berdialog dua arah. Fokusnya bukan hanya memeriksa fisik, tapi memastikan ibu paham kondisi kehamilannya. Isi dari Temu Wicara dalam Standar 10 T: Dalam poin ini, tenaga kesehatan wajib memberikan informasi mengenai: Hasil Pemeriksaan: Menjelaskan kondisi janin, posisi bayi, dan kesehatan ibu berdasarkan pemeriksaan T1 sampai T9 sebelumnya. Perencanaan Persalinan (P4K): Membahas di mana akan melahirkan, siapa penolongnya, siapa pendonor darah cadangan, dan transportasi yang akan digunakan. Tanda Bahaya Kehamilan: Memberi tahu kapan ibu harus segera ke RS (misal: perdarahan, kaki bengkak hebat, atau janin kurang bergerak). Masalah Kesehatan Spesifik: Jika hasil tes lab (T9) menunjukkan masalah (seperti anemia atau infeksi), maka akan dibahas solusi dan pengobatannya secara mendalam. Manfaat emu wicara ini untuk memastikan: Ibu hamil merasa tenang dan didukung secara psikologis, keluarga siap siaga jika terjadi keadaan darurat, mencegah keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat keluarga.

## B. Konseling gizi, aktivitas ibu hamil, persiapan persalinan dan rencana rujukan

Materi konseling gizi ibu hamil

1. Tujuan Konseling: memberikan pemahaman kepada ibu agar: memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan, menjaga kesehatan ibu dan janin, mencegah anemia dan kekurangan gizi, serta mendukung pertumbuhan janin optimal

2. Prinsip Gizi Ibu Hamil: prinsip gizi pada ibu hamila adalah makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, tidak perlu makan "dua kali lipat", tapi lebih berkualitas, serta makan teratur dan cukup
3. Kebutuhan Zat Gizi Penting
   a. Energi, tambahan ±300–450 kkal/hari (trimester 2 & 3) Contohnya: nasi + lauk + sayur + buah
   b. Protein, untuk pertumbuhan janin, sumber: telur, ikan, ayam, tempe, tahu
   c. Zat Besi (Fe), mencegah anemia, sumber: daging merah, hati, sayur hijau, wajib minum tablet Fe setiap hari
   d. Asam Folat, mencegah cacat pada janin, sumber: sayur hijau, kacang-kacangan
   e. Kalsium, bermanfaat pembentukan tulang janin, sumber: susu, ikan teri, keju
   f. Yodium berguna untuk perkembangan otak janin yang bersumber dari garam beryodium
4. Pola Makan yang Dianjurkan: 3 kali makan utama + 2 kali selingan, porsi kecil tapi sering, minum air putih ±8 gelas/hari
5. Contoh Menu Sederhana (Lokal)
   a. Pagi: nasi + telur + sayur bayam
   b. Siang: nasi + ikan + sayur + buah
   c. Malam: nasi + ayam/tempe + sayur
   d. Selingan: buah, kacang, susu
6. Makanan yang Dianjurkan, karbohidrat: nasi, ubi, jagung. Protein: ikan, telur, tempe sayur hijau dan buah berwarna. Susu ibu hamil (jika ada)
7. Makanan yang Harus Dibatasi/Dihindari
   Makanan mentah/setengah matang, kafein berlebihan (kopi, teh), makanan tinggi gula & lemak, serta alkohol (harus dihindari)
8. Tablet Tambah Darah (Fe), minum 1 tablet/hari, waktu terbaik: malam hari, minum dengan air putih atau jus jeruk, hindari minum dengan teh/kopi
9. Penanganan Keluhan Terkait Gizi
   Jika mual muntah, makan sedikit tapi sering, hindari makanan berbau tajam. Jika terasa lemas / anemia tingkatkan makanan tinggi zat besi, rutin minum tablet Fe. Jika nafsu makan kurang, pilih makanan yang disukai dan variasikan menu
10. Pemantauan Berat Badan : Kenaikan ideal ±11–16 kg selama hamil yang ditimbang setiap kunjungan ANC
11. Kebersihan Makanan: Cuci tangan sebelum makan, masak makanan sampai matang, hindari makanan tidak higienis
12. Peran Keluarga: membantu menyediakan makanan bergizi, mengingatkan minum tablet Fe, mendukung ibu

## C. Konseling Aktivitas Ibu Hamil

1. Tujuan Konseling: menjelaskan kepada ibu bahwa aktivitas yang tepat selama kehamilan bertujuan untuk: menjaga kesehatan ibu dan janin, meningkatkan kebugaran tubuh, mengurangi keluhan (pegal, nyeri punggung, stres), mempersiapkan persalinan
2. Prinsip Aktivitas Ibu Hamil: aktivitas yang boleh dilakukan ibu hamil selama tidak berlebihan, hindari kelelahan serta iIstirahat yang cukups esuaikan dengan usia kehamilan
3. Aktivitas yang Dianjurkan
   a. Aktivitas ringan sehari-hari seperti menyapu, memasak, berjalan santai dan tidak berdiri terlalu lama
   b. Olahraga ringan: Jalan kaki (15–30 menit/hari), senam hamil, yoga hamil
   c. Istirahat: Tidur malam 7–8 jam, istirahat siang 1–2 jam dengan posisi tidur miring kiri (melancarkan aliran darah ke janin)
4. Aktivitas yang Harus Dibatasi / Dihindari Adalah mengangkat beban berat, berdiri terlalu lama, aktivitas berisiko jatuh (naik tangga tinggi, sepeda ekstrem) dan olahraga berat (lari cepat, lompat, angkat beban)
5. Aktivitas Berdasarkan Trimester
   Trimester 1: Ibu sering lelah dan mual, anjurkan ibu banyak istirahat, aktivitas ringan
   Trimester 2: Kondisi lebih stabil, ibu boleh mulai olahraga ringan rutin
   Trimester 3: Perut sudah membesar maka hindari aktivitas berat, fokus relaksasi dan persiapan persalinan
6. Tanda Bahaya Saat Beraktivitas, hentikan aktivitas dan segera periksa jika terasa pusing hebat, perdarahan, nyeri perut hebat, air ketuban keluar, gerakan janin berkurang
7. Aktivitas Seksual, aman jika kehamilan normal, hindari jika ada perdarahan atau risiko tinggi, gunakan posisi yang nyaman
8. Perjalanan (Traveling) : Boleh jika kehamilan sehat, hindari perjalanan jauh saat trimester 3, gunakan sabuk pengaman dengan benar
9. Personal Hygiene & Aktivitas Harian: mandi 2x sehari, gunakan pakaian longgar dan nyaman, gunakan alas kaki yang tidak licin
10. Dukungan Keluarga: suami membantu pekerjaan berat dan keluarga mendukung ibu untuk istirahat cukup

## D. Konseling Persiapan Persalinan

1. Tujuan Konseling: memberikan pemahaman kepada ibu agar: Siap secara fisik dan mental, mengetahui tanda persalinan, mengurangi kecemasan, mencegah keterlambatan penanganan (3 terlambat)
2. Tanda-Tanda Persalinan: jelaskan dengan bahasa sederhana: Tanda pasti persalinan: mulas teratur dan semakin kuat, keluar lendir bercampur darah, air ketuban keluar. Sampaikan: "Kalau tanda ini muncul, ibu segera ke fasilitas kesehatan ya."
3. Tanda Bahaya Menjelang Persalinan
   Ibu harus segera ke fasilitas kesehatan jika: perdarahan banyak, nyeri hebat tidak hilang, gerakan janin berkurang, air ketuban hijau/berbau,
4. Rencana Tempat Persalinan
   Diskusikan dan pastikan: akan melahirkan di mana (Puskesmas/RS/BPM), Jarak dan akses menuju tempat, transportasi yang akan digunakan
5. Penolong Persalinan
   Pastikan ditolong tenaga kesehatan (bidan/dokter), hindari persalinan tanpa tenaga terlatih
6. Persiapan Biaya: apakah biaya persalinan dari tabungan persalinan, BPJS atau asuransi, tujuannya menghindari keterlambatan karena biaya
7. Persiapan Pendamping Persalinan: Suami atau keluarga yang akan memberi dukungan emosional
8. Persiapan Fisik Ibu
   a. Latihan, senam hamil, latihan pernapasan
   b. Nutrisi, makan bergizi seimbang dan minum yang cukup
   c. Istirahat, tidur cukup, hindari kelelahan
9. Persiapan Perlengkapan Persalinan terdiri dari: perlengkapan bayi terdiri dari baju bayi, popok, selimut. Perlengkapan ibu terdiri dari kain/pembalut, baju Ganti, serta perlengkapan mandi. Dan buku KIA & dokumen penting
10. Rencana Rujukan (Jika Darurat), ketahui fasilitas rujukan terdekat, siapkan kendaraan, nomor kontak tenaga Kesehatan, Jelaskan sacara sederhana: "Kalau ada kondisi darurat, ibu sudah tahu mau dirujuk ke mana."
11. Persiapan Psikologis, yakinkan ibu bahwa persalinan adalah proses alami, kurangi rasa takut, ajarkan teknik relaksasi
12. Peran Suami & Keluarga Adalah mendampingi ibu, membantu keputusan cepat, menyiapkan kebutuhan ibu

## E. Konseling Rencana Rujukan Ibu Hamil

1. Tujuan Konseling

   Memberikan pemahaman kepada ibu dan keluarga agar: siap menghadapi kondisi darurat, tidak terlambat mengambil Keputusan, mengetahui ke mana harus pergi saat terjadi komplikasi. Intinya: mencegah "3 Terlambat" (terlambat mengenali, memutuskan, dan mencapai fasilitas kesehatan)

2. Pengertian Rujukan

   Rujukan adalah pemindahan ibu ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap karena: adanya risiko atau komplikasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, sampaikan sederhana: "Kalau ada kondisi tertentu, ibu perlu dirujuk ke rumah sakit agar penanganannya lebih lengkap."

3. Kondisi yang Memerlukan Rujukan

   Jelaskan pada ibu tanda bahaya yang harus segera dirujuk:

   a. Saat kehamilan: perdarahan, Tekanan darah tinggi / preeklamsia, Anemia berat, Gerakan janin berkurang
   b. Menjelang persalinan: Air ketuban pecah dini, Letak bayi tidak normal, Kehamilan lewat waktu
   c. Saat persalinan: Persalinan lama, Perdarahan, Bayi tidak segera lahir

4. Komponen Rencana Rujukan (WAJIB dijelaskan)

   a. Tempat rujukan: tentukan RS tujuan
      Pilih yang paling dekat dan tersedia layanan
   b. Transportasi: kendaraan yang akan digunakan, alternatif jika darurat (mobil tetangga, ambulans)
   c. Biaya: BPJS / Asuransi atau tabungan persalinan
   d. Pendamping: Suami/keluarga yang siap mendampingi
   e. Kontak penting: Nomor bidan/dokter, nomor fasilitas kesehatan

5. Persiapan Dokumen: Buku KIA, KTP, Kartu BPJS, Hasil pemeriksaan
6. Persiapan Barang: pakaian ibu & bayi, Perlengkapan pribadi, disiapkan sejak trimester III
7. Peran Suami dan Keluarga: membantu mengambil keputusan cepat, menyiapkan transportasi dan biaya, mendampingi ibu saat rujukan
8. Edukasi Tindakan Saat Darurat: sampaikan langkah sederhana: Jangan panik, Segera hubungi bidan/faskes, segera ke tempat rujukan, bawa semua dokumen
9. Penekanan Penting (Kunci Konseling): Jangan menunggu kondisi parah, segera bertindak saat ada tanda bahaya, rencana harus disiapkan sejak awal

Aktivitas 1 — *Knows How*
Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Soal Kasus
Seorang perempuan usia 28 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan. Ibu mengeluh sering merasa lemas, pusing, dan nafsu makan berkurang. Ibu mengatakan jarang mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur dan lauk berprotein serta tidak rutin minum tablet tambah darah. Dalam aktivitas sehari-hari, ibu melakukan seluruh pekerjaan rumah tanpa bantuan sehingga sering merasa kelelahan. Ibu juga mengatakan belum memiliki rencana tempat persalinan, belum menyiapkan biaya, serta belum mengetahui tanda-tanda persalinan maupun tanda bahaya kehamilan. Hasil pemeriksaan: keadaan umum cukup, TD 100/70 mmHg, nadi 80 x/menit, suhu 36,8°C, pernapasan 22 x/menit, TFU sesuai usia kehamilan, DJJ 146 x/menit, konjungtiva tampak pucat.
Pertanyaan Diskusi
1. Apa saja masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Masalah apa yang berkaitan dengan aspek gizi pada ibu hamil dalam kasus ini?
4. Bagaimana pengaturan aktivitas yang tepat untuk ibu pada kasus tersebut?
5. Apa saja yang harus dikonselingkan terkait persiapan persalinan pada ibu tersebut?
6. Apa saja komponen penting dalam rencana rujukan yang harus dijelaskan kepada ibu?
7. Bagaimana pendekatan konseling ANC terpadu yang tepat pada kasus ini?
8. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga untuk mencegah komplikasi?

**Template Soal Osce Kebidanan**

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| 1 | No. Stasiun | 4 |
| 2 | Judul | Konseling ANC Terpadu |
| 3 | Kasus | Konseling ibu hamil dengan masalah gizi, aktivitas, dan persiapan persalinan serta rencana rujukan |
| 4 | Tujuan | Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam |
| 5 | Kompetensi | 1. KIE/konseling<br>2. Kolaborasi/rujukan<br>3. Perilaku profesional |
| 6 | Soal: Skenario dan tugas peserta ujian | SKENARIO KLINIK<br>Seorang perempuan usia 28 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan. Hasil anamnesis: ibu mengeluh sering lemas, pusing, nafsu makan berkurang, jarang mengonsumsi makanan bergizi, dan tidak rutin minum tablet Fe. Ibu juga melakukan aktivitas rumah tangga yang cukup berat tanpa bantuan. Ibu belum memiliki rencana tempat persalinan, belum menyiapkan biaya, serta belum mengetahui tanda bahaya kehamilan dan persalinan.. Hasil pemeriksaan: TD 100/70 mmHg, N 80 x/menit, S 36,8°C, RR 22 x/menit, TFU sesuai usia kehamilan, DJJ 146 x/menit, konjungtiva tampak pucat.<br>TUGAS<br>1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus.<br>2. Sampaikan masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh.<br>3. Lakukan konseling gizi pada ibu hamil.<br>4. Lakukan konseling aktivitas ibu hamil.<br>5. Lakukan konseling persiapan persalinan.<br>6. Lakukan konseling rencana rujukan. |
| 7 | Instruksi penguji | INSTRUKSI UMUM<br>1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:<br>a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta<br>b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka<br>3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian:<br>- Actual mark (0/1/2/3)<br>- Global rating (1/2/3/4)<br>4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan.<br>5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE.<br><br>INSTRUKSI KHUSUS<br>1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog.<br>2. Hal yang diharapkan dari peserta: {menggali pola makan ibu, menggali aktivitas ibu, menggali kesiapan persalinan, menggali rencana rujukan<br>3. Isi konseling yang diharapkan:<br>a. Gizi: {Menjelaskan gizi seimbang, pentingnya tablet Fe, contoh makanan bergizi<br>b. Aktivitas: {Aktivitas ringan diperbolehkan, hindari kelelahan, Istirahat cukup}<br>c. Persiapan persalinan:{Tanda persalinan, tempat persalinan, biaya dan pendamping}<br>d. Rujukan:{Tanda bahaya, tempat rujukan, transportasi dan biaya, peserta menggunakan komunikasi efektif dan empati, Penguji tidak diperbolehkan interupsi.<br>**INSTRUKSI TAMBAHAN** |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| | | 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya.<br>2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta. |
| 8 | Kebutuhan dan instruksi PS | Instruksi PS:<br>1. PS berperan sebagai ibu hamil trimester III.<br>2. PS tampak lemas, sedikit pucat, dan terlihat bingung tentang persiapan persalinan.<br>3. Jika peserta memberikan konseling dengan baik → PS kooperatif.<br>4. Jika ditanya tentang tablet Fe → PS mengatakan sering lupa minum. |
| 9 | Dialog PS | Peserta: Selamat pagi/siang, Bu.<br>PS: Pagi/siang, Bu.<br>Peserta: Apa keluhan ibu?<br>PS: Saya sering lemas dan pusing, Bu.<br>Peserta: Bagaimana pola makan ibu?<br>PS: Saya makan seadanya, jarang makan sayur.<br>Peserta: Apakah ibu minum tablet tambah darah?<br>PS: Dikasih, tapi saya sering lupa.<br>Peserta: Aktivitas ibu sehari-hari?<br>PS: Saya kerjakan semua pekerjaan rumah sendiri, Bu.<br>Peserta: Apakah sudah ada rencana persalinan?<br>PS: Belum ada, Bu.<br>Peserta: Apakah ibu tahu tanda bahaya kehamilan?<br>PS: Belum tahu, Bu.<br>Peserta: (memberikan konseling)<br>PS: Oh begitu ya, Bu.<br>Peserta: Apakah ibu bersedia mengikuti anjuran?<br>PS: Iya, Bu. |
| 10 | Kebutuhan manikin | • Tidak wajib (station konseling)<br>• Kursi dan meja konseling |

| No. | Komponen | Isi |
|---|---|---|
| 11 | Kebutuhan laboran | Peran laboran:<br>• Menyiapkan ruang konseling<br>• Menyiapkan lembar penilaian<br>• Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya |
| 12 | Kebutuhan alat | 1. Buku KIA<br>2. Leaflet edukasi<br>3. Pena<br>4. Lembar jawaban |
| 13 | Penulis | Bdn. Yanti, S.SiT.,M.Keb |
| 14 | Referensi | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan*. Kementerian Kesehatan RI.<br>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar kompetensi kerja bidang kebidanan*. Kementerian Kesehatan RI.<br>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal terpadu*. Kementerian Kesehatan RI.<br>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)*. Kementerian Kesehatan RI.<br>United Nations Children's Fund. (2019). *Maternal nutrition programming guidance*. UNICEF.<br>American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period*. ACOG. |

**RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN**

**Stase 4: Konseling ANC Terpadu**

**KOMPETENSI 1. KIE/Konseling**

| Komponen yang dinilai | Skoring | Skor |
|---|---|---|
| 1. Sapa dan salam | | |
| 2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana | | |
| 3. Menjelaskan gizi ibu hamil (makanan bergizi, tablet Fe, pola makan) | | |
| 4. Menjelaskan aktivitas ibu hamil (aktivitas aman dan istirahat) | | |
| 5. Menjelaskan persiapan persalinan (tanda persalinan, tempat, biaya, pendamping) | | |
| 6. Menjelaskan rencana rujukan (tanda bahaya, transportasi, tempat rujukan) | | |
| 7. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab dengan jelas | | |

**Skoring KOMPETENSI 1**

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6-7 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 7 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 7 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

**KOMPETENSI 2. Perilaku Profesional**

| Komponen yang dinilai | Skoring | Skor |
|---|---|---|
| 1. Melaksanakan secara sistematis | | |
| 2. Menjaga privasi dan kenyamanan pasien | | |
| 3. Komunikasi jelas, sopan, dan empatik | | |
| 4. Percaya diri dan tidak ragu-ragu | | |
| 5. Melibatkan ibu/keluarga dalam konseling | | |

**Skoring KOMPETENSI 4**

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

**TOTAL SKOR DAN KELULUSAN**

**TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + kopetensi 2 / 3**

*(dicatat di rubrik penilaian)*

**IV. Global Performance**

**Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian**

| TIDAK LULUS | BORDERLINE | LULUS | SUPERIOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), .....

.....

Penguji :.....

**Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada** Konseling ANC Terpadu (Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan)

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal |
|---|---|---|
| Metode penilaian | DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai mencakup komunikasi, kemampuan konseling, profesionalisme, serta keselamatan pasien. | Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan konseling ANC terpadu pada ibu hamil, meliputi aspek gizi, aktivitas, persiapan persalinan, dan rencana rujukan secara sistematis dan komprehensif |
| Tujuan penilaian | Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan konseling ANC secara menyeluruh, efektif, dan berpusat pada ibu (woman-centered care), serta mampu mencegah komplikasi melalui edukasi yang tepat. | Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan, tetapi dari kemampuan menyampaikan informasi, menggali kebutuhan ibu, serta memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi ibu. |
| Kasus klinik | Kasus dipilih dari situasi nyata yang sesuai dengan kompetensi bidan dalam pelayanan antenatal terpadu. | Seorang perempuan usia 28 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan. Ibu mengeluh lemas, jarang makan makanan bergizi, tidak rutin minum tablet Fe, melakukan aktivitas berat, serta belum memiliki rencana persalinan dan rujukan. |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal |
|---|---|---|
| Aktivitas mahasiswa yang diamati | Pada DOPS, mahasiswa diamati secara langsung saat melakukan **konseling ANC terpadu kepada ibu hamil dalam situasi klinik atau simulasi yang menyerupai kondisi nyata**. Penilaian difokuskan pada bagaimana mahasiswa melaksanakan proses konseling secara menyeluruh, bukan hanya pada penguasaan teori. | Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan komunikasi terapeutik, menggali informasi tentang pola makan, aktivitas, dan kesiapan persalinan, kemudian memberikan konseling meliputi: {Gizi ibu hamil (makanan bergizi, tablet Fe) , Aktivitas yang aman, Persiapan persalinan (tempat, biaya, tanda persalinan), Rencana rujukan (tanda bahaya, transportasi, fasilitas)<br>Mahasiswa juga memberikan kesempatan bertanya dan memastikan pemahaman ibu.<br>. |
| Aspek yang dinilai | Aspek yang dinilai meliputi kemampuan komunikasi, ketepatan isi konseling, sistematika penyampaian, empati, dan profesionalisme. | Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kondisi ibu (lemas, anemia ringan, aktivitas berat, belum siap persalinan) dengan kebutuhan konseling yang tepat dan komprehensif. |
| Fokus observasi pembimbing | Fokus observasi dalam DOPS adalah pada **performa nyata mahasiswa saat melakukan konseling ANC terpadu secara langsung kepada ibu hamil**. Penilaian tidak hanya melihat apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana mahasiswa melaksanakan proses konseling secara utuh dalam situasi klinik. | Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa:<br>• Menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis<br>• Menggunakan bahasa sederhana<br>• Melibatkan ibu dalam diskusi<br>• Memberikan edukasi yang sesuai kebutuhan<br>• Menunjukkan sikap empati dan profesional |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal |
|---|---|---|
| | | . |
| Umpan balik | Umpan balik diberikan segera setelah kegiatan. | Pembimbing menyampaikan kelebihan mahasiswa, misalnya komunikasi sudah baik, serta area yang perlu ditingkatkan seperti kelengkapan materi konseling atau keterlibatan pasien dalam diskusi. |
| Keputusan penilaian | Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan kemampuan melakukan konseling secara utuh, runtut, dan efektif dengan komunikasi yang jelas dan empatik. | Mahasiswa dinyatakan **kompeten** apabila mampu melakukan konseling ANC terpadu secara **runtut, lengkap, dan efektif**, meliputi aspek gizi, aktivitas, persiapan persalinan, dan rencana rujukan, dengan komunikasi yang jelas, empatik, serta mampu memastikan pemahaman ibu.<br>Mahasiswa dinyatakan **perlu supervisi** apabila sebagian langkah konseling sudah benar namun **belum lengkap atau belum sistematis**, misalnya hanya menjelaskan beberapa aspek (gizi atau aktivitas saja), atau masih memerlukan arahan dalam menyampaikan informasi dan melibatkan ibu dalam konseling.<br>Mahasiswa dinyatakan **remedial** apabila tidak mampu melakukan konseling secara adekuat, seperti **tidak menjelaskan aspek penting ANC terpadu**, memberikan informasi yang tidak tepat, tidak melibatkan ibu dalam proses konseling, atau tidak |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal |
|---|---|---|
| | | mampu mengarahkan ibu dalam persiapan persalinan dan rencana rujukan secara benar |
| Makna dalam OBE | DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran pada level *does* karena performanya diamati secara langsung saat melakukan konseling ANC terpadu. Penilaian ini tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan aspek gizi, aktivitas, persiapan persalinan, dan rencana rujukan dalam praktik nyata yang berpusat pada ibu.<br>Observasi langsung pada situasi klinik serta pemberian umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE) karena mampu menggambarkan secara nyata kompetensi mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif, komunikatif, dan profesional. | Pada konseling ANC terpadu, hal ini berarti mahasiswa tidak hanya memahami konsep tentang gizi, aktivitas, persiapan persalinan, dan rencana rujukan, tetapi mampu mengintegrasikan seluruh aspek tersebut dalam bentuk konseling yang utuh dan aplikatif kepada ibu hamil.<br>Mahasiswa diharapkan mampu: Mengkaji kebutuhan ibu secara menyeluruh , Menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan sesuai kondisi ibu , Menggunakan komunikasi yang empatik dan mudah dipahami , Melibatkan ibu dalam proses pengambilan Keputusan, Memberikan edukasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari<br>Dengan demikian, capaian pembelajaran tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi mencakup keterampilan komunikasi, sikap profesional, dan kemampuan klinis dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif. |

**Portofolio**

**Bukti yang dikumpulkan**

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat

● Refleksi patient safety
● Feedback CI/dosen

**Catatan untuk penulis:**

● Bukan sekali ujian
● Bukti konsistensi kompetensi

**Tabel. Portofolio pada Konseling ANC Terpadu: Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan**

| **Komponen** | **Deskripsi** | **Contoh pada Kasus Konseling ANC Terpadu** |
|---|---|---|
| **Hakikat portofolio** | Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu. | Pada konseling ANC terpadu, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian ibu hamil, memberikan konseling gizi, aktivitas, persiapan persalinan, dan rencana rujukan secara komprehensif, serta meningkatkan kemampuan berdasarkan umpan balik. |
| **Tujuan portofolio** | Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik. | Mahasiswa tidak hanya menunjukkan pernah melakukan konseling ANC, tetapi juga menunjukkan perkembangan kemampuan komunikasi, kelengkapan materi, dan pendekatan kepada ibu setelah mendapat masukan dari dosen atau CI. |
| **OSCE dan DOPS** | OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik. | OSCE memuat kemampuan mahasiswa dalam melakukan konseling terstruktur, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan konseling ANC terpadu |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Konseling ANC Terpadu |
|---|---|---|
| | | kepada ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan. |
| **Catatan kasus singkat** | Catatan kasus berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani, data penting, masalah, tindakan, dan hasil. | Mahasiswa menuliskan kasus ibu hamil 32 minggu dengan keluhan lemas, pola makan kurang baik, aktivitas berat, dan belum memiliki rencana persalinan, serta tindakan konseling yang diberikan. |
| **Refleksi patient safety** | Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko dan menyusun pencegahan. | Mahasiswa merefleksikan pentingnya edukasi gizi untuk mencegah anemia, pengaturan aktivitas untuk mencegah kelelahan, serta perencanaan persalinan dan rujukan untuk mencegah keterlambatan penanganan. |
| **Feedback CI/dosen** | Umpan balik dari CI/dosen menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. | CI menilai mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan konseling gizi, tetapi perlu meningkatkan kelengkapan konseling pada aspek rujukan dan keterlibatan keluarga. |
| **Karakteristik penilaian** | Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang menilai konsistensi performa mahasiswa. | Mahasiswa dinilai dari beberapa praktik konseling ANC, bukan hanya satu kasus, untuk melihat konsistensi dalam memberikan edukasi yang komprehensif. |
| **Bukti konsistensi kompetensi** | Portofolio menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan mutu performa dalam berbagai kesempatan. | Dari hasil OSCE, DOPS, dan catatan kasus, mahasiswa menunjukkan konsistensi dalam melakukan konseling |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Konseling ANC Terpadu |
|---|---|---|
| | | ANC terpadu secara sistematis dan komunikatif. |
| **Makna dalam OBE** | Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik capaian pembelajaran melalui performa nyata yang berulang dan berkembang. | Pada konseling ANC terpadu, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu memberikan edukasi yang komprehensif, komunikatif, dan berpusat pada ibu dalam praktik nyata. |

**Tabel. Case Report pada Konseling ANC Terpadu: Gizi, aktivitas, persiapan persalinan, rencana rujukan**

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Konseling ANC Terpadu |
|---|---|---|
| **Hakikat case report** | Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis. | Mahasiswa menyusun laporan tentang seorang ibu hamil trimester III yang mengalami keluhan lemas, pola makan tidak adekuat, aktivitas berat, serta belum memiliki rencana persalinan dan rujukan. |
| **Tujuan** | Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan. | Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah gizi, aktivitas, kesiapan persalinan, serta tindakan konseling yang diberikan dan perubahan pemahaman ibu setelah edukasi. |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Konseling ANC Terpadu |
|---|---|---|
| **Isi laporan** | Isi case report mencakup identitas pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus. | Mahasiswa menuliskan keluhan lemas, konjungtiva pucat, pola makan kurang, aktivitas berat, belum ada rencana persalinan; analisis anemia ringan dan kurangnya kesiapan persalinan; tindakan berupa konseling ANC terpadu. |
| **Fokus penilaian** | Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, ketepatan tindakan, dan evaluasi hasil. | Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan ibu dengan masalah gizi, aktivitas, serta kurangnya persiapan persalinan, dan memberikan konseling yang tepat. |
| **Nilai edukatif** | Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, dokumentasi, dan refleksi praktik klinik. | Dari kasus ini, mahasiswa belajar pentingnya konseling ANC terpadu untuk mencegah anemia, kelelahan, serta keterlambatan dalam persiapan persalinan dan rujukan. |
| **Makna dalam OBE** | Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab. | Mahasiswa menunjukkan bahwa tidak hanya memahami teori ANC terpadu, tetapi mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berpusat pada ibu. |

**Tabel. Refleksi Patient Safety pada Konseling ANC Terpadu: Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan**

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Konseling ANC Terpadu |
|---|---|---|
| **Hakikat refleksi patient safety** | Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan. | Pada konseling ANC terpadu, mahasiswa merefleksikan bahwa kurangnya edukasi tentang gizi, aktivitas, persiapan persalinan, dan rujukan dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan janin. |
| **Tujuan** | Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap asuhan kebidanan. | Mahasiswa memahami bahwa kurangnya konseling dapat menyebabkan anemia, kelelahan, keterlambatan persalinan, dan keterlambatan rujukan yang berisiko bagi ibu dan bayi. |
| **Fokus refleksi** | Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran dari pengalaman klinik. | Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, aktivitas berlebihan, tidak adanya persiapan persalinan, dan tidak adanya rencana rujukan. |
| **Risiko yang diidentifikasi** | Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien. | Risiko yang diidentifikasi meliputi anemia, kelelahan ibu, persalinan tanpa persiapan, keterlambatan penanganan komplikasi, dan tidak adanya kesiapan rujukan saat darurat. |
| **Tindakan pencegahan** | Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien. | Mahasiswa menuliskan pentingnya konseling gizi seimbang dan tablet Fe, pengaturan aktivitas dan istirahat, edukasi tanda persalinan dan bahaya, serta |

| Komponen | Deskripsi | Contoh pada Kasus Konseling ANC Terpadu |
|---|---|---|
| | | perencanaan rujukan (tempat, transportasi, biaya). |
| **Pembelajaran mahasiswa** | Refleksi menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan dampaknya pada praktik selanjutnya. | Mahasiswa menyadari bahwa konseling ANC terpadu sangat penting untuk mencegah komplikasi dan harus dilakukan secara lengkap, sistematis, dan komunikatif pada setiap kunjungan. |
| **Makna dalam OBE** | Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis terhadap keselamatan pasien. | Mahasiswa menunjukkan bahwa tidak hanya melakukan konseling, tetapi mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara berkelanjutan melalui edukasi yang komprehensif dan berpusat pada ibu. |

## F. Ringkasan

Konseling ANC terpadu merupakan bagian penting dalam pelayanan antenatal yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan janin melalui edukasi yang komprehensif, sistematis, dan berpusat pada ibu. Konseling tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup integrasi gizi, aktivitas, persiapan persalinan, dan rencana rujukan sebagai upaya pencegahan komplikasi serta peningkatan kesiapan ibu menghadapi persalinan. Untuk konseling gizi, ibu hamil dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, serta rutin mengonsumsi tablet tambah darah (Fe) untuk mencegah anemia. Untuk konseling aktivitas, ibu tetap diperbolehkan melakukan aktivitas ringan hingga sedang, namun perlu menghindari kelelahan dan memastikan istirahat yang cukup. Serta juga bisa melakukan senam ibu hamil atau yoga ibu hamil.

Pada persiapan persalinan, konseling yang diberikan meliputi pemahaman tanda-tanda persalinan, penentuan tempat persalinan, kesiapan biaya, serta dukungan dari keluarga atau pendamping. Sementara itu, rencana rujukan menjadi bagian penting untuk mengantisipasi kondisi darurat dengan menyiapkan fasilitas rujukan, transportasi, biaya, dan pengambilan keputusan yang cepat. Dalam memberikan asuhan kebidanan, bidan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan ibu melalui pengkajian yang tepat, kemudian memberikan konseling dengan bahasa sederhana, empatik, dan melibatkan ibu serta keluarga. Edukasi yang diberikan harus aplikatif sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

WHO dan Kementerian Kesehatan menekankan bahwa pelayanan antenatal yang berkualitas harus bersifat komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, konseling ANC terpadu menjadi kunci dalam mencegah masalah seperti anemia, kelelahan, keterlambatan persalinan, serta keterlambatan rujukan yang dapat meningkatkan risiko komplikasi.

**Alur Asuhan Singkat**

Ibu hamil datang ANC lakukan pengkajian kondisi ibu identifikasi masalah (gizi, aktivitas, kesiapan persalinan, rujukan) berikan konseling terpadu (gizi, aktivitas, persiapan persalinan, rujukan) libatkan ibu dan keluarga pastikan pemahaman ibu dokumentasi dan tindak lanjut

**Tabel Red Flags & Eskalasi**

Konseling ANC Terpadu (Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan)

| **Red flags** | **Makna klinis** | **Tindakan eskalasi** |
|---|---|---|
| Ibu tampak pucat, lemas, pusing, dan tidak rutin konsumsi tablet Fe | Mengarah pada anemia yang dapat berdampak pada ibu dan janin | Edukasi segera tentang gizi dan tablet Fe, evaluasi Hb bila memungkinkan, kolaborasi/rujukan jika anemia berat |
| Ibu tidak memahami pola makan bergizi selama kehamilan | Risiko kekurangan nutrisi dan gangguan pertumbuhan janin | Berikan konseling gizi seimbang, contoh menu harian, dan pemantauan rutin |
| Ibu melakukan aktivitas berat tanpa istirahat cukup | Risiko kelelahan, kontraksi dini, atau gangguan kesehatan ibu | Edukasi pembatasan aktivitas, anjurkan istirahat cukup, libatkan keluarga |
| Ibu tidak mengetahui tanda bahaya kehamilan | Risiko keterlambatan mengenali komplikasi | Edukasi tanda bahaya secara jelas dan sederhana, pastikan ibu memahami |
| Ibu belum memiliki rencana tempat persalinan | Risiko keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan saat persalinan | Diskusikan dan tentukan tempat persalinan yang aman |
| Ibu belum menyiapkan biaya persalinan | Risiko keterlambatan karena kendala finansial | Edukasi pentingnya persiapan biaya atau penggunaan BPJS |
| Ibu tidak memiliki rencana transportasi saat darurat | Risiko keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan | Rencanakan transportasi dan alternatif kendaraan |
| Ibu tidak mengetahui atau belum menentukan tempat rujukan | Risiko keterlambatan penanganan saat komplikasi | Edukasi dan tentukan fasilitas rujukan yang sesuai |
| Ibu dan keluarga tidak terlibat dalam perencanaan persalinan | Risiko pengambilan keputusan yang lambat | Libatkan keluarga dalam konseling dan pengambilan keputusan |
| Ibu menunjukkan kecemasan berlebihan | Dapat mempengaruhi kesiapan mental ibu | Berikan dukungan emosional, edukasi, dan reassurance |

| Red flags | Makna klinis | Tindakan eskalasi |
|---|---|---|
| atau ketakutan terhadap persalinan | | |

**Form Checklist "Saya sudah bisa…"**

**Bab: Konseling ANC Terpadu (Gizi, Aktivitas, Persiapan Persalinan, dan Rencana Rujukan)**

**Nama Mahasiswa:** _____

**NIM:** _____

**Tanggal:** _____

**Tempat Praktik / Skill Lab:** _____

**Petunjuk:** Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

| No | Pernyataan | Sudah | Belum | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saya sudah bisa menjelaskan pengertian konseling ANC terpadu | ☐ | ☐ | _____ |
| 2 | Saya sudah bisa menjelaskan tujuan konseling pada ibu hamil | ☐ | ☐ | _____ |
| 3 | Saya sudah bisa melakukan anamnesis terkait gizi, aktivitas, dan kesiapan persalinan | ☐ | ☐ | _____ |
| 4 | Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah gizi pada ibu hamil | ☐ | ☐ | _____ |
| 5 | Saya sudah bisa menjelaskan kebutuhan gizi ibu hamil dan pentingnya tablet Fe | ☐ | ☐ | _____ |
| 6 | Saya sudah bisa memberikan contoh makanan bergizi sesuai kondisi ibu | ☐ | ☐ | _____ |
| 7 | Saya sudah bisa menjelaskan aktivitas yang aman dan yang harus dihindari selama kehamilan | ☐ | ☐ | _____ |
| 8 | Saya sudah bisa menganjurkan istirahat yang cukup pada ibu hamil | ☐ | ☐ | _____ |
| 9 | Saya sudah bisa menjelaskan tanda-tanda persalinan kepada ibu | ☐ | ☐ | _____ |
| 10 | Saya sudah bisa membantu ibu merencanakan tempat dan pendamping persalinan | ☐ | ☐ | _____ |
| 11 | Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya persiapan biaya persalinan | ☐ | ☐ | _____ |
| 12 | Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya kehamilan dan persalinan | ☐ | ☐ | _____ |

| No | Pernyataan | Sudah | Belum | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Saya sudah bisa membantu ibu menyusun rencana rujukan (tempat, transportasi, biaya) | ☐ | ☐ | _____ |
| 14 | Saya sudah bisa melakukan konseling dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami | ☐ | ☐ | _____ |
| 15 | Saya sudah bisa melibatkan ibu dan keluarga dalam proses konseling | ☐ | ☐ | _____ |
| 16 | Saya sudah bisa memberikan kesempatan bertanya dan menjawab dengan jelas | ☐ | ☐ | _____ |
| 17 | Saya sudah bisa memastikan ibu memahami informasi yang diberikan | ☐ | ☐ | _____ |
| 18 | Saya sudah bisa menutup konseling dengan rangkuman dan anjuran yang tepat | ☐ | ☐ | _____ |
| 19 | Saya sudah bisa menjaga sikap profesional, empati, dan privasi pasien | ☐ | ☐ | _____ |

**Refleksi singkat mahasiswa:**

.....

.....

.....

## G. Daftar Pustaka


American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period*. ACOG.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal terpadu*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar kompetensi kerja bidang kebidanan*. Kementerian Kesehatan RI.

Khotimah, K., & Sacharum, N. (2025). Effectiveness of nutritional counseling on improving dietary compliance among pregnant women. *Professional Health Journal, 7*(1), 394–401. https://doi.org/10.54832/phj.v7i1.1296

Prasetyo, A. (2025). Nutritional and health factors influencing first antenatal visit in Indonesia. *Frontiers in Public Health*.

Putri, N., et al. (2024). The effect of nutritional counseling on knowledge and compliance with Fe tablet consumption among pregnant women. *Media Gizi Indonesia*

World Health Organization. (2020). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO Press.

# PROFIL PENULIS



**Baiq Iin Rumintang, S.ST., M.Keb.** Lahir di Mataram, 31 Januari 1980. Jenjang pendidikan kebidanan penulis diawali di D III Kebidanan AKBID Depkes Mataram, lulus tahun 2001. Setelah lulus, penulis bekerja sebagai pegawai kontrak di RSUD Provinsi NTB dan bertugas di ruang bersalin. Pada akhir tahun 2002, penulis diterima menjadi ASN di Poltekkes Kemenkes Mataram sehingga memulai perjalanan di dunia pendidikan, menjadi dosen tetap Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram hingga saat ini. Penulis melanjutkan pendidikan DIV Kebidanan Bidan Pendidik di Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2008. Kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikan Magister Kebidanan di Universitas Padjajaran Bandung, lulus tahun 2013. Penulis aktif dalam Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Mata kuliah yang diampu adalah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Nifas dan menyusui, Gizi dalam Kesehatan Reproduksi dan Pengembangan Kepribadian. Penulis aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, penulis buku, publikasi karya ilmiah dan narasumber. Penulis juga merupakan Konselor Menyusui dan Konselor Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang bergabung dalam organisasi sukarelawan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), menjabat sebagai Ketua AIMI Daerah NTB Periode 2019-2024 dan 2024-2029. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: baiqiinrumintang@gmail.com

Motto: ·

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat"

"Jika Kita Membantu Seorang Ibu untuk Menyusui pada Hakikatnya Kita Sudah Membantu Seluruh Keluarga"



**Husnul Khatimah** Penulis lahir di Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1991. Ketertarikan penulis dengan dunia kesehatan dimulai sejak bersekolah di SPK Polri Bhayangkara Makassar di Tahun 2005. Di tahun 2012 Penulis menamatkan pendidikan DIV Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia peminatan kesehatan Masyarakat di tahun 2017. Setelah menyelesaikan program magister penulis mulai aktif melakukan penelitian. Saat ini penulis berkerja sebagai dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Kegemaran membaca juga menjadi motivasi penulis untuk menghasilkan karya baik berupa jurnal maupun buku sebagai bentuk kontribusi pada dunia pendidikan.

Email Penulis: husnul.khatimah@poltekkesjakarta1.ac.id

# PROFIL PENULIS



**Bdn. Hasanalita, S.SiT., M.Keb.** Lahir di Serang, 28 Februari 1985. Saat ini penulis bekerja di Universitas Negeri Padang. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Prodi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Bandung lulus tahun 2007, Prodi D IV Bidan Pendidik STIKes Ranah Minang lulus tahun 2011, tahun 2019 lulus S2 Ilmu Kebidanan Universitas Andalas, tahun 2025 lulus Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Baiturahmah. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 hingga tahun 2020 di STIKes Ranah Minang, mengampu mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, asuhan neonatus bayi dan balita, promosi kesehatan, anatomi fisiologi, Promosi kesehatan, asuhan kebidanan III (nifas), Mikrobiologi, organisasi manajemen, ilmu kesehatan masyarakat. Universitas Nurul Hasanah sejak tahun 2021 hingga Mei 2024, mengampu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan nifas dan menyusui, keterampilan dasar praktik klinik kebidanan I dan II, konsep kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis : Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komunitas, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas Dan Menyusui Bagi Mahasiswa Diploma Tiga, Kesehatan Reproduksi Perspektif Klinis Dan Sosial, Buku Ajar Pemeriksaan Fisik Ibu Dan Bayi, Buku Latihan Soal UKOM 2025, Buku Ajar Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Buku Komplementer Dalam Kehamilan, Buku Kesehatan Reproduksi, Buku Perawatan Ibu Dan Bayi, Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, Dan BBL, Asuhan Kebidanan Kehamilan. Dan telah melakukan Publikasi penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui email: hasanalita.ana@gmail.com

# PROFIL PENULIS



**Bdn.Nurulicha, S.ST., M.Keb.** Penulis lahir di Indramayu, Tanggal 26 Februari 1984. Menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Cirebon tahun 2005, D IV Kebidanan Universitas Padjadajaran tahun 2007 dan S2 Kebidanan Universitas 'Padjadajaran Bandung tahun 2014, menyelesaikan pendidikan profesi bidan dan kompeten tahun 2026. Penulis saat ini aktif sebagai seorang dosen serta sebagai Sekretaris Prodi Profesi Bidan sejak tahun 2022 dan tahun 2024 – sekarang penulis menjabat sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta, penulis mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer, Askeb Neonatus bayi dan balita dan pra sekolah, Asuhan Kebidanan Kehamilan Normal, sebagai pembimbing dan penguji institusi praktik klinik kebidanan profesi. Selain mengajar juga membimbing Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan. Aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, tim dosen bimbel Optimal.

Pengalaman penulis dalam membuat buku Evidence Based Soal Kasus Kebidanan Komunitas, buku Latihan soal UKOM kebidanan, buku bunga rampai landasan ilmiah praktik kebidanan, buku ajar dan penyusunan SOP yang ber ISBN dan HKI. Selain itu, penulis pernah memperoleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Penulis juga aktif sebagai editor berbagai buku kebidanan serta terlibat dalam penyuntingan naskah ilmiah dan buku ajar, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kualitas publikasi akademik di bidang kebidanan. Selain berkiprah di bidang akademik, penulis juga aktif sebagai praktisi dan narasumber pada kegiatan Kelas Ibu Hamil, dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak, persiapan persalinan, perawatan bayi baru lahir, menyusui, serta penerapan pelayanan kebidanan berbasis bukti di masyarakat. penulis dapat dihubungi melalui email: nnurulicha26@gmail.com.



**Bdn.Yanti, S.SiT., M.Keb.** Lahir di Jambi, 07 Mei 1977. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Kesdam II/SWJ Cabang Jambi tahun 1996. Penulis melanjutkan Diploma III Kebidanan Akademi Kebidanan Poltekkes Jambi tahun 2003. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2006. Dan Lulus Magister Kebidanan Universitas Andalas Padang tahun 2015.

Saat ini penulis sebagai Dosen dI Prodi Profesi Kebidanan dan aktif mengajar di Universitas Senior Medan.

Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang Kebidanan.

Email: afriwanyanti@gmail.com

Motto "Teruslah Belajar Tak Perduli Berapa Usiamu, Orang Sukses adalah Orang Yang Selalu Ingin Belajar "

**Sinopsis**

Buku Ajar Pemeriksaan Antenatal Terpadu: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Temuan membahas konsep dan keterampilan dasar dalam memberikan pelayanan antenatal yang sistematis, menyeluruh, dan berpusat pada ibu hamil. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami pentingnya pemeriksaan antenatal sebagai upaya pemantauan kehamilan, deteksi dini risiko, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kesehatan ibu dan janin.

Materi dalam buku ini mencakup konsep pemeriksaan antenatal terpadu, teknik anamnesis pada ibu hamil, pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan obstetri, penilaian status gizi, pemantauan pertumbuhan janin, pengenalan tanda bahaya kehamilan, serta interpretasi hasil temuan pemeriksaan. Buku ini juga menekankan pentingnya komunikasi efektif, dokumentasi, edukasi kesehatan, konseling, kolaborasi, dan rujukan dalam pelayanan antenatal.

Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa kebidanan dalam mengembangkan kemampuan klinis, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat dalam pemeriksaan antenatal. Buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi pendamping bagi dosen, bidan, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang aman, profesional, dan berkualitas.

Buku Ajar Pemeriksaan Antenatal Terpadu: Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, dan Interpretasi Temuan membahas konsep dan keterampilan dasar dalam memberikan pelayanan antenatal yang sistematis, menyeluruh, dan berpusat pada ibu hamil. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami pentingnya pemeriksaan antenatal sebagai upaya pemantauan kehamilan, deteksi dini risiko, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kesehatan ibu dan janin.

Materi dalam buku ini mencakup konsep pemeriksaan antenatal terpadu, teknik anamnesis pada ibu hamil, pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan obstetri, penilaian status gizi, pemantauan pertumbuhan janin, pengenalan tanda bahaya kehamilan, serta interpretasi hasil temuan pemeriksaan. Buku ini juga menekankan pentingnya komunikasi efektif, dokumentasi, edukasi kesehatan, konseling, kolaborasi, dan rujukan dalam pelayanan antenatal.

Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa kebidanan dalam mengembangkan kemampuan klinis, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat dalam pemeriksaan antenatal. Buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi pendamping bagi dosen, bidan, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang aman, profesional, dan berkualitas.

Penerbit:
**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-92-3 (PDF)
9 786347 756923